



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 11

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 25 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Varón de 65 años, sin antecedentes de interés, que consulta por tos, dolor torácico, fiebre, sudoración nocturna y disnea. En la radiografía de tórax se observa un derrame pleural unilateral izquierdo, por lo que se realiza una TC torácica que confirma el derrame pleural y donde además se observa un engrosamiento pleural y micronódulos subpleurales en el lóbulo superior izquierdo. Ante este hallazgo se decide realizar una toroscopia con biopsia pleural, cuya histología se muestra en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión pleural?:

1. Infiltración por adenocarcinoma.
2. Inflamación aguda con abscesificación.
3. Inflamación granulomatosa.
4. Mesotelioma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En este caso clínico nos presentan un paciente que presenta un cuadro de fiebre, tos, sudoración nocturna y dolor torácico asociado a un derrame pleural y nodulos pulmonares en lóbulos superiores, por lo que una de las primeras posibilidades que nos viene a la mente es una tuberculosis. La imagen histológica muestra granulomas en la primera imagen y en la segunda se ven células gigantes multinucleadas por lo que había alguna duda. Por tanto la respuesta tiene que ser tuberculosis, incluso a pesar de que los granulomas no sean necrotizantes, que podría ser el único detalle que nos hiciera dudar, pero no siempre se tiene que ver la necrosis caseosa.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Varón de 20 años, de constitución longilínea, que presenta desde hace unos 15 meses disnea de grandes esfuerzos que progresa a pequeños esfuerzos, con palpitaciones y dolor precordial. Fallece de forma súbita subiendo escaleras. En la necropsia se encuentra un vaso con la imagen de la figura. De las siguientes ¿cuál es la enfermedad más probable?:

1. Embolia pulmonar.
2. Traumatismo torácico con afectación de la aorta y el corazón.
3. Necrosis quística de la media y síndrome de Marfan.
4. Síndrome dislipémico familiar con grave aterosclerosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Paciente con datos clínicos muy orientativos a síndrome de Marfan, que presenta dolor torácico y

muerte súbita. Imagen que complementa poco a la clínica (que da la respuesta correcta) en la que de cualquier forma se observa una disección de la pared arterial (doble luz). Este tipo de pacientes se encuentran en mayor riesgo de desarrollo de aneurismas aórticos que pueden complicarse en forma de disección, siendo el hallazgo característico la necrosis quística de la capa media.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Mujer de 81 años que consulta por ictericia, dolor epigástrico, astenia y anorexia. La TC abdominal muestra en la cabeza del páncreas una lesión sólida, mal delimitada, de 24 x 24 mm, que contacta focalmente con la vena mesentérica superior y comporta dilatación de la vía biliar. No se observa un claro contacto con otras estructuras vasculares principales. Con la sospecha de proceso neoplasia se indica la intervención quirúrgica. Se muestra una imagen macroscópica y una microscópica de la lesión pancreática. El estudio inmunohistoquímico realizado en la pieza de resección muestra positividad para citoqueratina 7 y negatividad para sinaptofisina, tripsina, CK20 y CDX2. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión pancreática?:

1. Adenocarcinoma ductal.
2. Cistadenoma seroso.
3. Neoplasia mucinosa quística.
4. Pancreatitis autoinmune asociada a enfermedad por IgG4.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta vinculada a imagen anatomopatológica, sencilla por tratarse de un tema muy preguntado. Observamos una masa/neoplasia en la cabeza del páncreas en una paciente anciana que debuta con dolor, pérdida de peso e ictericia obstructiva. Simplemente viendo que es una imagen sólida podemos descartar las opciones 2 y 3, puesto que son neoplasias con componente quístico. Por otro lado, la histología e inmunohistoquímica (ni la presentación clínica en una paciente octogenaria) no corresponden a una pancreatitis autoinmune. Vemos en la AP microscópica que la neoplasia forma glándulas y que existe una abundante reacción estromal, típica del adenocarcinoma pancreático, que es la neoplasia más frecuente del páncreas (y la de peor pronóstico).

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Se realizó una biopsia hepática en una paciente de 37 años con obesidad y alteración de las transaminasas (figura 2014) que demostró una intensa esteatosis que afectaba al 70% de los hepatocitos. A los 7 años, tras ser diagnosticada de esclerosis múltiple y ganar peso, se repitió la biopsia (figura 2021). ¿Cuál de las siguientes

afirmaciones describe mejor la evolución?:

1. La esteatosis es menos intensa en la segunda biopsia, lo que es signo de buen pronóstico.
2. En la segunda biopsia no hay datos de inflamación ni degeneración balonizante, lo que es signo de buen pronóstico.
3. La segunda biopsia muestra una situación estable.
4. La presencia de fibrosis en puentes demuestra la progresión de la enfermedad.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta fácil sobre el hígado graso. Nos presentan una primera imagen donde se ve una esteatosis macrovesicular con grandes gotas de grasa en el interior de los hepatocitos y balonización, todo ello compatible con hígado graso. Con el paso del tiempo vemos que (segunda foto) han aparecido tractos fibrosos y están empezando a delimitarse nódulos de regeneración. Esto sugiere que la enfermedad ha progresado y estamos ya ante una cirrosis. El hecho de que la paciente haya ganado peso nos ayuda también a acertar la pregunta.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Mujer de 90 años de edad que presenta desde hace un mes y medio la lesión de la imagen. La lesión ha crecido rápidamente, sangra con facilidad y le ocasiona ligero dolor. De entre las siguientes opciones ¿cuál es la más probable?:

1. Carcinoma de células escamosas cutáneo invasivo.
2. Carcinoma basocelular esclerodermiforme.
3. Sarcoma de Kaposi.
4. Lupus vulgar.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Nos preguntan por un paciente de edad avanzada con una lesión cutánea de aspecto tumoral, queratósica, que refiere sangra con facilidad y le produce dolor. Aunque clínicamente no nos genera muchas dudas con un epiteloma basocelular, el tiempo de evolución tan corto ya nos confirmaría que debe tratarse de un carcinoma escamoso. El sarcoma de Kaposi y el lupus vulgar clínicamente son muy diferentes.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Mujer de 70 años que consulta por lesiones cutáneas de 1 año de evolución, sin otra sintomatología asociada. Niega antecedentes personales de interés. En la exploración presenta 20 placas eritematosas finamente descamativas y discretamente atróficas, de tamaños de 4 a 10 cm en glúteos, ambas axilas y mamas, sin otros hallazgos. La anatomía patológica muestra un infiltrado en dermis superficial de linfocitos atípicos en banda, con

marcado epidermotropismo y formación de microabscesos intraepidérmicos. La analítica sanguínea completa fue normal. De los siguientes ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Linfoma de Hodgkin cutáneo.
2. Síndrome de Sézary.
3. Linfoma no Hodgkin cutáneo tipo T.
4. Psoriasis pustulosa.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos preguntan por una paciente con lesiones que describen como placas finas descamativas, en cuya histología se pueden observar linfocitos atípicos, epidermotropismo (¡palabra clave!) y microabscesos intraepidérmicos (de Pautrier). No son placas eritematodescamativas ni con pústulas para pensar en psoriasis (aunque la presencia de linfocitos atípicos en la histología ya nos harían descartarla como opción). Nos falta una eritrodermia y afectación en sangre para pensar en síndrome de Sézary. Estamos ante una micosis fungoide, un linfoma no Hodgkin de linfocitos T.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Niño de 23 meses de edad que ingresa por rectorragias de repetición y anemia (hemoglobina 10,0 g/dl, hematocrito 27,9 %). Se realiza estudio ecográfico abdominal sin hallazgos. Se muestra en la imagen la gammagrafía con pertecnetato-99mTc. De los siguientes, el diagnóstico más probable es:

1. Punto de sangrado de origen gástrico.
2. Divertículo de Meckel revestido de mucosa gástrica ectópica.
3. Punto de sangrado de origen genitourinario.
4. Gammagrafía normal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Imagen inédita en el MIR que muestra una captación anómala de tecnecio 99 en la línea media, en zona periumbilical, sugerente de captación ectópica, y por tanto, de divertículo de Meckel. Aún así, el caso clínico acompañante muestra un lactante con rectorragia y anemia; con esta edad y clínica lo primero a descartar es una malformación gastrointestinal como un divertículo de Meckel. Por tanto, casi sin ver la imagen, podemos contestar la opción 2, correcta en este caso.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Varón de 86 años con antecedentes de adenocarcinoma de próstata tratado con braquiterapia e HTA bien controlada que acude a urgencias por la aparición de edemas en MMII en las dos últimas semanas y disnea progresiva hasta hacerse de reposo. Se realiza ecocardiograma transtorácico observando una

hipertrofia leve concéntrica del VI con función sistólica conservada. Se muestra la gammagrafía con pirofosfatos-99mTc. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Infarto agudo de miocardio.
2. Gammagrafía cardiaca normal.
3. Amiloidosis cardiaca mediada por transtiretina.
4. Derrame pericárdico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta relativamente fácil. Anciano con insuficiencia cardiaca con FEVI preservada e hipertrofia leve de VI. Entre las distintas causas que pueden explicarlo se debe tener siempre en mente la miocardiopatía hipertensiva (causa más frecuente de IC con FEVI preservada en el anciano), e igualmente causas menos frecuentes como son las cardiopatías infiltrativas. En este perfil de paciente anciano, se debe pensar en la posibilidad de una amiloidosis senil por depósito de transtiretina. Desde el punto de vista ecocardiográfico se comporta con FEVI generalmente preservada (hasta los estadios finales en los que decrece), y engrosamiento miocárdico, tanto a nivel ventricular como auricular. El miocardio aparece con un aspecto hiperrefringente, granulado por el depósito de amiloide. Lo más complejo de esta pregunta es la prueba de imagen que se adjunta: gammagrafía con pirofosfatos, con gran captación miocárdica. La gammagrafía con compuestos fosfonados se emplea a la hora de hacer el diagnóstico diferencial entre amiloidosis por transtiretina (gran captación de fosfatos) frente a otros tipos de amiloide, fundamentalmente la amiloidosis AL, que no muestra captación, o es leve.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Mujer de 85 años, en tratamiento con rosuvastatina por dislipemia, que en las últimas 4 semanas presenta fiebre diaria (38-38,5°C), bien tolerada, sin escalofríos y sin sudoración nocturna, y pérdida de 3 kg de peso. En la exploración física destaca engrosamiento de la arteria temporal izquierda. Análisis: PCR 12 mg/dl, hemoglobina 9,5 g/dl. Radiografía de tórax normal. El resultado de la PET/TC se muestra en la figura. En este contexto ¿cuál es la respuesta correcta?:

1. La fiebre o febrícula es un síntoma presente en menos del 10 % de los pacientes.
2. Cuando se diagnostica la enfermedad, los hallazgos radiológicos (como los observados en esta PET/TC) están presentes en un 50-70% de los pacientes.
3. Atendiendo a los hallazgos de la PET/TC en esta paciente tiene indicación de tratamiento inmediato con glucocorticoides (20 mg/día) y tocilizumab.
4. La PET/TC es la técnica más específica para establecer el diagnóstico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan una anciana con fiebre y pérdida de peso de un mes de duración. En analítica PCR elevada y anemia. Como pista nos indican que tiene la arteria temporal indurada. Todo ello nos sugiere una arteritis de células gigantes (ACG). La imagen corresponde a un PET-TAC con captación de aorta (vasculitis). Recordar que además de la afectación craneal clásica de la ACG, al menos la mitad de los pacientes (respuesta 2 correcta) tienen afectación de grandes vasos (aorta y/o ramas principales). Esta afectación se manifiesta con síntomas sistémicos como fiebre de origen desconocido (respuesta 1 falsa), síndrome general con astenia o pérdida de peso, y se asocia frecuentemente a polimialgia reumática. La prueba más específica para el diagnóstico de ACG es la biopsia de arteria temporal (respuesta 4 falsa). El PET-TAC nos indica que hay vasculitis, pero no la etiología de la misma. El tratamiento de la ACG consiste en dosis altas de esteroides (respuesta 3 falsa).

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Mujer de 30 años sin cirugías previas en estudio de esterilidad primaria de 18 meses de evolución. No existen hallazgos patológicos en su pareja masculina. La ecografía ginecológica es normal. La histerosalpingografía se muestra en la imagen. Con estos datos ¿cuál sería el siguiente procedimiento a realizar?:

1. Fecundación in vitro.
2. Inseminación artificial.
3. Salpinguectomía bilateral laparoscópica.
4. Cromopertubación laparoscópica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Nos presentan la imagen de una histerosalpingografía donde se objetiva una obstrucción de la trompa derecha (no existe extravasación de contraste a cavidad abdominal). La técnica de reproducción asistida de elección cuando existe alteración de la permeabilidad tubárica bilateral es la fecundación in vitro (FIV); sin embargo, en este caso la paciente tiene una trompa permeable, es joven (< 38 años) y sana (hay que prestar especial atención a los antecedentes de endometriosis, que nos harían decantarnos por FIV); además, el semen de su pareja también es normal, con lo que lo estrictamente indicado sería intentar 3-4 ciclos de inseminación artificial, y si no consiguiera gestación, pasar a FIV.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Varón de 52 años, obeso, que acude a urgencias por pérdida de visión brusca en el ojo derecho. En la exploración del fondo de ojo encontramos la imagen representada. El resto de la exploración se encuentra dentro de la normalidad. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta?:

1. Retinopatía hipertensiva aguda con estrella macular.
2. Retinopatía diabética proliferativa con afectación de cuatro cuadrantes.
3. Retinitis por citomegalovirus.
4. Trombosis de vena central de la retina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media, que puede ser contestada descartando opciones según leemos el enunciado. El paciente no es hipertenso (ni nos hablan de un cuadro de hipertensión maligna), por lo que descartamos una retinopatía hipertensiva aguda. Tampoco es diabético, por lo que presuponemos que la etiología no es la microangiopatía. No aparece la palabra inmunosuprimido en el enunciado, típica de las retinitis por citomegalovirus. Así, la opción que nos queda es la trombosis de vena central de la retina, que a su vez coincide con la imagen asociada. En ella se pueden observar hemorragias en llamarada, con tortuosidad venosa.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Varón de 62 años que consulta por una masa laterocervical derecha de crecimiento progresivo que se acompaña de odinofagia. Fumador de 1 paquete de cigarrillos al día desde hace 30 años. Las exploraciones de cavidad oral, orofaringoscópica, rinoscópica y otoscópica son normales. En la palpación cervical se identifica una adenopatía a nivel III de 4 cm, dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según la imagen de laringoscopia?:

1. Carcinoma transglótico derecho con adenopatía metastásica.
2. Carcinoma de seno piriforme derecho con adenopatía metastásica.
3. Carcinoma de supraglotis derecha con adenopatía metastásica.
4. Carcinoma de amígdala palatina derecha con adenopatía metastásica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico asociado a imagen. Paciente fumador con adenopatía de características malignas. La exploración orofaringoscópica, rinoscópica y otoscópica son normales, por lo que podemos descartar la respuesta 4. Observando la imagen se aprecia la masa en el seno piriforme derecho, con la supraglotis y la glotis libre de enfermedad (Descartando opciones 1 y 3). Se trata de un tumor maligno de hipofaringe, que afecta a la zona más frecuente (Seno piriforme) en su presentación clínica más habitual (Adenopatía cervical de características malignas).

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Mujer de 64 años que consulta por dolor centrotorácico de 24 horas de evolución sin otras manifestaciones clínicas. En la radiografía de tórax ¿qué hallazgo se encuentra?:

1. Aneurisma aórtico.
2. Pericarditis aguda.
3. Neumonía.
4. Hernia hiatal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta vinculada a imagen que se contesta de forma relativamente sencilla si estamos atentos a los hallazgos de la imagen. No vemos ningún tipo de condensación en campos pulmonares, por lo que la opción de neumonía queda descartada. Asimismo, no existe ningún tipo de ensanchamiento mediastínico (aneurisma) ni cardiomegalia (pericarditis, que podría producir un derrame pericárdico) por lo que las opciones 1 y 2 también quedan descartadas. Se observa por detrás del corazón una gran hernia de hiato con burbuja de gas en el fundus gástrico que dibuja las paredes del estómago. Recordad que las hernias de hiato por deslizamiento gigantes (como la de este caso), así como las paraesofágicas o mixtas, pueden requerir reparación quirúrgica. En ocasiones las hernias de hiato por deslizamiento son tan grandes que llegan a alojar 2/3 partes del estómago en el tórax (en el mediastino). Esto lo vemos sobre todo en ancianos y asociado a la obesidad.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Varón de 74 años que consulta por dolor en hemitórax derecho de características pleuríticas de 1 semana de evolución, disnea de moderados esfuerzos, tos productiva y febrícula, sin síndrome general. En la analítica destaca PCR 92,9 mg/L y dímero D 1.630 ng/ml (normal <500). Se muestra la radiografía de tórax pósterio-anterior. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?:

1. Solicitar angioTC de arterias pulmonares por sospecha de tromboembolismo pulmonar.
2. Iniciar tratamiento antibiótico por sospecha de neumonía sin signos de complicación y control radiológico en 4-6 semanas.
3. Derivarle a consulta especializada por sospecha radiológica de carcinoma de pulmón.
4. Solicitar radiografía en decúbito lateral derecho por sospecha de derrame pleural encapsulado previo a toracocentesis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Bonito caso clínico en el que nos describen a un paciente con dolor pleurítico, disnea de moderados esfuerzos, tos y

febrícula de una semana de evolución. La clínica es compatible con un proceso infeccioso (neumonía) pero también con un infarto pulmonar. En el infarto pulmonar la clínica es larvada, de varios días de evolución y puede acompañarse de febrícula en el caso de que exista sobreinfección. La clave del caso clínico la aporta la imagen asociada en la que observamos un infiltrado periférico en pulmón derecho, de forma triangular y de base pleural, compatible con lo que se denomina "Joroba de Hampton", imagen muy característica del infarto pulmonar. La imagen típica de infarto pulmonar acompañada de clínica compatible, obligan a descartar tromboembolismo pulmonar (respuesta 1 correcta).

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

En un paciente anticoagulado y antiagregado que presenta lenguaje incoherente sin otras manifestaciones clínicas asociadas, con una imagen en la TC craneal como la que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hemorragia subaracnoidea.
2. Hematoma intraparenquimatoso.
3. Hematoma epidural.
4. Hematoma subdural.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de imagen en la que es necesaria recurrir a ella para contestar la pregunta, dado que todas las opciones de respuesta podrían cursar con la clínica que presenta el paciente. En la imagen vemos una TC craneal en corte axial que muestra una hiperdensidad (sangre o calcio) con forma de semiluna en la convexidad izquierda, desplazando la línea media, lo que es compatible con un hematoma subdural.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Varón de 47 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por fiebre de hasta 39°C con escalofríos y sudoración, de una semana de evolución, acompañada de dolor epigástrico y malestar general. Se realiza TC abdominopélvica con contraste endovenoso que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Absceso hepático.
2. Hemangioma hepático.
3. Hepatocarcinoma.
4. Hiperplasia nodular focal con necrosis en su interior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy fácil sobre una lesión sólida de hígado vista por TC. Nos presentan a un paciente con fiebre y dolor abdominal, lo que nos ha de hacer pensar en algo infeccioso

(respuestas 1 ó 4, siendo la opción 1 la más frecuente y por tanto la respuesta correcta).

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Varón de 74 años sin antecedentes de interés que consulta por presentar desde hace 15 días sensación continua de distensión abdominal e intolerancia oral con vómitos ocasionales de contenido maloliente. En la analítica únicamente destaca glucemia 110 mg/dl, PCR 6,3 mg/L (normal 0-5) y 13.140 leucocitos/microL. Se realiza TC abdominal con contraste intravenoso, que se muestra. Considerando los datos clínicos y la prueba de imagen ¿qué diagnóstico es más probable?:

1. Obstrucción gástrica por neoplasia antro pilórica.
2. Gastritis enfisematosa.
3. Gastroparesia diabética.
4. Úlcera péptica con signos de perforación contenida.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La TC muestra un estómago distendido y lleno de contenido, con un tracto de salida de paredes engrosadas y de aspecto irregular. Esto es causa de la clínica de obstrucción al tracto de salida gástrico, y se corresponde con una neoplasia como primera posibilidad diagnóstica. Lo más probable es que se trate de un adenocarcinoma gástrico ubicado a nivel de antro. El diagnóstico definitivo pasará por la realización de una gastroscopia con toma de biopsias. La otra posibilidad que podría plantearnos dudas en este caso sería una úlcera penetrada a páncreas, pero en este caso la clínica predominante no sería la obstructiva sino la relacionada con la dispepsia ulcerosa (cambios en las características del dolor, etc.).

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Varón de 43 años alérgico a la penicilina que presenta boca séptica, síndrome febril, disfagia, edema, eritema y dolor submaxilar de una semana de evolución, sin mejoría con tratamiento antiinflamatorio y antibiótico. Se aporta imagen de la TC cervicofacial realizada tras la administración de contraste intravenoso ¿Qué diagnóstico le sugiere?:

1. Angina de Ludwig.
2. Absceso lingual.
3. Faringitis abscesificada.
4. Quiste dermoide lingual abscesificado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico asociado a imagen. Se trata de un paciente de 43 años con un antecedente claro de boca séptica con síndro-

me febril y disfagia y refractario a tratamiento antibiótico. Ante este caso clínico nuestra sospecha principal debe ser de una complicación infecciosa por lo que estaría indicado realizar un TAC cervical para descartarla. En la imagen asociada se evidencian múltiples colecciones a nivel de celda submaxilar derecha con extensión a rama mandibular ipsilateral y suelo de boca, siendo un caso clínico compatible con una angina de Ludwig.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Varón de 56 años con antecedentes de infección por VIH diagnosticada hace unos meses, que es encontrado confuso, desorientado y con hemiparesia derecha. La familia refiere que presenta una pérdida significativa de peso en los últimos 6 meses, así como diarrea frecuente. No ha comenzado tratamiento antirretroviral por deseo personal. Los análisis muestran una carga viral de VIH-1 de 600.000 copias/mL, 130 linfocitos CD4, 900 linfocitos totales y un cociente CD4/CD8 de 0,1. La serología a toxoplasma, la carga viral de CMV y el antígeno criptocócico en sangre son negativos. La RM cerebral se muestra en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Toxoplasmosis cerebral.
2. Linfoma primario del sistema nervioso central.
3. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
4. Encefalitis por CMV.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico típico del MIR de lesión ocupante de espacio intracraneal en paciente VIH con menos de 200 CD4/uL. En este caso es una LOE que hace efecto masa, ya que comprime el ventrículo y por tanto descartamos de entrada las opciones 3 y 4. Como nos dicen que la serología de Toxoplasma es negativa (y la toxoplasmosis cerebral se produce por reactivación), el diagnóstico más probable por tanto es el linfoma cerebral primario.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Paciente de 75 años diagnosticado de endocarditis bacteriana por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina tras presentar fiebre de 10 días de evolución, soplo sistólico en foco mitral 1-2/6, ecocardiografía transtorácica compatible y hemocultivos positivos. Se le está administrando vancomicina. A los 4 días de antibioterapia presenta disnea intensa, ortopnea y TA 110/55 mmHg. Se aprecia un soplo en foco mitral irradiado a axila 3/6. Se muestra la radiografía de tórax. Indique la actitud más apropiada:

1. Añadir al tratamiento voriconazol.
2. Sustituir la vancomicina por daptomicina y

administrar furosemida.

3. Añadir gentamicina, rifampicina, furosemida y nitritos.
4. Indicar cirugía de recambio valvular urgente y tratamiento deplectivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente con una endocarditis infecciosa producida por MRSA, que a pesar de un tratamiento antibiótico correcto presenta una mala evolución en forma de insuficiencia cardíaca aguda con una intensificación del soplo y una radiografía sugestiva de edema pulmonar agudo. Esta evolución nos tiene que hacer sospechar una complicación mecánica tal como una rotura de velo valvular que esté produciendo una insuficiencia mitral masiva y aguda. Por tanto la única solución es la quirúrgica, hay que colocar una prótesis valvular.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

La presencia de lesiones cutáneas en forma de pápulas violáceas en dorso de articulaciones interfalángicas, como las que se aprecian en la figura, son muy características de:

1. Lupus cutáneo subagudo.
2. Porfiria cutánea tarda.
3. Dermatomiositis.
4. Artropatía psoriásica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente con pápulas de Gottron, una lesión característica de las dermatomiositis que hay que conocer. Son pápulas y placas eritemato-violáceas, generalmente acompañadas de descamación, que se asientan sobre todo en las prominencias óseas, en especial sobre las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas, a veces también en zona periungual como la imagen que se muestra (respuesta 3 correcta). Las lesiones de lupus subagudo respetan las prominencias óseas: metacarpofalángicas e interfalángicas (respuesta 1 falsa). Tampoco son manos sugestivas de artritis psoriásica, dado que no se aprecia tumefacción en manos y las lesiones de psoriasis son más descamativas (respuesta 4 falsa). En la porfiria cutánea tarda las lesiones se producen por traumatismos mínimos, y consisten en vesículas que progresan a erosiones y posteriormente costras (respuesta 2 falsa).

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Mujer de 64 años con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad (índice de masa corporal 34) que es atendida en su domicilio por el servicio de emergencias tras presentar durante el descanso nocturno dolor torácico, sudoración intensa, mareos y vómitos de dos horas de evolución. Se realiza

electrocardiograma urgente (imagen). En la exploración física se aprecia una ligera disminución del nivel de conciencia, frialdad acra y tensión arterial de 75/30 mmHg, además de un aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración y la aparición de pulso paradójico, sin evidencia de edema pulmonar en la auscultación. Con los datos clínicos, exploratorios y electrocardiográficos expuestos, ¿qué complicación del infarto sospecha en esta paciente?:

1. Afectación de ventrículo derecho.
2. Rotura del septo interventricular basal.
3. Rotura del músculo papilar posteromedial mitral.
4. Pseudoaneurisma ventricular inferobasal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. Clínicamente: paciente con dolor típico de síndrome coronario agudo, mal perfundido (hipotensión, frialdad, somnolencia), con datos de sufrimiento de ventrículo derecho (elevación de presión yugular, pulso paradójico) pero sin congestión pulmonar, lo cual hace pensar en que el ventrículo izquierdo se encuentra respetado. En el ECG necrosis y elevación del ST en cara inferior (II, III y aVF) y en precordiales derechas, pudiendo hacer el diagnóstico de IAM de ventrículo derecho.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Varón de 19 años con antecedentes familiares de muerte súbita en padre que acude por clínica de ángor y síncope en esfuerzo, con sensación de palpitaciones rápidas con el esfuerzo. Presenta el ECG que se adjunta. Se realiza un ecocardiograma y es diagnosticado de una miocardiopatía. Considerando su sospecha del tipo de miocardiopatía que presenta, señale la respuesta verdadera:

1. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy frecuentemente es inferior al 55%.
2. Esta entidad es debida a una hipertrofia del tabique con obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo.
3. No se asocia a disfunción diastólica.
4. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo es normal o esta disminuido.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Fácil. Paciente con angina y síncope de esfuerzo, junto con antecedentes familiares de muerte súbita. Debemos pensar ya en cardiopatía heredable. En el ECG aumento de voltajes y alteraciones de la repolarización compatibles con miocardiopatía hipertrófica, en la que la FEVI suele ser normal y el problema viene dado por la disfunción diastólica.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

En esta genealogía se observa un patrón de herencia autosómica dominante con un salto de generación en II-1 (su padre I-1 y su hijo III-1 están afectados por la enfermedad mientras que II-1 no la manifiesta). ¿Cómo se llama este fenómeno?:

1. Herencia mitocondrial.
2. Expresividad variable.
3. Penetrancia incompleta.
4. Variación en el fenotipo debida al ambiente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de genética vinculada a una imagen de un árbol genealógico. Nos están preguntando por un patrón de herencia autosómico dominante que manifiesta el padre (I-1) y el hijo (III-1), por lo que sin mirar la imagen ya sabemos que la respuesta 1 es incorrecta, ya que en la herencia mitocondrial la enfermedad es transmitida por la madre. Pese a tratarse de una patología con herencia autosómica dominante, existen descendientes que presentan la mutación, pero no la manifiestan (descendiente II-2). Este fenómeno se conoce como penetrancia incompleta, en el que solo un porcentaje de individuos con un genotipo susceptible de ser enfermo presentarán sintomatología o fenotipo de enfermedad. La expresividad es el grado con el que se expresa un rasgo que ha “penetrado”, su benignidad o malignidad, su magnitud, etc. Los determinantes ambientales no son transmitidos por mecanismos genéticos, es un distractor que introduce el concepto de plasticidad fenotípica.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

La imagen corresponde a 5 minutos de estudio de una poligrafía respiratoria en un varón de 62 años. ¿Qué tipo de evento respiratorio se ve en la misma?:

1. Apnea obstructiva.
2. Esfuerzo respiratorio asociado a microdespertar.
3. Apnea central.
4. Hipopnea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa y de gran dificultad sobre la interpretación de una poligrafía respiratoria. Sabemos que se trata de una poligrafía respiratoria y no de una polisomnografía porque en este caso no disponemos de electroencefalograma, por lo que no se pueden valorar los despertares o microdespertares (respuesta 2 incorrecta). Nos muestran varios canales: en la parte superior nos aportan el canal de flujo respiratorio, en el segundo canal los movimientos del tórax y del abdomen y en la parte inferior la saturación del paciente. En este caso vemos que el flujo cae y se reduce cíclicamente sin llegar a desaparecer por completo. Si esa reducción es mayor al 30%

durante 10 segundos y se acompaña de una desaturación mayor o igual al 3% estaríamos ante una hipopnea (respuesta 4 correcta). Una desaparición total del flujo daría un aplamamiento de la curva y sería compatible con una apnea (respuesta 1 incorrecta). Así mismo, vemos que siempre existen movimientos toracoabdominales. En la apnea central estos esfuerzos desaparecerían en el momento en que se produce la apnea puesto que no existe estímulo desde el SNC para iniciar la respiración (respuesta 3 incorrecta).

26. ¿Cuál de los siguientes estudios de la coagulación se encontraría alterado en un paciente en el que se sospecha un trastorno hemorrágico hereditario por deficiencia del factor VII?:

1. Tiempo de tromboplastina parcial activado.
2. Tiempo de trombina.
3. Tiempo de protrombina.
4. Determinación de factor von Willebrand.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El factor VII de la coagulación forma parte de la vía EXTRÍNSECA de la hemostasia secundaria. La vía extrínseca se monitoriza con el tiempo de protrombina o INR (respuesta 3 correcta).

27. En relación con la toxicidad del etanol, señale la afirmación correcta:

1. El acetato producido en el metabolismo hepático del etanol es oxidado en este tejido para obtener energía.
2. El incremento en la relación NADH/NAD⁺ en el metabolismo hepático del etanol inhibe la gluconeogénesis.
3. El ácido úrico compite con el lactato en la excreción urinaria, contribuyendo a la hiperlactacidemia.
4. Los principales marcadores bioquímicos de ingesta habitual de etanol son las transaminasas, especialmente la alaninaaminotransferasa sobre la aspartatoaminotransferasa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre el metabolismo del alcohol (etanol), de conocimiento bioquímico y no tanto fisiopatológico o clínico. La respuesta correcta es la 2. El etanol aumenta la relación NADH/NAD⁺, lo que inhibe la gluconeogénesis hepática al reducir la actividad de la fosfoenol piruvato carboxikinasa (PEPCK).

28. El perfil metabólico a las dos horas de haber ingerido una comida con abundantes proteínas y pocos hidratos de carbono incluye todos los siguientes cambios EXCEPTO:

1. Aumento de la oxidación de aminoácidos de cadena ramificada en el músculo esquelético.

2. Aumento de los niveles de glucagón.
3. Aumento de la gluconeogénesis hepática.
4. Aumento de la utilización de citrulina por los enterocitos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre metabolismo, que no puede faltar en el MIR y que no debe preocuparte lo más mínimo haber fallado. En una dieta cetogénica pobre en hidratos de carbono, el organismo debe producir glucosa a partir de la degradación de grasas y de proteínas, por lo que existe un aumento de la neoglucogénesis hepática y de la oxidación de aminoácidos ramificados del músculo esquelético. Además, la ausencia de hidratos de carbono estimula la producción de glucagón e inhibe la síntesis de insulina, por lo que las 3 primeras opciones parecen correctas. Eso deja como falsa la 4 por descarte. La citrulina tiene un papel en la medición de la función intestinal, pero no hemos podido encontrar ninguna relación clara entre dieta cetogénica y citrulina. Así, asumimos que la 4 debe ser falsa.

29. En relación con el control fisiológico hormonal y por autacoides de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal, indique la afirmación FALSA:

1. El óxido nítrico derivado del endotelio aumenta la resistencia vascular y disminuye la filtración glomerular.
2. Las prostaglandinas y la bradicinina reducen la resistencia vascular renal y tienden a aumentar la filtración glomerular.
3. La noradrenalina y la adrenalina contraen los vasos sanguíneos y reducen la filtración glomerular.
4. La angiotensina II contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Concepto de fisiología repetido en los últimos MIRs acerca de la regulación del aparato yuxtaglomerular. El óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora, que actúa dilatando la arteriola aferente glomerular, consiguiendo de esa manera un aumento del flujo glomerular y un aumento del filtrado de acuerdo a las leyes de Starling (pregunta 1 falsa, por tanto correcta). Lo mismo sucede con las prostaglandinas y la bradicinina (respuesta 2 verdadera). En cambio, las catecolaminas (noradrenalina/adrenalina) producen vasoconstricción arteriolar (tanto en arteriola aferente como eferente), que pueden de manera neta disminuir a filtración glomerular por hipoperfusión renal (respuesta 3 verdadera). La angiotensina II, en cambio, produce vasoconstricción selectiva de la arteriola eferente, lo que mejora el filtrado glomerular (respuesta 4 verdadera).

30. Con respecto a la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal en una situación fisiológica, indique la afirmación FALSA:

1. El ritmo de casi todas las contracciones gastrointestinales viene determinado por la frecuencia de las ondas lentas.
2. La despolarización de las ondas lentas viene determinada por la entrada de iones sodio y calcio.
3. Los potenciales en espiga son potenciales de acción y tienen una duración mayor que el de las grandes fibras nerviosas.
4. En la generación y características de los potenciales en espiga es determinante la participación de iones calcio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil sobre fisiología del músculo liso gastrointestinal. En ella, existen dos tipos de ondas eléctricas: lentas y en espiga. Las ondas lentas son rítmicas y están mediadas por la entrada de iones de sodio (respuesta 2 falsa) y son generadas por las células intersticiales de Cajal. No constituyen un potencial de acción en sí mismas, sino ondulaciones periódicas leves del potencial de membrana, que marcan la frecuencia de generación de los potenciales en espiga (actúan como su marcapasos, respuesta 1 verdadera). Los potenciales en espiga sí son verdaderos potenciales de acción, con entrada de iones calcio (4 verdadera), que son los que generan las contracciones peristálticas. Los potenciales del músculo liso siempre serán más lentos que las fibras nerviosas (3 verdadera).

31. En relación con el volumen y flujo sanguíneo en los pulmones, en un sujeto sano y en bipedestación, señale la afirmación FALSA:

1. En la espiración forzada se puede generar trasvase de sangre de la circulación pulmonar a la circulación sistémica.
2. Cuando disminuye la concentración de oxígeno en los alvéolos, los vasos adyacentes se dilatan.
3. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo en todas las zonas pulmonares.
4. El aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso es asumido normalmente sin grandes aumentos en la presión arterial pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de fisiología respiratoria sobre un tema muy recurrente en el MIR: la circulación pulmonar. La pregunta hace referencia a diferentes situaciones que generan cambios en la circulación pulmonar. La respuesta falsa es la 2 sobre un concepto de gran importancia en la fisiología pulmonar: la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En la circulación pulmonar, al contrario de lo que ocurre en la circulación sisté-

mica, se produce vasoconstricción de los capilares pulmonares ante la hipoxia en los alveolos adyacentes. Tanto la respuesta 3 como la 4 (ambas correctas) hacen referencia al fenómeno de reclutamiento: ante aumentos de flujo o presión en la circulación pulmonar se produce la apertura de capilares previamente cerrados para evitar grandes cambios de presión a nivel de la arteria pulmonar. Existen shunt anatómicos (suponen menos del 2-5% del gasto cardíaco) que en situaciones como la espiración forzada, pueden suponer un paso de sangre desde la circulación pulmonar a la circulación sistémica (Respuesta 1 verdadera)

32. En cuanto a las características de los potenciales de acción que presentan las fibras musculares esqueléticas, en relación con los potenciales de acción de las fibras de las motoneuronas A alfa que las inervan, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El potencial de membrana de reposo tiene un valor similar.
2. La duración del potencial de acción de la fibra muscular es mayor.
3. La velocidad de conducción del potencial de acción de la fibra muscular es menor.
4. El flujo de corriente en la profundidad de la fibra muscular es similar al de la motoneurona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre el potencial de acción. El potencial de reposo es similar en el nervio y músculo (-80 mV, respuesta 1 verdadera), pero en el músculo su duración es mayor (2 verdadera) y la velocidad es más rápida (3, verdadera). No obstante, el flujo de corriente en la profundidad es muy distinto: la fibra muscular es tan grande que necesita de los túbulos T para que la corriente penetre a la profundidad de las miofibrillas. Los axones nerviosos carecen de túbulos T (respuesta 4 incorrecta).

33. Las diferentes clases (isotipos) de inmunoglobulinas (Ig) tienen diferentes funciones que dependen de los fragmentos Fc de sus cadenas pesadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. La IgA se une al receptor poli-Ig (pIgR) para atravesar la placenta y participar en la defensa del neonato.
2. La IgG se une al receptor III para Fc-gamma (Fc-gamma-RIII) de los fagocitos activando el proceso de opsonización.
3. La IgM se une a C1q y activa la vía clásica del complemento contribuyendo a la eliminación de bacterias extracelulares.
4. La IgE se une al receptor para Fc-épsilon (Fcépsilon-R) y activa a eosinófilos y mastocitos participando en la defensa frente a los helmintos.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta fácil y de concepto repetido sobre las características de los distintos isotipos de las inmunoglobulinas. La 2, 3 y 4 explican procesos biológicos conocidos de la IgG, IgM e IgE respectivamente, y que hay que conocer. En cambio, la opción 1 es falsa dado que la única Ig que tiene receptores para cruzar la placenta es la IgG.

34. En la inmunoterapia antitumoral basada en el uso de anticuerpos monoclonales contra puntos de control inmunológico (checkpoints) destaca el uso de los anticuerpos monoclonales que bloquean la interacción entre PD-1 y sus ligandos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. La molécula PD-1 es un receptor inhibidor de los linfocitos T que se expresa mayoritariamente en linfocitos T naïve.
2. La interacción de PD-1 y sus ligandos inhibe la activación de los linfocitos T en los ganglios linfáticos.
3. El bloqueo de PD-1 o de sus ligandos potencia la capacidad antitumoral de los linfocitos T CD8+.
4. El uso de este tipo de inmunoterapia no se debe combinar con tratamientos de quimioterapia.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Concepto de inmunoterapia importante dado el auge de estas terapias para el tratamiento de ciertos tumores. PD-1, al igual que otros receptores, son moléculas que inhiben la actividad de los linfocitos T, y su bloqueo mediante anticuerpos monoclonales potencia su actividad (opción 3 correcta). Las otras opciones no son ciertas, dado que no se expresan mayoritariamente en linfocitos naïve (más bien en linfocitos más maduros; opción 1 falsa), se pueden combinar con quimioterapia (opción 4 falsa), y la interacción PD-1/PD-L1 en el marco de la inmunoterapia sucede en el mismo ambiente tumoral (opción 2 falsa).

35. Diferentes mutaciones en el gen AIRE (Autoimmune Regulator) causan una enfermedad rara denominada síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 (APS-1). Respecto al gen ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Está ligado al cromosoma X, por lo que el síndrome APS-1 también se conoce como IPEX (Inmunodesregulación, Poliendocrinopatía y Enteropatía ligada al cromosoma X).
2. Se expresa en los timocitos que no expresan CD4 ni CD8 (doble negativos) promoviendo su expansión y participando en el proceso de selección positiva en el timo.
3. Se expresa en las células T reguladoras controlando su función y siendo responsable

del proceso de tolerancia periférica.

4. Se expresa en células epiteliales de la médula tímica regulando la expresión antígenos específicos de otros tejidos y participando en el proceso de selección negativa en el timo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El regulador autoinmune, más conocido como AIRE por sus siglas en inglés (Autoimmune Regulator), es una proteína codificada por el gen AIRE, gen de 13kb del cromosoma 21q22.3 (respuesta 1 falsa). Es considerado un factor de transcripción humano expresado en las células epiteliales de la médula del timo, el cual es fundamental en la prevención de enfermedades autoinmunes, ya que se encarga de exponer a las células T a proteínas/antígenos expresados de manera natural en el cuerpo, de tal manera que los células T que reaccionen a ellas son destruidas en el propio timo antes de entrar a circulación, lo que se conoce como selección negativa (respuesta 4 verdadera, respuestas 2 y 3 falsas). Si el AIRE es defectuoso, las células T que reaccionan contra proteínas propias del organismo salen a la circulación, pudiendo producir la enfermedad autoinmune.

36. Un estudio reciente indica que aproximadamente el 10-20 % de los pacientes muy graves o fallecidos por COVID-19 poseen autoanticuerpos neutralizantes de los interferones de tipo I. Los interferones de tipo I:

1. Inhiben la actividad citotóxica de los linfocitos T CD8+ contra las células infectadas.
2. Son producidos por linfocitos CD4+ Th1 tras el reconocimiento de péptidos víricos mediante el receptor T para el antígeno.
3. Activan la expresión de genes que confieren a la célula huésped una resistencia mayor a la infección viral.
4. Inhiben la expresión de los antígenos de histocompatibilidad (HLA) de clase I en las células infectadas.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta de dificultad moderada moderada-alta por tratar sobre un concepto novedoso en relación a la COVID-19, pero que con técnica de examen se puede solucionar. Los interferones tipo I son agentes con un importante papel en la respuesta frente a infecciones virales. En este caso, la opción mas acorde a este concepto es la 3 (activan expresión génica antiviral). Tiene lógica que los pacientes con formas más graves tengan esta vía alterada (en este caso, por autoanticuerpos) y sea la causa de estas formas graves. La opción 1 y la opción 4 habla de mecanismos que impedirían una buena respuesta inmune, por lo que son falsas, y la 2 habla de una respuesta Th1 mediada por linfocitos T CD4, un tipo de respuesta distinto donde se libera interferón gamma (que no es un interferón tipo I).

37. Respecto a las células T reguladoras (Treg) es cierto que:

1. Colaboran en la eliminación de células tumorales.
2. Expresan el correceptor inhibidor CTLA-4.
3. Coexpresan tanto CD4 como CD8.
4. Liberan citoquinas como IL-17 o IL-22.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las células Treg son un fenotipo de linfocito T implicado en la inhibición de la respuesta inmune frente a un antígeno (concepto importante). Así pues, la opción 1 queda descartada. Por otro lado, son liberadoras de IL-10 o TGFb, pero no IL-17/IL-22 (que son los linfocitos Th17), por lo que la opción 4 también es falsa. Existe un pequeño número de linfocitos T llamados “doble positivos” que coexpresan CD4 y CD8, pero no son los TReg (opción 3 falsa). Como es lógico pensar, si expresan el receptor de checkpoint inmune CTLA-4, tendrán una capacidad de inhibir respuestas inmunes, por lo que la opción correcta es la 2.

38. Mujer de 25 años con antecedentes de asma bronquial alérgica por sensibilización a pólenes de gramíneas y dermatitis atópica. Presenta de forma brusca hipotensión, taquicardia, urticaria y broncoespasmo tras ingerir cacahuetes y es trasladada a urgencias. ¿Cuál sería el orden de los fármacos a administrar y qué prueba de laboratorio podría solicitarse para ser evaluada posteriormente?:

1. Adrenalina intramuscular, seguida de un broncodilatador inhalado tipo SABA y dexclorfeniramina intramuscular. A continuación solicitar triptasa sérica.
2. Un broncodilatador inhalado tipo SABA, seguido de dexclorfeniramina intramuscular y adrenalina intramuscular. A continuación solicitar triptasa sérica.
3. Dexclorfeniramina intramuscular, seguida de un broncodilatador inhalado tipo SABA y adrenalina intramuscular. A continuación solicitar proteína catiónica del eosinófilo.
4. Adrenalina intramuscular, seguida de un broncodilatador inhalado tipo SABA y dexclorfeniramina intramuscular. A continuación solicitar proteína catiónica del eosinófilo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil por ser de un tema poco común en el MIR (Alergología). Se nos presenta una mujer con una clara anafilaxia tras ingerir cacahuetes. El primer fármaco a administrar ante una anafilaxia es adrenalina intramuscular, concepto importantísimo. A continuación, podemos continuar con fármacos que faciliten la reversión del cuadro (aunque la

evidencia es menor), como broncodilatadores y antihistamínicos. Por último, ante cuadros de alergia, la triptasa sérica es de ayuda para monitorizar el cuadro clínico y para luego establecer el diagnóstico de alergia. En este caso, la opción 1 es la que mejor define la actuación a seguir.

39. Paciente de 35 años de edad que consulta para confirmar una sospecha de alergia a Anisakis simplex. Ha sufrido previamente un cuadro clínico de anisakirosis gastrointestinal tras ingerir pescado. En las pruebas efectuadas se evidencian niveles de IgE específica de 10 KU/l frente a Anisakis simplex. De las siguientes ¿cuál sería la recomendación dietética para este paciente?:

1. No puede comer ningún pescado, crustáceo, molusco ni cefalópodo.
2. Puede comer pescado fresco cocinado a la plancha.
3. Puede comer pescado ultracongelado comercialmente.
4. Puede comer pescado fresco marinado o ahumado en frío.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta nos explican el caso de un paciente que ha presentado una anisakirosis gastrointestinal previa y en el que se ha comprobado que presenta sensibilización frente a Anisakis (IgE frente a Anisakis positiva). A las personas con sensibilización frente a Anisakis debe recomendarseles ingerir solo pescado que haya sido previamente congelado.

40. Mujer de 16 años diagnosticada de rinoconjuntivitis alérgica por sensibilización a pólenes de gramíneas desde los 10 años, que no controla totalmente la sintomatología en época de polinización con antihistamínicos orales y corticoides tópicos nasales. ¿Qué opción terapéutica etiológica estaría indicada?:

1. Inmunoterapia específica vía sublingual o vía subcutánea durante un periodo mínimo de 3 años.
2. Inmunoterapia específica vía sublingual o vía subcutánea durante un periodo máximo de 1 año.
3. Omalizumab vía subcutánea cada 4 semanas durante un periodo máximo de 1 año.
4. Omalizumab vía subcutánea cada 4 semanas durante un periodo mínimo de 6 meses.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico de una joven con un cuadro de rinoconjuntivitis alérgica de mal control. Nos preguntan por el tratamiento etiológico, dirigido a su alergia a pólenes de gramíneas. Las opciones 1 y 2 plantean el único tratamiento etiológico, la

inmunoterapia dirigida via subcutanea/sublingual, con distintas pautas de dosificación que suelen girar en torno a los 3-5 años para conseguir su dosis máxima. RC 1.

41. Se realiza un estudio para determinar la posible relación entre la contaminación ambiental por SO₂ en diversas zonas geográficas y el número de visitas a urgencias por asma. Sobre el diseño del estudio, señale la respuesta correcta:

1. Estudio de correlación ecológica.
2. Estudio de incidencia.
3. Estudio de prevalencia.
4. Estudio de cohortes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Es un estudio observacional y que no presenta seguimiento, por lo que la opción 2 y 4 quedan descartadas. Al tratarse de un estudio de base comunitaria (utiliza datos que reflejan el promedio de la característica estudiada obtenida de registros) estamos ante un estudio ecológico (el estudio de prevalencia es de base individual). Recuerda que los estudios sin seguimiento no pueden demostrar causalidad, solamente asociación mediante la razón de prevalencias. Podré ver la asociación entre contaminación elevada y aumento de asistencias a urgencias pero no establecer relación causal.

42. ¿Qué tipo de medidas de precaución deben adoptarse ante un paciente con neumonía y antigenuria positiva a Legionella pneumophila?:

1. Precauciones de transmisión por gotas.
2. Precauciones de transmisión por contacto.
3. Precauciones de transmisión por aire.
4. Precauciones estándar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La Legionella se adquiere a partir de micropartículas de agua contaminadas, pero no se transmite de persona a persona, por lo que únicamente deben adoptarse las precauciones estándar.

43. En un meta-análisis, el estimador combinado de los resultados de los estudios revisados es:

1. La suma de los resultados de todos los estudios.
2. La media aritmética de los resultados de todos los estudios.
3. La media ponderada de los resultados de todos los estudios.
4. El porcentaje de resultados favorables a la hipótesis estudiada en todos los estudios.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El resultado final de un metaanálisis (resultado agregado) debe tener en cuenta los resultados de los diversos estudios que se han incluido para realizarlo (ponderar los resulta-

dos de éstos). Si los estudios incluidos son similares entre sí (no existe heterogeneidad significativa) los resultados de los estudios se combinan mediante un modelo de efectos fijos y se ponderan por el tamaño muestral (los estudios más grandes "pesan" más). Si los estudios incluidos son distintos entre sí (existe heterogeneidad significativa) se utilizará un modelo de efectos aleatorios en el que se pondera según la variabilidad inter-estudios. La respuesta 4 es falsa porque precisamente uno de los escenarios en los que se realiza un metaanálisis es cuando algunos de los estudios previos han obtenido resultados a favor y otros en contra.

44. La especificidad de una prueba diagnóstica es del 94 %. ¿Cuál es la interpretación correcta?:

1. De cada 100 resultados negativos, 94 corresponden a pacientes sanos.
2. De cada 100 pacientes sanos, en 94 el resultado de la prueba será negativo.
3. De cada 100 pacientes enfermos, en 6 el resultado de la prueba será negativo.
4. De cada 100 resultados positivos, 6 corresponden a pacientes enfermos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La especificidad es la capacidad de una prueba para detectar a los sanos como tal. La especificidad hace referencia, por lo tanto, al porcentaje de sujetos sanos que tendrán un resultado negativo en el test. Las medidas de validez interna y externa son probabilidades condicionadas. En el caso de la especificidad, nos encontramos ante un sujeto sano y nuestro test puede dar un resultado verdadero negativo (especificidad) o equivocarse y clasificarlo como positivo (tasa de falsos positivos).

45. En la valoración del riesgo de sesgo en los ensayos clínicos ¿cuál de los siguientes criterios se considera?:

1. Pérdidas en el seguimiento.
2. Falta de representatividad de la muestra.
3. Insuficiente tamaño muestral.
4. Escasa comparabilidad de los casos y controles.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En cualquier estudio epidemiológico, para que los resultados sean válidos, debe preverse en el diseño la posibilidad de cometer sesgos ya que, en caso de ocurrir, no podremos aceptar los resultados aunque sean estadísticamente significativos por falta de validez interna. La primera opción hace referencia al sesgo de atrición por el que en los distintos grupos el número de pérdidas difiere y esto puede sobreestimar el efecto. Para evitarlo deberíamos realizar un análisis por intención de tratar. Las respuestas 2 y 3 hacen referencia a los errores aleatorios. Un tamaño muestral pequeño puede hacer que no alcancemos a ver diferencias estadísticamente significativas. Una muestra no representativa afectará a la validez externa, no podremos extrapolar los resultados a la

población. No debe confundirse esto último con un sesgo de selección en el que existen diferencias en las características basales en ambos grupos.

46. Un ensayo clínico controlado ha evaluado la eficacia de un nuevo antiagregante en pacientes graves con síndrome coronario agudo. En el grupo de tratamiento convencional (control) la mortalidad fue del 10 % en mujeres y del 8 % en hombres. En el grupo de intervención con el nuevo antiagregante, la mortalidad se redujo a la mitad del observado en el control tanto en mujeres como en hombres. En relación con la eficacia del nuevo antiagregante para mejorar la supervivencia según el género, señale la respuesta correcta:

1. Es más eficaz en mujeres, porque el valor de NNT estimado en mujeres es inferior al de los hombres.
2. Es más eficaz en hombres, porque el valor de NNT estimado en hombres es superior al de las mujeres.
3. El nuevo antiagregante es igual de eficaz en mujeres y hombres, porque en ambos casos reduce la mortalidad a la mitad.
4. Es más eficaz en hombres, porque el valor de NNT estimado en hombres es inferior al de mujeres.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Una pregunta clásica sobre el cálculo e interpretación del número necesario a tratar (NNT). El NNT es el número de pacientes que deberían recibir un tratamiento para evitar una muerte (o evento) y se calcula como el inverso de la reducción absoluta de riesgo ($RAR = I_o - I_e$; $NNT = 1/RAR$). En este caso, en ambos grupos se redujo la mortalidad a la mitad (RAR en mujeres 5%; RAR en hombres 4%). El RAR significa que por cada 100 pacientes tratados, evitaremos 5 y 4 eventos en mujeres y hombres, respectivamente. Por lo tanto el NNT es 20 (mujeres) y 25 (hombres). El NNT para evitar un evento es menor en el caso de los mujeres, por lo que es en éstas una medida más eficaz; para evitar un infarto en el caso de las mujeres precisamos tratar a 20, mientras que en el caso de los hombres a 25.

47. ¿En cuál de las siguientes infecciones se precisan medidas de aislamiento de contacto y gotas?:

1. Varicela.
2. Fiebres hemorrágicas virales.
3. Norovirus.
4. Clostridioides difficile.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de cierta dificultad sobre las medidas de aislamiento de diferentes microorganismos. La varicela requiere ais-

lamiento de contacto y aéreo, mientras que *C. difficile* solo requiere aislamiento de contacto. Los Norovirus no suelen aislarse, aunque en todo caso sería un aislamiento de contacto. Finalmente los virus causantes de fiebre hemorrágica requieren aislamiento de contacto y gotas.

48. Para conocer si el uso habitual de ácido acetil salicílico (AAS) se asocia a un mayor riesgo de hipertensión se selecciona un grupo de sujetos, se averigua cuántos están tomando AAS y se les sigue durante 5 años para identificar los casos nuevos de hipertensión. ¿Cuál es el diseño de este estudio?:

1. Es un ensayo clínico, porque se realiza con fármacos.
2. Es un estudio ecológico, porque se sigue a muchos sujetos.
3. Es un estudio de casos y controles, en el que los casos toman AAS y los controles no.
4. Es un estudio de cohortes, porque se sigue a sujetos clasificados según su exposición para identificar el riesgo de una enfermedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un estudio observacional (respuesta 1 falsa) en el que se establece como factor de riesgo la exposición a AAS (un grupo expuesto y otro no) y se evalúa la incidencia de hipertensión arterial en ambos grupos de forma prospectiva. Partimos del factor de riesgo y vamos a buscar la aparición de la enfermedad; se trata de un estudio de cohortes.

49. ¿Cuál es la mejor forma de medir la carga global de enfermedad en una población?:

1. Los años vividos con discapacidad.
2. Los años de vida perdidos por muerte prematura.
3. La mortalidad general y por las principales enfermedades.
4. Los años de vida ajustados por discapacidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La mejor medida de la carga global de una enfermedad son los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD en castellano; DALY en inglés: disability adjusted life years). Esta medida agrupa los años perdidos respecto a la esperanza de vida (opción 2) y los años que el paciente vivirá con peor calidad de vida fruto de la enfermedad (opción 1).

50. Varón de 58 años que acude a control programado de una diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 años. Tiene antecedentes personales de HTA, dislipidemia, cardiopatía isquémica y pancreatitis de origen biliar. Su medicación incluye lisinopril, metoprolol, metformina, AAS y atorvastatina. En la exploración física presenta

tensión arterial 151/93 mmHg, IMC 27,1 kg/m². La hemoglobina glicada es de 8,3 %. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más adecuado para este paciente?:

1. Empaglifozina.
2. Glipizida.
3. Acarbosa.
4. Sitagliptina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy fácil y predecible dado que es una novedad de las guías en los últimos años. Tenemos un caso de un hombre de 58 años diabético con múltiples factores de riesgo cardiovascular, además nos recalcan que el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica (es decir, enfermedad cardiovascular establecida). El paciente está en tratamiento con metformina para su diabetes y tiene un mal control (glicada 8,3%), nos piden decidir el segundo antidiabético a añadir. Dado que el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, tenemos como mejores opciones según las guías los arGLP1 o los iSGLT2; dado que de los primeros no nos los ofrecen en las respuestas, claramente la elección es añadir empagliflozina (respuesta 1 verdadera), que además ayudará a que este paciente pierda peso. Pero miremos las otras opciones: glipizida es una sulfonilurea, cada vez menos usadas y además aumentan el peso por lo que no serían la mejor opción en este paciente que tiene sobrepeso (respuesta 2 falsa); la acarbosa es un inhibidor de la disacaridasa intestinal que ofrece un pobre control glucémico, por lo que requiere tratamiento combinado; además, también están en desuso (respuesta 3 falsa); la sitagliptina en un iDPP4 con efecto incretina pero es poco potente y no influye en el peso, por lo que no sería la mejor opción en este paciente dado que debemos tratar de que reduzca su IMC (opción 4 falsa).

51. Mujer de 55 años con diabetes tipo 1 diagnosticada a los 15 años que refiere náuseas y distensión abdominal, especialmente después de las comidas. La evaluación es compatible con una gastroparesia diabética. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería el tratamiento más adecuado para mejorar sus síntomas?:

1. Lansoprazol.
2. Ondansetrón.
3. Loperamida.
4. Metoclopramida.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Por la clínica y antecedentes de la paciente parece que nos encontramos ante un caso típico de gastroparesia secundaria a neuropatía autonómica en paciente diabético. Si bien la ERGE y los síntomas secundarios al ácido pueden estar aumentados en una gastroparesia, no es lo que sufre esta paciente, por lo que el IBP no tiene sentido (opción 1 falsa). Asimismo, la loperamida es un antidiarreico derivado opioi-

de que no tiene papel en el tratamiento de problemas gástricos. El ondansetrón es un antiemético que actúa a nivel de receptores de serotonina 5-HT₃, utilizado sobre todo en el tratamiento de la emesis asociada a quimioterapia. Nuestra paciente no llega a presentar vómitos y, además, el ondansetrón no presenta efecto procinético asociado, por lo que no sería el tratamiento más adecuado. La opción correcta es la metoclopramida que, además de ser antiemética, presenta efectos procinéticos y favorecedores del vaciado gástrico.

52. Mujer de 35 años diagnosticada de esquizofrenia refractaria que ha iniciado tratamiento con clozapina. ¿Qué valor de laboratorio se debería monitorizar de forma periódica?:

1. El aclaramiento de creatinina.
2. El recuento sanguíneo de leucocitos.
3. El nivel sérico de colesterol.
4. El nivel sérico de transaminasas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de examen MIR 2022. La clozapina es un fármaco antipsicótico que precisa de control leucocitario periódico, por el riesgo de leucopenia y, particularmente, de agranulocitosis (muy poco frecuente, más probable al inicio del tratamiento). Pregunta fácil, más teniendo en cuenta que el MIR 2021 también se preguntó este fármaco y efecto secundario.

53. Varón de 28 años que es trasladado a urgencias con signos de intoxicación aguda. Está consciente y presenta un cuadro caracterizado por vómitos, diarrea, sudoración, sialorrea, lagrimeo y miosis. Considerando la causa más probable de este síndrome, ¿qué fármaco indicaría para su tratamiento de entre los siguientes?:

1. Naloxona.
2. Flumazenilo.
3. Ciproheptadina.
4. Atropina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tema de intoxicaciones agudas. En este caso, nos presentan un cuadro de intoxicación con miosis y exceso de secreciones: diarrea, sudoración, sialorrea y lagrimeo. Se trata de un síndrome colinérgico, que se produce en intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa como insecticida, organofosforados, carbamato o fisostigmina; y por agonistas de receptores muscarínicos como el betanecol o la pilocarpina. Su antídoto es la atropina (respuesta 4 correcta), y a veces la pralidoxima, sin olvidar las medidas de soporte. La naloxona o el flumazenilo se usarían en los síndromes opiáceo y los síndromes hipnótico sedante, que no cursan con aumento de secreciones. La ciproheptadina es un antiserotoninérgico con acción anticolinérgica.

54. ¿Qué afirmación es correcta en relación con el omeprazol?:

1. Es un potente antiácido.
2. Bloquea reversiblemente la bomba de hidrogeniones en el estómago.
3. Es un profármaco.
4. Tras disolverse su cubierta entérica en el estómago se une directamente a la bomba de protones de la célula parietal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta teórica y directa sobre las características del omeprazol. El término “antiácido” se emplea para aquellos fármacos que son bases y neutralizan directamente el ácido en la luz gástrica, como el almagato (sales de aluminio y magnesio). El omeprazol, en cambio, es lo que llamamos un antisecreto, función que realiza mediante el bloqueo irreversible de la bomba de protones de la célula parietal. Para ello, primero debe interactuar con el medio ácido del estómago y convertirse en un derivado tetracíclico activo, que es el que se une a la bomba de protones, bloqueando su función. Se trata, por tanto, de un profármaco (respuesta 3 correcta).

55. Paciente diabético de 63 años a quien su médico de familia ha solicitado una analítica para determinar los niveles de vitamina B12. ¿Cuál es el fármaco antidiabético que toma que justifica dicha solicitud?:

1. Gliclazida.
2. Metformina.
3. Repaglinida.
4. Pioglitazona.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy bonita de dificultad media sobre un efecto adverso de antidiabéticos. La metformina, pilar del tratamiento de la diabetes, reduce la absorción intestinal de vitamina B12 hasta en un 30% de los pacientes, reduciendo las concentraciones séricas de vitamina B12 en un 5-10%, por lo que rara vez causa anemia megaloblástica (respuesta 2 verdadera, resto falsas). Como información extra, debéis saber que la dosis y la duración del tratamiento con metformina se correlacionan con el riesgo de deficiencia de vitamina B12. En un estudio, la reducción de la vitamina B12 sérica parecía deberse a una absorción deficiente de B12 en el íleon y se corrigió mediante la administración de carbonato de calcio por vía oral (1,2 g diarios). También se ha demostrado que la suplementación con un multivitamínico diario se asocia con una menor prevalencia de deficiencia de vitamina B12. Se puede considerar el control o la administración de rutina de B12 en pacientes con ingesta o absorción dietética deficiente.

56. Para tratar una infección en un niño alérgico a la penicilina, de los siguientes antibióticos a los que el germen es sensible según el antibiograma ¿cuál utilizaría?:

1. Claritromicina.
2. Imipenem.
3. Ceftriaxona.
4. Norfloxacin.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las macrólidos son una de las opciones más utilizadas como alternativa en pacientes alérgicos a penicilina. Recuerda que en niños las quinolonas están contraindicadas por ser tóxicas para el cartílago de crecimiento. Ceftriaxona e imipenem son beta-lactámicos y por tanto puede existir riesgo de reacción cruzada en alérgicos a penicilina.

57. Uno de los siguientes signos clínicos impide realizar el diagnóstico de muerte cerebral:

1. Presencia de reflejos medulares.
2. Anisocoria.
3. Ausencia de hipotensión.
4. Ausencia de ventilación espontánea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por cómo está formulada. Nos están preguntando cuál de los siguientes signos debe hacernos dudar de que el paciente aún conserva cierta actividad cerebral. Los reflejos medulares son eso, medulares, por lo que pueden preservarse en situaciones en las que el cerebro esté completamente lesionado (su presencia no excluye el diagnóstico de muerte cerebral). La inestabilidad hemodinámica secundaria a lesión troncoencefálica puede servir de apoyo, pero NO es un criterio obligatorio para el diagnóstico de muerte cerebral y por tanto su ausencia no lo excluye. En cambio, la ausencia de ventilación espontánea SÍ es un requisito indispensable que puede explorarse mediante el test de apnea. La anisocoria es la que fue dada por buena por el Ministerio, ya que puede traducir que el circuito pupiloconstrictor está preservado en al menos un lado.

58. Indique cuál de los siguientes NO se considera un factor de riesgo de delirium postoperatorio en el paciente mayor:

1. Caídas previas.
2. Demencia o deterioro cognitivo.
3. Institucionalizado en una residencia.
4. Alteración visual y auditiva.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre factores de riesgo de delirium postoperatorio. Los déficits sensoriales, el deterioro cognitivo, la institucionalización (indicativo de dependencia funcional)

se consideran de riesgo, no así las caídas previas (que en caso de ser frecuentes o recurrentes sí se incluyen en la definición de anciano frágil, en quien sí es frecuente a su vez el delirium).

59. En la valoración preoperatoria de un paciente, ¿cuál de los siguientes NO consideraría un factor predisponente a desarrollar complicaciones pulmonares?:

1. Edad > 60 años.
2. Albúmina sérica < 3,5 g/100ml.
3. Consumo de alcohol.
4. ASA = 1.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El ASA es la clasificación del riesgo anestésico del paciente, establecido por la American Society of Anesthesiologists (ASA) para estimar el riesgo anestésico en función de la situación del paciente y no del tipo de cirugía que se va a realizar. Se trata de una clasificación compuesta por 6 grados. El ASA I se corresponde con un paciente sano por definición, sin ninguna comorbilidad, por lo que es la respuesta correcta.

60. Paciente de 20 años que acude a urgencias tras sufrir un accidente de bicicleta con traumatismo facial. Se realiza TC craneal que muestra una fractura del tercio medio facial que afecta a la región órbito-malar. Una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de fracturas es:

1. Anquilosis témporo-mandibular.
2. Maloclusión dental.
3. Pseudoartrosis naso-etmoidal.
4. Enoftalmos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica directa sobre los traumatismos del macizo facial y sus posibles complicaciones. Ante una fractura que afecte el complejo orbito-malar, la complicación más frecuente es el enoftalmos.

61. El conocimiento de la anatomía de la mama es fundamental a la hora de realizar intervenciones quirúrgicas en cirugía plástica. Señale cuál de los siguientes troncos nerviosos es el encargado en la mayoría de los casos de inervar el complejo areola-pezones:

1. Rama cutánea lateral del nervio intercostobraquial.
2. Ramas cutáneas mediales del plexo cervical.
3. Rama cutánea medial del nervio torácico largo.
4. Rama cutánea lateral de los nervios intercostales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil acerca de la anatomía quirúrgica de la mama. La vascularización del complejo areola-pezones (CAP) es fundamental a la hora de establecer cualquier técnica quirúrgica para mantener la viabilidad del mismo. Su inervación es también importante de cara a ser mantenida tras una cirugía reconstructiva o estética mamaria en la medida de lo posible. Esta inervación cutánea no se realiza por un único nervio, sino que es determinada por ramas de los nervios intercostales que se encargan también en su variante arterial de la vascularización mamaria.

62. Mujer de 57 años intervenida de mamoplastia de aumento con prótesis hace 4 años. Refiere que desde hace 2 años su mama izquierda está más rígida que la derecha y que en ocasiones le ha producido molestias al realizar esfuerzos con su brazo izquierdo. En la exploración física presenta asimetría evidente de ambas mamas con aumento de la consistencia y cierta deformidad de la mama izquierda y desplazamiento moderado hacia el hueco axilar. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Seroma crónico con colonización bacteriana.
2. Linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis mamarias.
3. Contractura capsular.
4. Carcinoma ductal infiltrante de mama.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Complicación más frecuente de los implantes mamarios tanto reconstructivos como estéticos. Cualquier cuerpo externo al organismo (como un implante mamario) es rodeado por una cápsula fibrosa que lo aísla. Con el paso del tiempo esta cápsula va engrosándose y las fibras de colágeno modifican su disposición, pudiendo dar lugar a una contractura capsular, que se presentará como en la paciente con una alteración morfológica de la mama con elevación del implante y dolor a la palpación (la mama afecta se encuentra más dura y consistente). Su manejo pasa por un explante y capsulectomía completa, y reposición de un nuevo implante mamario.

63. Varón de 36 años que consulta por hiperemia conjuntival y sensación de cuerpo extraño. En la exploración presenta afectación del ganglio preauricular. ¿Cuál de las siguientes patologías NO se corresponde con dicha exploración?:

1. Conjuntivitis adenovírica.
2. Conjuntivitis alérgica.
3. Síndrome oculoglandular de Parinaud.
4. Conjuntivitis por Chlamydia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Podemos intentar descartar

tar la opción más discordante: todas ellas tienen origen infeccioso excepto una, la conjuntivitis alérgica. Otra técnica para acertar la pregunta (si uno no conoce que el síndrome oculoglandular de Parinaud es lo mismo que la enfermedad por arañazo de gato, provocada por *Bartonella henselae*), es pensar que las alergias, al no tener una etiología infecciosa, no tienen por qué inflamarse un ganglio, siendo la opción a elegir. Recuerda que el síndrome oculoglandular de Parinaud se caracteriza por conjuntivitis unilateral granulomatosa con reacción folicular asociada a linfadenopatía en los ganglios preauriculares y/o submandibulares. Su causa más frecuente es *Bartonella henselae*, pero también se produce por tularemia o esporotricosis.

64. Mujer de 68 años que utiliza para visión lejana gafas de +4,00 dioptrías en ambos ojos. Consulta porque desde hace unas semanas tiene dolor ocular con cefalea y visión borrosa por la noche cuando está viendo la televisión en penumbra. ¿Cuál de las siguientes patologías es más probable que presente?:

1. Glaucoma por cierre angular primario.
2. Migraña.
3. Queratitis actínica.
4. Síndrome de ojo seco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. El caso descrito en el enunciado es un glaucoma por cierre angular. Sin embargo, no es un ataque agudo, sino varios subagudos. La paciente tiene una predisposición anatómica por ser un ojo pequeño, tiene hipermetropía. Recuerda que el signo positivo en la refracción es hipermetropía, y el signo negativo es miopía. Si no recuerdas esto, puedes sospechar el glaucoma agudo por el dolor ocular asociado a baja luminosidad (que es cuando la pupila se dilata y puede bloquear el ángulo iridocorneal). Recuerda que el caso típico de un glaucoma agudo por cierre angular es un ojo rojo doloroso por subida brusca y mantenida de la presión intraocular, con midriasis media, en un paciente de 55-65 años hipermétrope. Puede desencadenarse por baja luz, estrés agudo o colirios midriáticos.

65. ¿Cuál de las siguientes entidades es más probable que presente un paciente que acude a consulta por visión borrosa y metamorfopsia?:

1. Maculopatía.
2. Neuritis óptica.
3. Glaucoma agudo.
4. Catarata intumesciente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Ante un paciente que tiene visión borrosa y metamorfopsia (visión del tamaño o la forma de los objetos de manera irregular) hay que pensar en patología macular. Las neuritis producen diferentes tipos de

escotoma, por ejemplo: altitudinal, central, etc.; pero no metamorfopsia. En el glaucoma agudo la pérdida de visión es generalizada por edema corneal. Y, en la catarata, la pérdida de visión se asocia a halos alrededor de las luces, no distorsión de del tamaño o la forma.

66. Mujer de 60 años con crisis de mareo de segundos de duración que se desencadenan con los movimientos de la cabeza a la derecha y cuando se da la vuelta en la cama a la derecha. No se asocia a hipoacusia, sensación de taponamiento ni acúfenos. La exploración otológica, de la bipedestación y la marcha son normales. No se evidencia nistagmo espontáneo, pero con la maniobra de Dix-Hallpike a la derecha se identifica, tras breve latencia, un nistagmo disconjugado (más torsional derecho y más vertical izquierdo) de unos 30 segundos de duración con mareo y náuseas. Indique la afirmación correcta sobre su diagnóstico y manejo:

1. Vértigo de origen central, es preciso hacer una prueba de neuroimagen.
2. Vértigo posicional paroxístico benigno, debe ser tratado con la maniobra de Epley derecha.
3. Neuronitis vestibular derecha, debe ser tratada con sulpirida.
4. Primera crisis de enfermedad de Ménière en oído derecho, se infiltrarán corticoides intratimpánicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico de un cuadro de mareo con giro de objetos de segundos de duración, acontecido con cambios de posición, sin ninguna otra clínica otológica acompañante. La exploración vestibular no encuentra nistagmo espontáneo y la maniobra de Dix Hallpike es claramente positiva para un VPPB derecho. Se trata claramente de un VPPB y el tratamiento de elección es la maniobra de Epley.

67. Varón de 40 años sin antecedentes relevantes que consulta por hipoacusia izquierda de instauración progresiva y un bulto ipsilateral en el cuello. No refiere catarro de vías altas, rinorrea acuosa, prurito nasal, otalgia, otorrea, vértigo ni acúfenos. En la otoscopia, en el oído izquierdo se observa una membrana timpánica íntegra con una imagen de líquido ambarino con burbujas en oído medio, siendo la exploración del oído derecho normal. Rinne positivo en oído derecho y negativo en oído izquierdo, Weber lateraliza a oído izquierdo. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tenga en el oído izquierdo?:

1. Otitis media aguda que debe ser tratada con antibióticos vía oral.

- Otitis media crónica colesteatomatosa que debe ser tratada mediante cirugía.
- Otitis media serosa que precisa una exploración de la nasofaringe en busca de una neoformación u obstrucción de la trompa de Eustaquio.
- Hipoacusia neurosensorial que precisa la realización de una audiometría tonal y una logaudiometría.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico de un varón de 40 años con hipoacusia unilateral, con burbujas y líquido ambarino en la otoscopia, y acúmetría concordante con una hipoacusia de transmisión (Rinne - OI y Weber lateralizado a oído izquierdo), estamos ante una otitis secretora, que sin factores epidemiológicos acompañantes (No rinorrea, no catarro de vías altas), SIEMPRE debemos de buscar una afectación en la nasofaringe. La respuesta correcta es la 3.

68. **Mujer de 52 años de edad, a la que tres semanas antes se había diagnosticado una sinusitis aguda maxilar, etmoidal y frontal derechos. Mejoró inicialmente con tratamiento antibiótico, descongestionante nasal, mucolítico y corticoides tópicos. Acude dos semanas después con un cuadro de fiebre, cefalea intensa, náuseas y malestar general. Para el estudio de posibles complicaciones supuradas intracraneales la prueba complementaria más adecuada es:**

- Tomografía axial computarizada del macizo facial con cortes coronales y axiales.
- Endoscopia nasal con ópticas rígidas o flexibles.
- Resonancia magnética nuclear con gadolinio.
- Punción lumbar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico de una complicación grave de una sinusitis. Mujer de 52 años con una sinusitis extensa con tratamiento dirigido correcto, que empeora con un cuadro de cefalea intensa, náuseas y fiebre, se deberá de descartar una complicación intracraneal. La primera prueba que ha de realizarse es un TC con contraste del macizo facial Y CRANEAL para descartar complicaciones, con su consiguiente punción lumbar si procediese. La RM con gadolinio, si bien no la primera prueba a solicitar, nos facilita información completa y sensible de todas las complicaciones intracraneales. Pregunta dudosa e impugnada. RC 3

69. **¿Cuál es el marcador ecográfico más importante en el cribado de la preeclampsia del primer trimestre del embarazo?:**

- Longitud cráneo-caudal.
- Grosor placentario.
- Índice de pulsatilidad de las arterias uterinas.

- Índice de pulsatilidad de la arteria central de la retina materna.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El cribado de riesgo de preeclampsia en el primer trimestre se calcula con parámetros clínicos (antecedentes en la anamnesis y TAM en la exploración física) y analíticos (lo más frecuente, niveles de PIGF en sangre materna e IP medio de las arterias uterinas en la ecografía).

70. **Mujer de 43 años portadora de dispositivo intrauterino de levonorgestrel que consulta por falta de descanso nocturno con aparición de calor y palpitaciones. En la analítica destaca T4 libre 10,5 pmol/L (9-19), tirotropina 2,1 mUI/L (0,30-5,00), FSH 95,6 UI/L (1,38-16,7), LH 21 UI/L (2,4-9,3), estradiol < 0,07 nmol/L (0,07 1,14). ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?:**

- Benzodiacepinas.
- Estrógenos vaginales.
- Estrógenos y progestágenos orales en pauta continua.
- Estrógenos transdérmicos en pauta continua.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Nos presentan una paciente con clínica climatérica y una analítica compatible con menopausia (FSH >30, estradiol bajo) que solicita tratamiento sintomático. La indicación es administrar estrógenos, mejor evitando la vía oral; y, como es una paciente que conserva útero, asociar gestágenos para evitar el riesgo de cáncer de endometrio. El truco de esta pregunta radica en que la paciente es portadora de un DIU liberador de levonorgestrel, por lo que sólo hace falta que añadamos los estrógenos. Estos deben ser transdérmicos para que tengan acción sistémica, mientras que optaríamos por la vía vaginal si la paciente aquejase clínica genital (síndrome genitourinario de la menopausia).

71. **En relación con el estudio prenatal de aneuploidías mediante el cribado combinado del primer trimestre ¿Cuál es la afirmación correcta?:**

- El valor de la fracción libre de la gonadotropina coriónica se encuentra disminuido en la trisomía 21.
- Se realiza mediante la combinación de datos analíticos y ecográficos.
- Está indicada en el primer trimestre en población gestante de riesgo.
- La transonolucencia nuchal debe medirse entre las 11 y 14 semanas, mediante la realización de un corte sagital y con el embrión en posición de hiperflexión.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja acerca del tema más importante del bloque de Obstetricia: el cribado de aneuploidías del primer trimestre. Recordad que está indicado en toda la población gestante entre las semanas 11 y 14 y que aúna parámetros clínicos (edad materna), bioquímicos (beta-hCG y PAPP-A) y ecográficos (siendo el marcador aislado más sensible la translucencia nuchal). La translucencia nuchal debe medirse en un corte medio sagital del embrión, que debe estar en posición neutral (ni hiperflexionado ni hiperextendido). De los marcadores bioquímicos recordad que siempre están disminuidos salvo la beta-hCG en la trisomía 21, que aumenta.

72. ¿Cuál de los siguientes NO constituye un criterio de selección para la elección de la vía del parto en la presentación de nalgas durante el inicio del trabajo de parto?:

1. Tipo de presentación podálica (nalgas puras, completas o incompletas).
2. Medida del diámetro biparietal fetal.
3. Peso fetal.
4. Actitud de la cabeza fetal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-alta. Desde la actualización del protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, se está intentando recuperar la práctica del parto de nalgas. Como contraindicaciones para permitirlo, recordad la macrosomía fetal, la presentación en nalgas incompletas, la actitud hiperextendida de la cabeza fetal, la prematuridad y el CIR.

73. Mujer de 51 años, menopáusica desde hace un año y medio, que consulta por manchado vaginal de 2 semanas de evolución. Refiere que el manchado es menor que una regla. En la ecografía se objetiva un endometrio de 7 mm. Señale la opción correcta:

1. El endometrio está engrosado y ante la clínica de la paciente, toma una biopsia endometrial con cánula de Cornier.
2. El endometrio no está engrosado por lo que le pauta ácido tranexámico y seguimiento ambulatorio.
3. Tiene indicación de histeroscopia diagnóstica sin necesidad de toma de biopsia endometrial.
4. El endometrio no está engrosado, pero como tiene clínica de metrorragia está indicada la realización de una biopsia endometrial.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta fácil. De nuevo nos presentan un caso clínico sobre el cáncer de endometrio. Debéis sospecharlo ante una

metrorragia postmenopáusica que se acompaña de engrosamiento endometrial (superior o igual a 3 mm), y la actitud correcta es tomar una biopsia (de elección mediante histeroscopia).

74. Primigesta de 34 semanas que presenta cifras tensionales de 165/95 y cefalea de dos días de evolución. Analítica: hemoglobina 10,5 g/dL, plaquetas 98.000/mm³, AST 356 UI/L (0-31), ALT 234 UI/L (0-31), LDH 878 UI/L (125-243). Llamam del laboratorio por presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica. Ha recibido la segunda dosis de corticoides para maduración fetal hace 24 h. En la ecografía obstétrica el peso fetal estimado está en el percentil 1 para la edad gestacional y el Doppler de arteria umbilical presenta ausencia del flujo telediastólico. ¿Cuál de las siguientes es la actitud clínica más indicada?:

1. Actitud expectante con antihipertensivos y sulfato de magnesio hasta la mejora de las plaquetas maternas.
2. Actitud expectante con tratamiento antihipertensivo a domicilio y controles cada 48 h.
3. Finalización de la gestación cuando complete la maduración pulmonar fetal.
4. Finalización inmediata de la gestación.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Nos presentan un caso clínico del síndrome de HELLP, un subtipo de preeclampsia grave, en una gestación de 34 semanas que además tiene un feto CIR (peso fetal estimado en percentil 1 y flujo diastólico ausente en arteria umbilical: signo ominoso). Dada la edad gestacional, está indicado finalizar la gestación.

75. Mujer de 30 años que solicita un método anticonceptivo. Como antecedentes tiene una cesárea urgente hace 7 meses, naciendo una niña de 3.550 g. Está dando lactancia materna exclusiva. Señale la afirmación correcta:

1. Le explica que, si está en amenorrea, no requiere de otro método anticonceptivo puesto que la lactancia materna es suficiente como método anticonceptivo.
2. Le informa que el DIU de levonogestrel está contraindicado por haber tenido una cesárea hace menos de un año.
3. Le explica que podría usar un método hormonal de sólo gestágenos.
4. Le ofrece anticoncepción hormonal combinada.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta de dificultad media acerca de la anticoncepción

hormonal durante la lactancia materna. Pasados 6 meses postparto se asume que el periodo de máximo riesgo tromboembólico ha finalizado y podrían administrarse preparados combinados; sin embargo, los estrógenos disminuyen la excreción de la leche, por lo que si la paciente continúa con lactancia materna son de elección los anticonceptivos de sólo gestágenos (en cualquiera de sus presentaciones: DIU, implante, minipíldora...).

76. Mujer de 40 años que consulta porque desde hace un mes se nota un bulto en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Aporta un informe de una mamografía que describe una lesión BIRADS 3. ¿Cuál es la actitud a seguir?:

1. Tranquilizarle, puesto que ya se ha hecho una prueba de imagen y se ha descartado malignidad.
2. Esa clasificación implica probablemente cirugía dado que la probabilidad de cáncer es mayor del 10 %. Se lo explica y le deriva de forma preferente a la Unidad de Mama.
3. Se trata de un hallazgo probablemente benigno, dado que hay menos de un 2 % de probabilidad de cáncer. Le explica que requiere de un seguimiento cada 6-12 meses hasta los 24 meses o una biopsia.
4. Los hallazgos son de baja sospecha de cáncer (entre un 2 y un 10 %) pero es necesario hacer una biopsia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media acerca de la clasificación radiológica de las lesiones mamarias, denominada BI-RADS. Se aplica tanto a las mamografías como a las ecografías de mama. Debéis conocer aquellos BI-RADS que obligan a tomar una determinada actitud por parte del médico: BI-RADS 0 obliga a complementar con otra prueba de imagen distinta; BI-RADS 3 obliga a repetir la prueba en 6-12 meses; y BI-RADS 4 y 5 obligan a realizar una biopsia (BAG/BAV) para descartar malignidad.

77. Siguiendo las indicaciones del cribado del cáncer de cérvix ¿a qué mujer realizaría una citología entre las siguientes candidatas?:

1. Mujer de 26 años sin citologías previas.
2. Mujer de 40 años con citología y virus del papiloma humano negativos hace 3 años.
3. Mujer de 67 años con incontinencia urinaria de esfuerzo.
4. Mujer de 22 años vacunada para el virus del papiloma humano e inicio de relaciones sexuales hace 1 año.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre el cribado del cáncer de cérvix, que ac-

tualmente es universal en todo el territorio nacional. La primera citología está indicada a los 25 años y se repite cada 3 años hasta los 35. A los 35 años está indicado realizar una prueba cada 5 años, siendo de primera elección la detección del VPH. El cribado se finaliza a los 65 años.

78. En una enfermedad genética con un patrón de herencia autosómico dominante el riesgo de recurrencia de la enfermedad en una futura descendencia es de:

1. 25 % en cada embarazo.
2. 50 % en cada embarazo en caso de que el hijo sea un varón.
3. 50 % en cada embarazo siempre que la pareja sea también portadora.
4. 50 % en cada embarazo independiente del sexo de la descendencia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La transmisión de herencia autosómica dominante es vertical e independiente del sexo. Un individuo enfermo heterocigoto tiene un 50% de probabilidad de tener descendientes afectados, por lo que la respuesta correcta es la 4. No se considera el estado de portador. En cambio, en la herencia autosómica recesiva, si los padres son heterocigotos (Aa), la frecuencia de tener un descendiente afecto homocigoto (aa) es del 25%, un 25% de sanos en homocigosis (AA) y un 50% de portadores sanos (Aa)

79. En caso de que haya manifestaciones clínicas ¿cuál es la forma clínica más frecuente de primoinfección por el virus del herpes simple tipo 1 en lactantes y niños pequeños?:

1. Meningitis.
2. Genital.
3. Neumonía.
4. Gingivostomatitis y faringitis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La primoinfección por VHS-1 se manifiesta típicamente en forma de gingivostomatitis y faringitis tanto en niños como en adultos.

80. Lactante de 2 meses de edad con catarro de vías altas de 3 días de evolución, que comienza con dificultad respiratoria moderada y auscultación pulmonar con sibilancias espiratorias. La saturación de oxígeno es de 89 %. Se aísla virus respiratorio sincitial en el exudado nasofaríngeo. ¿Cuál de los siguientes tratamientos considera más indicado para este cuadro?:

1. Rivabirina oral.
2. Salbutamol nebulizado.
3. Oxígeno suplementario.
4. Corticoides intravenosos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre una patología clásica en el MIR, la bronquiolititis. En este caso nos preguntan por el tratamiento, que no es otra cosa más que soporte respiratorio + nutrición en caso de necesitarlo. Por tanto, opción correcta 3: oxígeno suplementario. Recordad que ni los antibióticos ni los corticoides han demostrado utilidad frente a esta patología de forma rutinaria.

81. Con respecto a las comunicaciones interventriculares (CIV) en la infancia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Exceptuando la válvula aórtica bicúspide, la CIV es la cardiopatía congénita más frecuente.
2. Las CIV localizadas en la porción media y apical del tabique interventricular son de tipo muscular.
3. La repercusión clínica y la necesidad de tratamiento dependen del tamaño de la comunicación.
4. Las CIV membranosas son las más frecuentes y la que tienen más probabilidad de cierre espontáneo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre cardiopatías congénitas. La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente en neonatos y la segunda en adultos después de la valvulopatía aórtica bicúspide. Se trata de defectos del cierre del tabique interventricular, en su mayoría (80%) en la porción membranosa (parte más proximal del tabique). Aunque esta localización es proclive al cierre espontáneo, la localización más asociada a la autorresolución es la CIV muscular.

82. Con respecto al síndrome de dificultad respiratoria neonatal (enfermedad de la membrana hialina), señale la respuesta FALSA:

1. Los corticoides antenatales reducen el riesgo de su aparición.
2. Sus manifestaciones clínicas aparecen a partir de las 24 horas de vida.
3. El riesgo de aparición disminuye ante una rotura prematura de membranas.
4. Su causa principal es el déficit de surfactante pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Concepto sobre la etiología, clínica y factores protectores de la enfermedad de membrana hialina. Para poder evitarla o adelantarnos a ella, recordad que la rotura prematura de membranas se ha propuesto, de forma aislada, como un factor estresante para el recién nacido que, por tanto, que puede favorecer la maduración pulmonar. La clínica siempre será de aparición muy precoz, nada más nacer, de ahí que la op-

ción 2 sea la respuesta falsa.

83. La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica congénita. En relación con la misma, indique la contestación FALSA:

1. La fenilalanina debe suprimirse en la dieta completamente.
2. La discapacidad intelectual es constante y progresiva en caso de no realizar bien la dieta.
3. Puede deberse a un déficit de tetrahidrobiopterina BH4.
4. Se recomienda su estudio a las 24-48 horas del inicio de la ingesta del recién nacido.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja sobre una enfermedad metabólica, por lo tanto una entidad poco frecuente. La fenilcetonuria es una patología que afecta a la transformación de fenilalanina (aminoácido esencial) en tirosina. Al ser un aminoácido esencial, no puede suprimirse completamente de la dieta (respuesta 1 correcta). En un individuo sano, la enzima hepática fenilalanina hidroxilasa (PAH), cataliza la conversión de la fenilalanina en tirosina. La tetrahidrobiopterina (BH4) es un cofactor necesario para la actividad de PAH, además del oxígeno molecular y el hierro. La fenilcetonuria está causada mayoritariamente por el déficit de PAH; esto da como resultado concentraciones elevadas en sangre y orina de fenilalanina y sus metabolitos, fenilacetato y fenil-lactato. Las concentraciones de tirosina suelen estar en el rango normal, aunque, ocasionalmente, se observan concentraciones bajas. Se sabe que los defectos en el metabolismo de BH4 representan aproximadamente el 2% de los pacientes con niveles elevados de fenilalanina (respuesta 3 falsa). Esta patología se detecta mediante prueba de screening (análisis de sangre) a las 24-72h después del parto, cuando el recién nacido ha iniciado ya la ingesta (respuesta 4 falsa). Requiere una dieta especial baja en fenilalanina, para lo que se requieren fórmulas nutricionales especiales (mezclas de aminoácidos) durante el periodo neonatal, y una dieta cuidadosa durante la infancia, pues las necesidades proteicas globales son las mismas. Si no se realiza esta dieta la enfermedad progresa causando retraso psicomotor con alteraciones conductuales (agresividad, alteración del sueño, automutilaciones) y del desarrollo físico (respuesta 2 falsa).

84. En una enfermedad genética neurológica, el fenómeno de anticipación implica la aparición de las manifestaciones más precozmente y en general de forma más grave en la siguiente generación. Dado que la anticipación ocurre por la expansión de trinucleótidos, indique en cuál de estas enfermedades es posible esperar este fenómeno:

1. Atrofia muscular espinal.
2. Distrofia muscular de Duchenne.
3. Enfermedad de Parkinson.
4. Distrofia miotónica de Steinert.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto repetidamente preguntado: la distrofia miotónica de Steinert es una enfermedad por expansión de tripletes, en concreto el triplete CTG. Las enfermedades por expansión de tripletes presentan en fenómeno de anticipación, que consiste en la aparición de la enfermedad a una edad más precoz y más grave en las sucesivas generaciones, y que se observa más frecuentemente cuando el transmisor del gen es el padre. La atrofia muscular espinal (AME) está causada por una mutación en el gen SMN1. En cambio, la atrofia muscular espinoBULBAR o enfermedad de Kennedy, sí es una enfermedad por expansión de triplete (triplete CAG). La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad recesiva ligada al X, y la enfermedad de Parkinson se ha relacionado con mutaciones en diversos genes.

85. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más común en niños. En relación con su diagnóstico, señale la respuesta FALSA:

1. Debemos sospecharlo ante la aparición de un síndrome opsoclono-mioclono-ataxia.
2. Existe casi siempre un aumento en la excreción urinaria de metabolitos de catecolaminas.
3. La mayoría se diagnostica en menores de 6 años de edad.
4. La gammagrafía con tecnecio es muy específica y está indicada para definir mejor su extensión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta compleja sobre Oncología infantil, en concreto sobre el neuroblastoma, tumor sólido más frecuente en la edad pediátrica tras los tumores del sistema nervioso central. Todas las opciones referidas son correctas sobre esta patología salvo la 4, ya que la gammagrafía es muy útil en esta patología pero con MIBG (metayodobenzilguanidina), no con tecnecio.

86. ¿Cuál de los siguientes NO es indicación de realizar inmunoprofilaxis con palivizumab en un lactante?:

1. Lactante nacido antes de las 29 semanas de gestación en el primer año de vida.
2. Lactante nacido antes de las 32 semanas de gestación con enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad en el primer año de vida.
3. Lactante diagnosticado de fibrosis quística de páncreas en el cribado neonatal durante el primer año de vida.
4. Lactante de 12 meses afecto de inmunodeficiencia severa combinada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Concepto de dificultad media-alta por obligar a reconocer las indicaciones de palivizumab en los pacientes pediátricos,

que suelen englobar a los pacientes prematuros (sobre todo menores de 29- 32 semanas), así como lactantes con patología respiratoria, neuromuscular, cardiopatías o inmunodeficiencias. La opción 3 es incorrecta, ya que aunque hablan de una fibrosis quística, inciden en que es una forma puramente pancreática, por lo que no es indicación de profilaxis.

87. Con respecto al síndrome de muerte súbita del lactante, señale la afirmación correcta:

1. La presencia de antecedentes de muertes similares en hermanos/familiares es criterio diagnóstico de este síndrome.
2. Ante un episodio de muerte súbita infantil se debe firmar el certificado ordinario de defunción por el facultativo del servicio de urgencias.
3. La edad del niño superior a 1 año excluye el diagnóstico, independientemente de que se trate o no de lactantes.
4. La existencia de una patología grave diagnosticada en la autopsia es criterio diagnóstico de este síndrome.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre un concepto hace tiempo no recogido en el MIR. En la muerte súbita del lactante no se conoce la causa de la muerte tras realizar una autopsia al paciente, lo cual implica que no se debe firmar un certificado ordinario de defunción, si no que debemos “judicializar” la muerte hasta conocer los resultados de la autopsia. Tener antecedentes no es diagnóstico de este síndrome, pero, sin embargo, la edad sí que es excluyente, ya que los pacientes afectados deben tener todos menos de un año. Opción 3 correcta.

88. Niño de 23 meses que presenta fiebre, hipotensión, vómitos repetidos, signos meníngeos, petequias y equimosis. El hemograma muestra 25.000 leucocitos (75 % neutrófilos, 10 % cayados) y 12.000 plaquetas/microL y el estudio de coagulación una actividad de protrombina de 35 %. ¿Qué opción NO es adecuada en su manejo?:

1. Administración de cefotaxima intravenosa.
2. Realización de punción lumbar.
3. Recogida de hemocultivo.
4. Fluidos intravenosos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las plaquetas forman parte de la hemostasia primaria y son claves para evitar sangrados. Una trombocitopenia se considera clínicamente relevante cuando las plaquetas son inferiores a 100.000 aunque los sangrados espontáneos son excepcionales con cifras de plaquetas >20.000. De cara a realizar procedimientos, como cirugías o técnicas invasivas, es recomendable que el paciente presente plaquetas >50.000, con excepción de los procedimientos en el globo

ocular o en el SNC, en los cuales los sangrados pueden ser críticos, por lo que en ellos se requieren plaquetas superiores a 100.000 para realizarse con seguridad. En este caso, al tratarse de un niño con trombopenia grave, con plaquetas inferiores a 100.000, que serían las necesarias para realizar una punción lumbar (procedimiento sobre en SNC), ésta no debería realizarse (respuesta 2 correcta).

89. Niña de 4 años que presenta fiebre alta de 6 días de evolución. En la exploración clínica presenta un exantema eritematoso maculopapular en tronco y zona genital, con tendencia a la confluencia, sin llegar a ser escarlatiniforme; inyección conjuntival sin secreciones y labios rojos con lengua aframbuesada. Presenta también eritema con edema en manos y pies y una adenopatía cervical unilateral de 2 cm de diámetro. El diagnóstico clínico de sospecha más probable es:

1. Enfermedad de Kawasaki.
2. Sarampión.
3. Rubeola.
4. Escarlatina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Cuestión muy clásica y sencilla de reconocer tras evidenciar los criterios diagnósticos: fiebre de más de 5 días + “cosas rojas” como exantema, labios e inyección conjuntival + adenopatía + edema de pies y manos: enfermedad de Kawasaki (opción 1 correcta).

90. Dentro de las cardiopatías cianóticas destaca la tetralogía de Fallot. En relación con este cuadro, señale la respuesta INCORRECTA:

1. En la prueba de hiperoxia con O₂ al 100 % no se eleva significativamente la saturación de O₂.
2. Es típica la presencia de hiperaflujo sanguíneo pulmonar.
3. Ante toda sospecha debe administrarse precozmente una perfusión de prostaglandina E₁.
4. La silueta cardíaca presenta la típica imagen de corazón en bota.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta que puede asustar de inicio pero que es fácilmente acertable: tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Consiste, entre otros hallazgos, de una estenosis del tracto de salida de VD, con CIV acompañante que implica: 1) dificultad para la evacuación de sangre a la arteria pulmonar (por la obstrucción), lo que produce hipoaflujo pulmonar, y 2) shunt derecha > izquierda sobre la CIV. Es una causa a descartar ante un recién nacido cianótico. Uno de los tests de utilidad es el de la hiperoxia, en el cual, si la causa es pulmonar típicamente se produce un aumento de la saturación arterial de

oxígeno, mientras que en caso de las cardiopatías congénitas la respuesta es escasa o nula. La prostaglandina E i.v. se recomienda junto con otra serie de medidas generales en las cardiopatías congénitas cianóticas para permitir la estabilización y como puente a tratamientos más avanzados.

91. ¿Cuál de las siguientes NO es una indicación para la realización de pruebas de neuroimagen en psiquiatría?:

1. Trastorno mental de inicio después de los 50 años.
2. Crisis convulsivas con síntomas psiquiátricos.
3. Recaída psicótica al suspender el tratamiento tras un primer episodio psicótico.
4. Presencia de síntomas psiquiátricos atípicos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta novedosa acerca de las indicaciones de prueba de neuroimagen en Psiquiatría. La recaída psicótica es algo probable con la suspensión del tratamiento, más en el tiempo inmediatamente posterior a un episodio previo, de ahí la recomendación de realizarse un tratamiento prolongado. Como norma general se recomendaría realizar una prueba de imagen (TC o RM) ante cualquier debut de clínica psicótica, cuando aparece un trastorno mental en edad avanzada (respuesta 1), si hay precedente o aparece clínica neurológica (respuesta 2), o la presentación es atípica (respuesta 4).

92. Mujer de 75 años traída a consulta por su familia porque le encuentran desde hace meses deprimida y con fallos de memoria. Les preocupa que pueda tener una enfermedad de Alzheimer. La paciente refiere que no cree que le pase nada y que está como siempre. ¿En qué orden se presentan generalmente los siguientes síntomas en la progresión de la enfermedad de Alzheimer?:

1. Cambios de humor, síntomas conductuales, déficit cognitivo.
2. Síntomas conductuales, síntomas motores, declive de la independencia funcional.
3. Cambios de humor, déficit cognitivo, declive de la independencia funcional.
4. Síntomas conductuales, cambios de humor, síntomas motores.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la enfermedad de Alzheimer podemos observar a grandes rasgos dos tipos de sintomatología psiquiátrica: por un lado los cambios de humor, depresión o apatía, que suelen aparecer de forma precoz en la evolución de la enfermedad; y, por otro lado, los trastornos conductuales, que aparecen de forma más tardía, normalmente después de que ya se haya instaurado un déficit cognitivo manifiesto y normalmente asociado a declive funcional.

93. Varón de 35 años de edad, casado y padre de tres hijos, que ingresa en el hospital por una fractura de tobillo complicada. Al segundo día se le notó nervioso y comenzó a temblar. Se le interroga acerca de posibles hábitos tóxicos y los niega, explicando que ocasionalmente bebe una cerveza. La esposa señala que desde hace tres años consume cantidades importantes de cerveza diariamente y ocasionalmente se muestra violento. Al día siguiente las enfermeras informan de que ha dormido mal, está muy ansioso y dice incoherencias, estando desorientado en el tiempo. De las siguientes pautas terapéuticas ¿cuál es la más adecuada?:

1. Benzodiacepinas de vida media larga y clometiazol.
2. Benzodiacepinas de vida media corta y betabloqueantes.
3. Benzodiacepinas de vida media larga y carbamacepina.
4. Benzodiacepinas de vida media corta y clozapina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre delirium tremens, expresión clínica grave del síndrome de abstinencia al alcohol y que, como sucede en el caso presentado en la pregunta, aparece a las 48-72 horas con cuadro clínico de estado confusional acompañado de vegetativismo y alucinaciones visuales zoomórficas. El tratamiento recomendado son las benzodiazepinas de vida media larga (descartadas 2 y 4) y clometiazol (derivado de la tiamina con efecto sedante y anticonvulsivante); respuesta correcta: 1.

94. Varón que consulta porque hace 1 mes falleció su madre, tras un largo periodo de enfermedad neurodegenerativa. A pesar del tiempo transcurrido sigue presentando dificultades del sueño ocasionales y problemas para aceptar su muerte, sintiendo gran añoranza y elevada emocionabilidad cuando la recuerda o le hablan de ella. Por otra parte, si está distraído es capaz de disfrutar algo y en el trabajo su desempeño es prácticamente normal. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA?:

1. El diagnóstico es duelo (Z63.4, según la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE-10-).
2. Si las dificultades del sueño tienen consecuencias sobre la vigilia del día siguiente podría prescribirle temporalmente un fármaco hipnótico.
3. Dado el tiempo transcurrido se debería instaurar un antidepresivo a dosis bajas.
4. Es conveniente darle una nueva cita al cabo de 1-2 meses para ver su evolución.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico de duelo, que es la reacción emocional derivada de la pérdida, fundamentalmente, de un ser querido. No es indicativo de tratamiento farmacológico (respuesta 4 falsa) ya que es un proceso y vivencia necesaria para hacer frente a la nueva situación; si fuese preciso un tratamiento, se indicaría de forma sintomática y temporal (como recoge la respuesta 3).

95. Mujer de 23 años que consulta por presentar desde hace 2 meses crisis repentinas y recurrentes de ansiedad con palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo y dolor torácico. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

1. En la evolución es frecuente encontrar agorafobia y conductas de evitación.
2. En el diagnóstico diferencial se deben considerar feocromocitoma, tirotoxicosis e hipoglucemia.
3. Es preciso descartar una taquicardia auricular paroxística.
4. El diagnóstico más probable es un trastorno por ansiedad generalizada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta acerca del diagnóstico diferencial de los trastornos de ansiedad. En el enunciado hace referencia a crisis recurrentes e inesperadas, con lo que se establecería como diagnóstico más probable un trastorno de pánico, lo que descartaría un trastorno de ansiedad generalizada (por tanto, respuesta falsa: 4).

96. Sobre los factores de riesgo de suicidio, indique de entre los siguientes el factor con MENOS riesgo:

1. Abuso de sustancias.
2. Evento estresante de larga duración.
3. Trastorno de pánico coexistente.
4. Edad avanzada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de complejidad media. Sabemos que el consumo de sustancias y la edad avanzada son factores de riesgo de suicidio. Podríamos dudar entre la 2 y la 3. A priori podríamos dudar que un trastorno de pánico sea un factor de riesgo, pero la evidencia científica arroja que más de la mitad de los pacientes con un trastorno de pánico tienen un trastorno depresivo asociado, lo que eleva el riesgo de suicidio. Los trastornos de ansiedad potencian la tendencia suicida, aumentando la ideación suicida y desesperanza.

97. Señale la afirmación correcta en relación con el tratamiento de la manía:

1. El tratamiento habitual en las primeras 48 horas se basa en benzodiacepinas en monoterapia por vía parenteral.
2. La clozapina es el fármaco de elección para el tratamiento agudo.
3. La combinación de litio y antipsicóticos está contraindicada en las fases iniciales del tratamiento.
4. En casos graves o resistentes puede utilizarse la terapia electroconvulsiva.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento agudo de la manía incluye politerapia, con varias opciones: antipsicótica y benzodiacepinas; antipsicótica y estabilizadora; e incluso antipsicótica más estabilizadora más benzodiacepinas. El litio es un buen fármaco antimaniaco y la terapia electroconvulsiva es de elección en manías resistentes. Por lo tanto, la respuesta verdadera es la 4.

98. Respecto a la utilización de estimulación magnética transcraneal repetitiva en los trastornos psiquiátricos, señale la respuesta correcta:

1. Es especialmente útil en trastornos psiquiátricos secundarios a la epilepsia.
2. Tiene una eficacia superior a la terapia electroconvulsiva.
3. Está indicada en la depresión resistente al tratamiento farmacológico.
4. Por su seguridad, es el tratamiento de elección en la esquizofrenia de inicio tardío.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta novedosa sobre un tratamiento biológico en Psiquiatría, hasta la fecha no preguntado: la estimulación magnética transcraneal (EMT). La EMT consiste en la aplicación de un campo magnético en la corteza cerebral, que a su vez induce pequeñas corrientes eléctricas en dicha zona. Esto se consigue colocando un electroimán en el cuero cabelludo. Se trata, por tanto, de una técnica local, no invasiva y que no requiere la administración de anestesia, a diferencia de la TEC. Su principal indicación es la depresión resistente. Sin embargo, su efecto es muy limitado, por lo que no se recomienda en casos severos o urgentes, en cuyo caso la TEC seguiría siendo el tratamiento gold standard. Los efectos secundarios son infrecuentes, siendo el principal la inducción de una crisis epiléptica.

99. Ante un síndrome depresivo en un varón de 68 años sin antecedentes psiquiátricos, señalar cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

1. La presencia de desorientación, apatía y pérdida de memoria orienta hacia el diagnóstico de demencia.

2. La presencia de temblor de reposo, marcha sin balanceo y amimia facial orienta el diagnóstico hacia enfermedad de Parkinson.
3. La presencia de hipercolesterolemia, bradipsiquia, bradicardia y estreñimiento orienta hacia el diagnóstico de hipotiroidismo.
4. El inicio reciente de tratamiento con betabloqueantes y antiinflamatorios no esteroideos puede justificar la aparición de un síndrome depresivo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una pregunta muy difícil, en relación a la etiología de la depresión secundaria. Entre las causas, se encuentran la enfermedad de Parkinson (respuesta 2 correcta), el hipotiroidismo (respuesta 3 correcta) y los AINES y beta-bloqueantes (respuesta 4 correcta). También aparece la demencia, pero la depresión suele aparecer en las fases avanzadas de la misma, por lo que la respuesta menos correcta sería la 1.

100. Mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus que presenta de forma brusca una alteración del lenguaje. A su llegada al hospital se objetiva una fibrilación auricular no conocida y en la exploración presenta habla fluente con tendencia a la jergafasia, mala comprensión del lenguaje, incapacidad para la repetición y disnomia. Semiológicamente presenta un cuadro compatible con:

1. Afasia de Broca.
2. Afasia de conducción.
3. Afasia transcortical sensitiva.
4. Afasia de Wernicke.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta prototipo de afasias, en este caso de inicio brusco en una paciente diabética e hipertensa con una FA de novo, por lo que debemos pensar en un ictus. Siguiendo el esquema básico: es fluente, por tanto sensitiva (eliminamos la opción 1). No repite, por lo que descartamos la opción 3 (las afasias transcorticales, tanto sensitiva como motora, tienen la repetición preservada). Entre la 2 y la 4 debemos saber que la afasia de conducción tiene la comprensión conservada, por lo que la opción correcta es la 4, afasia de Wernicke.

101. Todas las siguientes enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con una alteración en la proteína Tau, EXCEPTO:

1. Enfermedad de Alzheimer.
2. Demencia frontotemporal.
3. Enfermedad de Parkinson.
4. Parálisis supranuclear progresiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia. El Parkinson cursa con depósito de alfa-sinucleína (o cuerpos de Lewy), respuesta correcta la 3. Recordad que todas las "sinucleinopatías" presentan los mismos síntomas no motores prodrómicos: depresión, estreñimiento, ortostatismo, hiposmia y trastorno de conducta del sueño REM. Las tres sinucleinopatías que hay que conocer son: Parkinson, enfermedad por cuerpos de Lewy difusos y atrofia multisistema.

102. Mujer de 29 años con antecedentes de crisis febriles y fumadora importante. Consulta por presentar desde hace unos 2 años episodios frecuentes, estereotipados, que comienzan con una sensación epigástrica ascendente y un olor desagradable, seguidos de desconexión del medio. Los familiares que están con ella observan que hace movimientos de chupeteo y de apertura y cierre repetidos de la mano izquierda. Pasados dos minutos los movimientos ceden, pero le cuesta responder adecuadamente y solo recuerda parcialmente lo ocurrido. De los siguientes ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Crisis focales complejas del lóbulo temporal.
2. Accidentes isquémicos transitorios en territorio carotídeo derecho.
3. Crisis focales simples motoras.
4. Episodios de amnesia global transitoria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que describe una crisis focal con alteración de consciencia (empieza con aura y otros datos semiológicos focales y se sigue de desconexión), llamada crisis parcial compleja en la clasificación antigua. Aunque la opción 1 mezcla ambas clasificaciones (focal compleja), es la opción más correcta. La semiología es la característica del lóbulo temporal (aura epigástrica ascendente y olfativa seguida de desconexión con automatismos orales y manuales), y debemos saber reconocerla porque es el tipo de epilepsia focal más frecuente. En nuestro medio, la causa más frecuente es la esclerosis hipocámpal (o temporal mesial), destacando su relación con el antecedente de convulsiones febriles en la infancia.

103. Varón de 30 años que consulta por cefaleas perioculares unilaterales que progresan rápidamente hasta hacerse muy intensas. Las crisis de dolor duran entre 30-60 minutos, ocurren 23 veces al día y se acompañan de lagrimeo en el ojo que le duele y rinorrea unilateral. ¿Cuál es el tratamiento preventivo más adecuado?:

1. Prednisona oral con retirada en 2-3 meses.
2. Prednisona oral con retirada en un mes, asociada a verapamilo oral a dosis de 80-180 mg cada 8 horas.
3. Carbamazepina a dosis de 600-1200 mg al día.

4. Indometacina a dosis de 50 mg cada 8 horas durante un mes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre la cefalea en racimos y el tratamiento preventivo que se responde fácilmente con el manual.

104. En un paciente con una parálisis facial periférica (parálisis de Bell) izquierda ¿cuál de los siguientes signos o síntomas NO esperaría encontrar?:

1. Hiperacusia izquierda.
2. Hipoestesia de la hemicara izquierda.
3. Hipogeusia.
4. Falta de lagrimeo en el ojo izquierdo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa sobre la parálisis facial y la afectación del nervio facial. En su recorrido se encarga del lagrimeo (Nervio petroso mayor), el reflejo estapedial (Nervio estapedial), pudiendo provocar hiperacusia y algiacusia y el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua (Nervio cuerda del timpano) y de la musculatura de la cara, pero NO DE LA SENSIBILIDAD (Trigémino), por lo que la respuesta correcta es la 2, hipoestesia de la hemicara izquierda.

105. Varón de 45 años traído a la consulta por sus familiares por un cuadro de un año de evolución de pérdida de memoria, que ha ido progresando hasta necesitar ayuda para algunas actividades de su vida cotidiana. Tiene antecedentes de migrañas y algún episodio de focalidad neurológica autolimitada por los que no ha consultado nunca. La exploración neuropsicológica es compatible con una demencia inicial y la RM cerebral muestra una leucoencefalopatía grave. ¿Qué prueba habría que solicitar?:

1. Punción lumbar para analizar amiloide y proteína tau en LCR.
2. Estudio genético para presenilina 1 (PSEN1).
3. Estudio genético para NOTCH3.
4. Estudio genético para progranulina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El CADASIL es una enfermedad genética infrecuente de pequeño vaso cerebral que se caracteriza por paciente joven con leucoencefalopatía vascular (afectación isquémica de sustancia blanca o leucoaraiosis), migraña con aura, ictus/AIT de repetición y deterioro cognitivo. Pregunta difícil pues preguntaban el gen implicado: Notch3.

106. Con respecto al tratamiento de la hipertensión intracraneal NO es una medida aceptada:

1. Elevar la cabeza del enfermo y mantener la cabeza centrada.
2. El drenaje de LCR a través de un drenaje lumbar.
3. La hiperventilación moderada.
4. Los glucocorticoides en algunas circunstancias.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica sobre el manejo de la hipertensión intracraneal (HTIC). Nos deberían especificar si la pregunta es sobre el abordaje de la HTIC aguda o crónica, pero podemos deducir por las opciones de respuesta que preguntan el manejo de la HTIC aguda. En este caso, lo primero es intentar tratar la causa del cuadro. Luego, el manejo inicial incluye medidas generales como la postura (cabecera elevada a 30° y evitar flexión o rotación del cuello que dificulte el drenaje venoso craneal), control de la presión arterial y de la temperatura. Medidas más específicas incluyen terapias osmóticas (manitol), corticoides para tratar el edema vasogénico e hiperventilación. En casos refractarios, puede ser necesario recurrir a hiperventilación, coma barbitúrico, hipotermia, drenaje ventricular para una evacuación controlada de LCR o incluso una craneotomía descompresiva. Un drenaje lumbar está normalmente contraindicado en el contexto de una HTIC aguda por el riesgo de herniación transtentorial.

107. Varón de 55 años que sufre una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma de arteria cerebral media. Es tratado de forma quirúrgica. Tras una buena evolución en la que recupera la capacidad de caminar, un mes después de sufrir la hemorragia presenta un deterioro progresivo, llegando a encontrarse obnubilado y con dificultad para obedecer órdenes. Señale la afirmación correcta:

1. Se encuentra en el momento de la evolución en el que es más frecuente el vasoespasmio.
2. Probablemente este deterioro progresivo sea secundario al resangrado del aneurisma.
3. El deterioro subagudo que presenta con mayor probabilidad se debe a hidrocefalia.
4. La técnica diagnóstica de elección es la angiografía cerebral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La hidrocefalia es una complicación de la HSA que puede ser precoz (en fase aguda, por presencia de sangre en el sistema ventricular y cisternas) o tardía (tras varias semanas puede producirse una hidrocefalia comunicante en caso de que los restos de sangre bloqueen las granulaciones aracnoideas, donde se absorbe el LCR). En este último caso, la clínica es no focal y se va instaurando de forma progresiva en forma de alteración del estado mental, cefalea, alteración de la marcha... La opción 2 es incorrecta porque esperaríamos una instauración súbita de los síntomas. El vasoespasmio, que es con la que podemos dudar, suele producirse antes (habitualmente durante las primeras dos semanas), además

de ser de instauración brusca/aguda y dar clínica focal (hemiparesia, afasia...). Además podemos ayudarnos con técnica de examen: si la 1 fuese correcta, la 4 lo sería también, por lo que ninguna de las dos puede serlo.

108. Varón de 49 años que ingresa en UCI por un traumatismo craneoencefálico tras un accidente laboral. En la exploración física no abre ojos, no emite sonidos antes de ser intubado y presenta extensión de extremidades al estímulo nociceptivo. Se coloca un sensor de presión intracraneal y debe realizarse una craneotomía descompresiva por una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. A su llegada se encuentra en un coma de la escala de Glasgow de 7.
2. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media más la presión intracraneal.
3. El edema cerebral vasogénico se produce por edema celular, rotura de la membrana y muerte celular.
4. El flujo vascular cerebral aumenta con la hipercapnia y la acidosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La respuesta 1 es falsa si conocemos la escala de Glasgow, puesto que puntúa 4 (E1, V1, M2). El resto son de fisiopatología. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media MENOS la presión intracraneal (a más presión intracraneal más dificultad para que llegue la sangre al cerebro, por ello en la tríada de Cushing de la hipertensión intracraneal se produce hipertensión arterial como mecanismo reflejo para mantener la presión de perfusión cerebral). El edema vasogénico se produce por aumento de permeabilidad capilar y extravasación de plasma al espacio extracelular (en la opción 3 están describiendo el edema citotóxico). La 4 es la opción correcta: ante la presencia de hipercapnia y acidosis, se produce una vasodilatación (tanto cerebral como en el resto de tejidos del organismo, por eso se nos enrojece la cara si hacemos una apnea). Esto, que es un mecanismo de defensa para aumentar la presión de perfusión cerebral en situaciones de estrés, puede volvérsenos en contra contribuyendo a generar más hipertensión intracraneal en el paciente con TCE.

109. Respecto a la sedación del paciente crítico en ventilación mecánica en la UCI ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Los bloqueantes neuromusculares están indicados cuando el paciente presenta asincronías, independientemente del grado de analgesia y sedación.
2. Se prefieren los sedantes no benzodiazepínicos debido a que las benzodiazepinas se relacionan con peor resultado clínico.
3. La interrupción diaria de la sedación no acorta

el tiempo de ventilación mecánica ni la estancia en UCI.

4. El paracetamol es el principal agente farmacológico para lograr una adecuada analgesia en los pacientes intubados y ventilados mecánicamente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La relajación neuromuscular está indicada para adaptar al paciente al ventilador, sobre todo cuando se detecta ausencia de correcto acoplamiento o asincronías. Esta técnica, que usa bloqueantes neuromusculares como en una intervención quirúrgica, ha demostrado aumentar la supervivencia en los enfermos críticos respiratorios que requieren ventilación mecánica. En cuanto a la sedación de un paciente intubado, ya sea para lograr un grado basal de confort como para control sintomático de la agitación, se prefieren agentes no benzodiazepínicos, como el propofol, la dexketomidina u otros agonistas alfa-2 adrenérgicos, los antipsicóticos sedantes como haloperidol, quetiapina, olanzapina, e incluso ketamina. Las benzodiazepinas se emplean como último recurso por múltiples motivos: se desarrolla tolerancia, pueden desencadenar abstinencia o delirio paradójico, se acumulan en el tejido adiposo durante larga vida media, y se han asociado a mayor tiempo de duración de la intubación en comparación con propofol o dexketomidina, así como a un incremento de complicaciones como síndrome de estrés post-traumático y encefalopatía post-UCI. El paracetamol fijo pautado se utiliza como analgésico complementario a los opiáceos (morfina, fentanilo, remifentanilo), que son los analgésicos principales del paciente intubado, para ahorrar uso de narcóticos; se asocia con menores efectos adversos y además, previene la fiebre. El cuanto a la interrupción diaria de la sedación, el concepto básico aquí es detener las infusiones de sedantes y opioides y volver a titular diariamente, para asegurarnos de que estamos usando la dosis más baja posible y detectar cuándo se produce el día adecuado para la extubación.

110. El osteosarcoma es un tumor óseo maligno que:

1. Es más frecuente en la primera década de la vida.
2. Su tratamiento con quimioterapia y radioterapia suele evitar la cirugía.
3. Afecta más frecuentemente a huesos en la proximidad de la articulación de la rodilla.
4. Si presenta enfermedad de Paget previa tiene un mejor pronóstico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clara sobre el osteosarcoma. En general debemos recordar que los tumores óseos tienen preferencia por la región de la rodilla. El osteosarcoma es el tumor maligno de estirpe ósea más frecuente, presentando una distribución bimodal en adultos jóvenes y ancianos. Tiene potencial metastásico y puede elevar LDH y FA. Su tratamiento es quimio-

terapia + cirugía + quimioterapia, y si se produce secundario a una enfermedad de Paget tiene peor pronóstico.

111. El síndrome del túnel carpiano:

1. Es más frecuente en varones.
2. Cursa con hipoestesia en el pulpejo de los dedos segundo a quinto.
3. Los síntomas se exacerbaban durante la noche.
4. Se acompaña de atrofia de la musculatura de la eminencia hipotenar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El túnel del carpo es el síndrome producido por la compresión del nervio mediano a su paso por el mismo, el cual, distal a la muñeca, da sensibilidad a la zona palmar de los 3 primeros dedos y mitad del cuarto, e inerva motóricamente la musculatura de la eminencia tenar (a excepción del aductor del pulgar, que corresponde al nervio cubital). Por tanto, su compresión dará lugar a una clínica sensitiva en este territorio y atrofia de esa musculatura cuando se encuentra muy avanzado. El sobreuso de tendones flexores (profesiones manuales) aumenta su incidencia y es más frecuente en mujeres, siendo la clínica típica el dolor nocturno y las parestesias que hacen que “se caigan cosas de la mano al cogerlas”.

112. Mujer de 61 años, administrativa, con antecedentes de sobrepeso, hipertensión, dislipemia y síndrome metabólico, que consulta por dolor en ambas nalgas, región trocantérea izquierda, cara lateral del muslo izquierdo hasta la rodilla y pierna izquierda hasta el tercio medio. El dolor aparece cuando levantamos el miembro inferior con la rodilla extendida, pero se alivia al flexionar la rodilla. ¿Cuál es la primera sospecha clínica?:

1. Artritis gotosa de cadera izquierda.
2. Artrosis coxo-femoral izquierda.
3. Lumbalgia irradiada / lumbociatalgia.
4. Claudicación por estenosis de canal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y muy repetida del MIR. La definición de lumbalgia implica dolor lumbar, que puede irradiar a ambos glúteos y muslos (no pasa de la rodilla), e implica mecanismos inespecíficos (osteomusculares benignos en el 99%). La lumbociatalgia o ciática es un dolor lumbar que irradia por debajo de la rodilla, generalmente hasta el pie, y es más específico de compresión nerviosa radicular o ciática. La paciente además presenta el signo de Lasègue (dolor irradiado hasta el pie con la elevación de la pierna con la rodilla extendida, que se alivia al flexionar la rodilla), que es muy sugestivo de radiculopatía lumbar. Recordad que si solo cursa con dolor y alteración sensitiva, el manejo es conservador (como en una lumbalgia).

113. Varón de 35 años, cartero, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por un dolor agudo cervical de 24 horas de evolución, sin traumatismo previo, que irradia a brazo izquierdo hasta la mano y se acompaña de parestias en el borde radial del antebrazo. No presenta pérdida de fuerza objetivable, conserva la movilidad del cuello aunque es dolorosa y se aprecia contractura de la musculatura paravertebral. La primera actitud será:

1. Tratamiento conservador con antiinflamatorios no esteroideos, calor local y reposo relativo.
2. Llamada urgente al neurocirujano para valoración quirúrgica.
3. Solicitud preferente de resonancia magnética y electromiograma.
4. Derivación preferente a consultas externas de traumatología.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre el manejo de la cervicobraquialgia, que será el mismo que el muy preguntado en el MIR de la lumbociatalgia: ante ausencia de signos de alarma, inicialmente siempre debemos optar por un tratamiento conservador sin necesidad de más estudios, dado que el mismo resolverá la gran mayoría de casos.

114. Respecto a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, señale la respuesta correcta:

1. Es frecuente que se produzca por un traumatismo sobre la cara anterior de la tibia con la rodilla en flexión.
2. Raramente cursa con hemartros.
3. La maniobra de Lachman es negativa.
4. El tratamiento con fisioterapia con potenciación del cuádriceps y los isquiotibiales puede evitar la cirugía.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El ligamento cruzado anterior es intraarticular y muy vascularizado, por lo que su rotura cursa con derrame articular (hemartros, sangre) agudo y abundante (2 falsa). La maniobra de Lachmann y cajón anterior son positivas (puedo trasladar la tibia hacia anterior respecto al fémur, ya que el ligamento cruzado que estabiliza = evita este movimiento está roto) (3 falsa). El tratamiento con fisioterapia y potenciación muscular puede aumentar la estabilidad de la rodilla y evitar la cirugía, sobre todo en pacientes con poca demanda deportiva (4 correcta). La maniobra descrita en la respuesta 1 (traumatismo sobre cara anterior de tibia con la rodilla en flexión), está describiendo la energía de un cajón posterior, es decir, justo lo contrario, y podría ser un mecanismo de producción de lesión de cruzado posterior, no anterior (1 falsa).

115. Varón de 27 años, deportista habitual, que refiere dolor en la pierna derecha tras la práctica de carrera continua. Ha acudido en varias ocasiones a un fisioterapeuta, siendo diagnosticado de una sobrecarga en gemelos. Han transcurrido varios meses, no ha mejorado y refiere dolor intenso tras la actividad física que cede con el reposo en las siguientes horas del ejercicio. ¿Qué prueba puede ayudar en el diagnóstico?:

1. Tomografía de emisión de positrones con 18 FDG.
2. Determinación de la presión del compartimento posterior inmediatamente tras actividad.
3. Ecografía-Doppler para descartar un trastorno circulatorio de la extremidad inferior.
4. Espectrometría por resonancia magnética.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil donde nos hablan de un posible síndrome compartimental crónico, una entidad poco frecuente. Lo primero a tener claro es que tiene características distintas al agudo, ocurriendo fundamentalmente en el ámbito deportivo debido al sobreesfuerzo muscular repetitivo. Puede afectar a cualquier grupo muscular aunque suele ser más frecuente en la pantorrilla y antebrazo. Si se sospecha, puede estar indicada la medición de la presión intracompartimental justo después de hacer ejercicio. Puede intervenir de forma programada (no urgente como un síndrome compartimental agudo) si los síntomas son desagradables y no ceden con la disminución de la actividad que lo produce. La ecografía doppler tendría sentido si sospecháramos una TVP, distractor principal, donde nos darían datos de inflamación, edema, brillantez cutánea, factores de riesgo, y sin relación con la actividad deportiva. El PET (utilizado en contexto oncológico) y la espectrometría no tienen sentido.

116. Mujer de 95 años que vive en una residencia, independiente para sus actividades básicas de la vida diaria, sale al jardín a pasear. Tiene antecedentes de HTA, dislipidemia, osteoporosis y deterioro cognitivo leve. Sufre una caída al levantarse por la noche al baño. La radiografía muestra una fractura subcapital desplazada de cadera derecha. ¿Cuál es el tratamiento recomendado?:

1. Hemiartróplastia de cadera.
2. Fijación con clavo trocánterico.
3. Fijación con tornillos canulados.
4. Conservador: vida cama-sillón.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre las fracturas subcapitales de cadera donde nos dan datos clave para responder adecuadamente. Lo primero es saber que una fractura subcapital nunca la vamos a tratar con un clavo trocánterico (que es tratamiento para fracturas pertrocantéreas) (2 falsa). Los tornillos canu-

lados sólo podemos utilizarlos en fracturas no desplazadas (3 falsa). La principal duda sería si en una paciente tan mayor (95 años) optamos por operarla mediante artroplastia o la dejamos sin operar con tratamiento conservador por el riesgo quirúrgico. Nos dan unos datos clave de la paciente para decidir: es independiente, camina, sale a pasear. Sin duda es la respuesta 1, debemos devolverla a su actividad habitual con la mayor celeridad posible (1 correcta). Nos plantearemos tratamiento conservador en aquellas fracturas donde el paciente, literalmente, no haga nada, no camine y vaya a todas partes en silla de ruedas, o tenga una demencia avanzada que hace que no salga de la cama. En estos casos podemos optar por tratamiento conservador.

117. ¿En relación con las fracturas de la epitroclea en los niños señale la afirmación INCORRECTA?:

1. Se desencadenan por un mecanismo de valgo forzado del codo en la caída.
2. Están asociadas hasta en un 50 % de los casos con una luxación postero-lateral del codo.
3. Pueden presentar asociada una neurapraxia del nervio cubital.
4. Es más frecuente en niños de edades entre 4 y 6 años.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre un concepto específico. Las fracturas de epitroclea aislada suelen ocurrir en niños mayores y adolescentes, cercanos a la edad del cierre de las fisis (9-14 años) (4 falsa). En su mayor parte pueden tratarse de forma conservadora con férula. Dado que en la epitroclea se inserta el ligamento que estabiliza el valgo del codo, suele ocurrir con un mecanismo de valgo forzado. El nervio cubital se encuentra en el canal epitrocleo-olecránico, entre la epitroclea y olécranon, por lo que una fractura de la epitroclea puede producir una neuroapraxia del mismo. El 50% se asocia con una luxación de codo. Si el fragmento está incarcerated en la articulación debe operarse.

118. Varón de 41 años que consulta por gonalgia de varios días de evolución. En la exploración se realiza el test de Thessaly (dolor con los movimientos de rotación interna y externa con la rodilla flexionada) que resulta positivo. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable?:

1. Lesión meniscal.
2. Lesión por rotura del ligamento cruzado anterior.
3. Lesión por rotura del ligamento cruzado posterior.
4. Lesión por artropatía degenerativa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos preguntan directamente por un test de exploración meniscal. Los test meniscales más importantes son el test de McMurray, test de Apley y test de Thessaly. Sin embargo,

todos tienen el mismo principio: ROTAR fémur contra tibia (o tibia contra fémur) cizallando el menisco, para producir dolor. Tenemos que recordar que las maniobras de exploración que incluyen rotación (excepto pivot shift para el cruzado anterior) buscan explorar los meniscos. Las maniobras de cajón anterior-posterior explorarán los cruzados y las de bostezo en varo-valgo los colaterales.

119. Mujer de 13 años, sin antecedentes relevantes, con menarquia hace 3 meses, seguida desde los 10 años por escoliosis idiopática que ha empeorado. En la exploración física presenta una giba de 7 grados en el test de Adams y en el escoliógrama una curva toracolumbar T4-L1 de 35 grados de Cobb y un Risser 0. La actitud correcta a tomar será:

1. Recomendar natación y revisión en tres meses.
2. Prescribir una ortesis tipo corsé.
3. Derivar a fisioterapia para elastificación del raquis.
4. Revisar en 6 meses con una nueva radiografía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta preciosa y perfecta sobre la escoliosis del adolescente, donde nos presentan una paciente con muy reciente menarquia y risser 0, datos que nos indican que aún le queda crecimiento. La escoliosis es progresiva con el crecimiento y se detiene cuando éste termina, por lo que debemos vigilar las curvas pequeñas (<25°) y evitar la progresión de curvas intermedias (25-45°) para evitar que terminen precisando tratamiento quirúrgico. En este caso nos muestran una curva intermedia con 35° de Cobb y crecimiento residual. Debemos detener la progresión, por lo que la respuesta correcta es un corsé. Debemos recordar que el corsé NO corrige la deformidad, sólo evita su progresión.

120. Sobre la fascitis plantar, señale la respuesta correcta:

1. El dolor mejora al andar de puntillas.
2. Se asocia a la presencia de espolón calcáneo.
3. El tratamiento de elección es quirúrgico.
4. Provoca dolor en la zona del talón, más intenso al empezar a caminar.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta sobre la fascitis plantar. Se presenta con dolor plantar en la zona del talón, más intenso en los primeros pasos de la mañana (4 verdadera), y empeora al caminar descalzo o de puntillas (1 falsa). El tratamiento de elección es conservador, mediante reposo, estiramientos y ortesis nocturnas (3 falsa), reservándose el tratamiento quirúrgico para casos muy refractarios, mediante alargamiento de gastrocnemio medial o fasciotomía. La asociación con el espolón calcáneo (un hallazgo radiológico) no está clara, aunque pueden observarse conjuntamente con frecuencia, motivo por el que finalmente esta pregunta fue anulada.

121. Mujer de 79 años que ingresa por una fractura osteoporótica de cadera. Respecto a la prevención secundaria de las fracturas por fragilidad, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La baja adherencia al tratamiento se asocia a un incremento del riesgo de fractura.
2. Los marcadores de remodelado óseo pueden ser útiles para monitorizar de forma precoz la respuesta al tratamiento.
3. La vitamina D en monoterapia es eficaz en la reducción de dichas fracturas en personas mayores no institucionalizadas.
4. El aumento de calcio dietético o tomar suplementos de calcio de forma aislada no protegen frente a la aparición de fracturas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ni aumentar el calcio dietético ni tomar suplementos de calcio de forma aislada protege frente a la aparición de fracturas (respuesta 4 correcta). Tampoco la vitamina D en monoterapia es eficaz en la reducción de fracturas por fragilidad en personas ancianas no institucionalizadas (respuesta 3 incorrecta). Los suplementos de calcio y vitamina D han mostrado eficacia en población >65 años institucionalizada, reduciendo el riesgo de fractura no vertebral (no así el de fractura vertebral) y de forma más marginal de fractura de cadera. Este efecto depende en gran parte de la dosis de vitamina D y es más evidente a mayor edad y niveles más bajos de vitamina D. Es necesaria una buena adherencia al tratamiento para disminuir el riesgo de fractura (respuesta 1 correcta). Los marcadores de remodelado óseo pueden ser útiles en la evaluación inicial, y sobre todo durante el seguimiento, para valorar la adherencia y respuesta al tratamiento (respuesta 2 correcta).

122. Paciente de 78 años sin antecedentes que consulta por astenia y disnea de 3 meses de evolución, que ha progresado hasta hacerse de reposo en los últimos días. En los días previos refiere también dolor torácico de características anginosas con pequeños esfuerzos. En la exploración destaca presión arterial de 110/80 mmHg, frecuencia cardíaca de 85 lpm y auscultación con un soplo sistólico áspero en segundo espacio intercostal derecho y crepitantes en ambas bases pulmonares. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Insuficiencia mitral.
2. Estenosis aórtica.
3. Insuficiencia aórtica.
4. Miocardiopatía dilatada de origen isquémico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil. Paciente de edad avanzada con disnea, luego angina y que tiene un soplo sistólico en foco aórtico; la

respuesta es estenosis aórtica (valvulopatía más frecuente en general, y sobre todo en pacientes ancianos).

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con relación al síndrome del QT largo?:

1. Los betabloqueantes están contraindicados en el QT largo congénito.
2. Los antidepresivos tricíclicos pueden dar lugar a un QT largo adquirido.
3. Predispone a la taquicardia ventricular polimórfica.
4. Su fisiopatología se basa en una alteración de los canales iónicos responsables del potencial de acción transmembrana de la célula miocárdica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia en un tema de moda en el MIR como es el QT largo y sus arritmias relacionadas. Las 3 últimas opciones son claramente ciertas. La opción 1 es la falsa (y por tanto la que hay que señalar). Los betabloqueantes son el tratamiento farmacológico de elección en los casos de QT largo congénito. En pacientes con historia de muerte súbita, o arritmias ventriculares a pesar de betabloqueantes, se implanta un DAI.

124. Mujer de 82 años con fibrilación auricular crónica de 10 años de evolución y función sistólica biventricular conservada que presenta episodios de bloqueo aurículo-ventricular completo sintomáticos, por lo que se decide implantar un sistema de estimulación cardíaco definitivo. ¿Cuál de los siguientes está indicado?:

1. Marcapasos DDD (bicameral).
2. Marcapasos VVI (unicameral ventricular).
3. Marcapasos AAI (unicameral auricular).
4. Terapia de resincronización ventricular (TRC).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por lo novedoso que representa en el MIR, sobre los modos de estimulación básicos en marcapasos. En un paciente con FA bloqueada, sólo se implanta un cable ventricular (para evitar la bradicardia dependiente del bloqueo AV). El propósito de poner un cable auricular y otro ventricular es que el segundo siga al primero (como ocurre en condiciones fisiológicas). En caso de FA, no interesa que el cable ventricular siga la actividad auricular (que es fibrilatoria) por lo que no se pone cable en aurícula. Un marcapasos auricular (AAI) no evitaría la bradicardia ventricular (no estimula el ventrículo) y tampoco tiene sentido en un paciente en FA por lo mencionado. Un TRC sólo se contempla ante individuos con FEVI deprimida, por lo cual también es falsa.

125. Varón de 23 años diagnosticado de síndrome de Wolff-Parkinson-White que acude a urgencias

por palpitaciones. El ECG muestra una taquicardia irregular de QRS ancho, con una frecuencia cardíaca de 205 lpm, compatible con fibrilación auricular preexcitada. ¿Cuál de los siguientes fármacos considera adecuado administrar para detener la taquicardia?:

1. Verapamilo.
2. Digoxina.
3. Adenosina.
4. Procainamida.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. En paciente con WPW y FA preexcitada están prohibidos los frenadores del nodo, ya que en caso de frenarse demasiado el nodo, la FA dispondrá de la vía accesoria como único camino de acceso al ventrículo, pudiendo ensancharse el QRS, lo que puede ser mal tolerado hemodinámicamente. El tratamiento es cardiovertir la FA, ya sea eléctricamente o farmacológicamente (siempre que la arritmia sea bien tolerada clínicamente). En este último caso se emplea la procainamida como fármaco de elección.

126. Varón de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial de 6 años de evolución, que consulta por mal control de las cifras de presión arterial a pesar de recibir tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un diurético y un calcioantagonista. En consulta presenta cifras de 149/100 mmHg. Analítica: creatinina 1,2 mg/dl, potasio 2,2 mEq/l y alcalosis metabólica compensada; resto del estudio bioquímico, hemograma, coagulación y sedimento urinario normal. Señale la afirmación correcta:

1. El origen de la hipertensión en este caso es la secreción excesiva de aldosterona causada por una hiperfunción autónoma de la médula suprarrenal.
2. En la mayoría de los casos el sustrato anatómico es una hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal.
3. La TC forma parte del estudio diagnóstico en caso de haber una confirmación bioquímica.
4. La espironolactona está contraindicada en el manejo de esta patología.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada por el Ministerio por haber dos respuesta correctas. La hiperplasia bilateral es hoy en día la causa más frecuente de hiperaldosteronismo 1°. Además, una vez confirmado el diagnóstico bioquímico, es importante completar el estudio con pruebas de imagen para confirmar el diagnóstico etiológico y decidir el mejor tratamiento (opciones 2 y 3 correctas).

127. Entre las intervenciones sobre los factores de riesgo cardiovascular mostrados ¿cuál es la más rentable para reducir eventos coronarios en prevención secundaria?:

1. Abandono del tabaco.
2. Aumento de los niveles de lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL).
3. Control adecuado de la glucemia en pacientes diabéticos.
4. Aumento de la actividad física.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre factores de riesgo cardiovascular. La modificación del estilo de vida más beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular es el cese del tabaquismo (principal causa de muerte evitable). Aunque el aumento de la actividad física y un buen control glucémico también se asocian a mejoría pronóstica, no tienen una repercusión tan importante. El aumento de los niveles de HDL no se encuentra respaldado por una evidencia científica robusta que indique mejoría pronóstica durante el seguimiento.

128. Mujer de 75 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 25% que acude a revisión, encontrándose estable en clase funcional III de la NYHA. Tiene un desfibrilador cardioversor implantado. La medicación actual consiste en lisinopril, carvedilol y espironolactona en las dosis máximas toleradas. En la exploración física tiene TA 118/74 mmHg, FC 78 lpm. En la auscultación cardíaca se detecta un tercer tono, la auscultación pulmonar es normal y no presenta edemas. ¿Cuál de los siguientes es el paso más apropiado en su manejo?:

1. Añadir sacubitrilo/valsartan.
2. Añadir ivabradina.
3. Suspender el lisinopril e iniciar sacubitrilo/valsartan.
4. Suspender el carvedilol e iniciar ivabradina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y esperada por ser de tremenda actualidad. En paciente con IC y FEVI deprimida que toma IECA pero no INRA (sacubitril-valsartan), hay que suspender el primero y añadir sacubitril-valsartan, actitud que se ve respaldada por un descenso de la mortalidad en los ensayos clínicos que comparaban ambos grupos farmacológicos en este tipo de pacientes.

129. Varón de 65 años que acude a urgencias por aparición de lesiones moteadas cianóticas en los dedos de ambos pies. Antecedentes personales: tabaquismo, hipertensión arterial y dislipemia. Rx tórax: ensanchamiento mediastínico.

AngioTC tóraco-abdomino-pélvica: aneurisma de aorta torácica descendente de 7 cm de diámetro, distal a arteria subclavia izquierda y con trombo mural. De las siguientes, señale la opción correcta:

1. Está indicado el tratamiento con estatinas para estabilizar el trombo.
2. Es necesaria la realización de una aortografía diagnóstica urgente.
3. En la cirugía se sustituye el segmento aneurismático por una prótesis tubular con reimplante de los troncos supraaórticos.
4. Está indicado el implante de una endoprótesis torácica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Aneurisma aórtico descendente embolígeno. La dilatación aneurismática de la pared aórtica da lugar a una estasis sanguínea que puede llegar a generar trombosis local. El alto flujo y presión aórtica puede dar lugar a movilización y embolia distal del trombo. El tratamiento de elección de los aneurismas de aorta torácica descendente es la endoprótesis percutánea (TEVAR).

130. Varón de 85 años en fibrilación auricular permanente que consulta por sufrir un dolor brusco y frialdad en el pie derecho desde hace 6 horas. En la exploración presenta cianosis plantar con déficit parcial de sensibilidad y movilidad. El pulso femoral es palpable, estando ausentes los pulsos poplíteo y distales de dicha extremidad. De las siguientes ¿cuál es la actitud terapéutica idónea?:

1. Desestimar la cirugía de revascularización, por el tiempo prolongado de isquemia.
2. Aplicar calor y avisar al cirujano vascular de guardia.
3. Tratamiento quirúrgico urgente mediante tromboembolectomía.
4. Tratamiento médico urgente con prostaglandinas intravenosas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Oclusión arterial aguda de causa tromboembólica con extremidad viable (aún preserva sensibilidad y capacidad motora). El tratamiento consiste en iniciar anticoagulación para evitar la extensión local del trombo y revascularización por tromboembolectomía (de elección en casos embólicos, realizándose mediante sonda de Fogarty).

131. Varón de 30 años, de complexión delgada, que durante un partido de baloncesto sufre un episodio de dolor torácico derecho agudo, acompañado de disnea de aparición brusca y respiración superficial por el que acude

a urgencias. ¿Cuál de los siguientes signos exploratorios le parecería más probable encontrar en la auscultación pulmonar?:

1. Soplo tubárico y crepitantes en base derecha.
2. Disminución del murmullo vesicular en la base derecha, disminución de las vibraciones vocales y matidez a la percusión.
3. Disminución/abolición de las vibraciones vocales y timpanismo en la percusión en hemitorax derecho.
4. Roncus y sibilancias dispersas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre semiología respiratoria disfrazada de caso clínico en el que nos cuentan el típico paciente con un neumotórax espontáneo primario: varón joven, delgado, alto (está jugando al baloncesto) que presenta disnea de aparición brusca. En este caso, tanto la transmisión de la voz, las vibraciones vocales y los ruidos respiratorios estarán ausentes en el hemitórax afecto y al percudirlo, sonará timpánico (respuesta 3 correcta).

132. Varón de 75 años con antecedentes de EPOC que acude a urgencias por disnea progresiva de varios días de evolución y disminución del nivel de conciencia. En la gasometría arterial respirando aire ambiente (FiO₂ 21%) se informan los siguientes valores: pH 7,25; pO₂ 45 mmHg; pCO₂ 70 mmHg; H₂CO₃ 26 mmol/L; EB -0,1 mmol/L. Desde un punto de vista gasométrico presenta:

1. Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria.
2. Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica.
3. Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica.
4. Insuficiencia respiratoria parcial con alcalosis respiratoria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Para responder a la pregunta debemos analizar por un lado la oxigenación y por otro el equilibrio ácido-base. La oxigenación se define por las cifras de pO₂ en sangre arterial. Cuando las cifras de pO₂ son inferiores a 60, hablamos de insuficiencia respiratoria. Cuando la pO₂ es inferior a 80, hablamos de hipoxemia. Como nuestro paciente tiene pO₂ menor de 60, podemos afirmar que estamos en una situación de insuficiencia respiratoria. El equilibrio ácido-base debe interpretarse siempre en el mismo orden. El pH nos da el estado real del equilibrio ácido-base. En este caso tenemos un pH disminuido (7.25), por tanto acidosis. El siguiente paso es ver si la causa de dicha acidosis es respiratoria, metabólica o mixta. Nos encontramos ante un bicarbonato normal (26) y una pCO₂ elevada (70), por lo que estamos claramente

te ante una acidosis respiratoria. Debemos destacar en esta pregunta otro concepto: los tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria parcial, en la cual únicamente se ve afectada la oxigenación (pO_2 menor de 60); y la insuficiencia respiratoria global en la que se ve implicada la oxigenación, y la ventilación (aumento de la pCO_2). Por tanto, en nuestro caso clínico, estamos ante una insuficiencia respiratoria ($pO_2 < 60$) global (pCO_2 aumentada) y una acidosis respiratoria (pH disminuido con bicarbonato normal y pCO_2 elevada)

133. Mujer de 78 años que consulta por disnea, diagnosticándosele una exacerbación de su EPOC. Tras ser evaluada se decide administrar prednisona. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. En este caso es preferible administrar prednisona vía intravenosa ya que es más efectiva que la administración oral.
2. Una buena opción sería administrar prednisona 40 mg/día vía oral durante 5 días
3. La dosis de prednisona debe ser como mínimo 1 mg/kg de peso al día.
4. La prednisona debe pautarse de tal forma que la disminución de la dosis se realice de forma paulatina durante 10 días.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre tratamiento de la agudización de EPOC. Siempre que se nos plantee una pregunta sobre tratamiento del EPOC, es importante saber si nos están hablando de la fase estable, o de un episodio agudo. Recordemos las iniciales "BOCA" B: broncodilatadores de acción corta siempre: beta-agonista (salbutamol, terbutalina) y anticolinérgico (ipratropio). O: oxigenoterapia si la saturación es menor del 90% ($pO_2 < 60$ mmHg), a la menor dosis posible, restringiendo el flujo al mínimo necesario C: corticoides sistémicos. Si es una agudización moderada- grave preferiblemente intravenosos, y en leves- moderados individualizar. A: antibióticos, si se cumplen 2 de 3 criterios: aumento de disnea, aumento de volumen de expectoración, aumento de purulencia del esputo. En nuestro caso clínico, únicamente nos hablan de los corticoides y las diferentes formas de administración. No nos especifica si la exacerbación es leve, moderada o grave, por lo que la respuesta 1 podría ser correcta si no fuese porque nos dicen que la prednisona intravenosa es mas efectiva que la oral, concepto que es totalmente incorrecto. Los corticoides orales se absorben rápidamente (los niveles séricos máximos se alcanzan una hora después de la ingestión) con una biodisponibilidad prácticamente completa y parecen igualmente eficaces que los corticoides intravenosos para tratar la mayoría de las exacerbaciones de la EPOC. Históricamente en las exacerbaciones graves se administran por vía intravenosa por la situación clínica del paciente, que impide la administración oral, o porque previamente el paciente ya había estado tomando corticoides orales en domicilio sin mejoría clínica. Respecto a la 3, la dosis de

corticoide debe ser 0.5-1 mg/kg/ día, por tanto tampoco es correcta. La 2 y la 4 son opuestas, ya que una defiende pauta corta de corticoides sin descenso de dosis vs descenso progresivo. Debemos tener claro que siempre que podamos, y la gravedad del paciente nos lo permita, debemos optar por pautas orales cortas de corticoides sin descenso progresivo de la dosis según nos indican las guías de practica clínica con un alto nivel de recomendación.

134. Paciente de 71 años sin antecedentes cardiovasculares que consulta por ronquido crónico y apneas presenciadas durante el sueño. En la exploración destaca un índice de masa corporal de 31 kg/m². El grado de somnolencia diurna evaluado con la escala de Epworth es de 5. Se realiza una poligrafía respiratoria que evidencia un índice de apnea/hipopnea de 15 por hora de registro, con una saturación media de oxígeno del 94 %. La primera intervención terapéutica indicada es:

1. Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).
2. Oxigenoterapia nocturna domiciliaria.
3. Presión positiva de doble nivel en la vía aérea.
4. Medidas higiénico-dietéticas generales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre el tema de síndrome de apnea del sueño. El SAOS predomina en varones obesos de edad media, los cuales presentan síntomas nocturnos como apneas, ronquidos, microdespertares (arousal); así como diurnos, siendo la manifestación mas frecuente la somnolencia excesiva. La valoración de la somnolencia se realiza mediante la escala de Epworth (test que evalúa la probabilidad de quedarse dormido en diferentes situaciones). La escala es de 0 a 24, donde 0 es no tener ninguna posibilidad de quedarse dormido y 24 es tener mucha somnolencia. Se considera excesiva somnolencia una puntuación de 10-15. En el caso clínico nos hablan de un valor en la escala de Epworth de 5, por lo tanto, escasa somnolencia. El diagnostico definitivo se realiza mediante polisomnografía o poligrafía nocturna, considerándose diagnostico de SAOS un IAH (índice apnea-hipopnea) mayor o igual a 15. El tratamiento de elección es el uso de CPAP nocturna, estando esta indicada en casos de IAH > 30, y también en casos de IAH > 15 que asocien mucha somnolencia o comorbilidades (HTA mal controlada, ictus, IAM..., ósea, eventos cardiovasculares). En nuestro caso clínico tenemos un IAH de 15, pero NO se asocia excesiva somnolencia (Epworth de 5), y nos especifican que el paciente NO tiene antecedentes cardiovasculares. Por lo tanto, no cumple criterios de CPAP, la 1 es incorrecta. La 2 es incorrecta, ya que para iniciar oxigenoterapia nocturna se debe demostrar que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, que no es el caso de nuestro paciente (SatO₂ media de 94%). Respecto a la 3, en el SAOS esta indicada la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), no la presión positiva de doble nivel (BiPAP). Únicamente podríamos plantear-

nos el uso de la BiPAP en paciente que ha fracasado el uso de CPAP por requerir presiones mas altas. El truco de esta pregunta, radica, además de en saberse la teoría anteriormente expuesta, en la palabra “primera intervención” que en el examen MIR casi siempre van a ser “medidas higiénico-dietéticas”.

135. Mujer de 66 años, no fumadora, con tos y disnea de un año de evolución. Se realiza TC torácica de alta resolución por sospecha de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál de los siguientes hallazgos radiológicos son típicos de esta entidad?:

1. Quistes de panal y patrón reticular con predominio basal.
2. Opacidades en vidrio deslustrado parcheadas o difusas, bilaterales y simétricas.
3. Consolidaciones múltiples, con distribución periférica en campos pulmonares inferiores.
4. Bronquiectasias por tracción y patrón nodulillar subpleural en bases pulmonares.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre características radiológicas de la enfermedad intersticial por excelencia: fibrosis pulmonar idiopática. Tradicionalmente se creía que en la FPI existía una progresión radiológica, presentando un patrón de vidrio deslustrado o esmerilado en las fases iniciales de la enfermedad. Después se formaría infiltrados nodulares y reticulonodulares y, finalmente, en la fase de fibrosis, aparece un patrón reticular difuso, en panal de abeja o queso suizo, que constituye el estadio final y esta caracterizado por presencia de ESPACIOS QUISTICOS DE PAREDES GRUESAS. Esta progresión actualmente esta en duda, pues se considera que la FPI es una enfermedad directamente fibrosante (imágenes reticulonodulares y panal de abeja o QUISTES EN PANAL, como los nombra en el enunciado de la respuesta 1). Estas alteraciones radiológicas predominan en lóbulos inferiores y son de predominio periférico, subpleural. La FPI es una enfermedad heterogénea que puede producir múltiples patrones radiológicos, realmente podría producir cualquiera de los patrones que describen las cuatro opciones, pero nos están preguntando por los MÁS TIPICOS, por lo que la opción MÁS correcta es la 1.

136. Paciente de 65 años, no fumador, que refiere que trabajó en su juventud en industria relacionada con la uralita. Consulta por un cuadro de disnea progresiva, sin fiebre. En la radiografía de tórax se observan calcificaciones pleurales izquierdas y un engrosamiento pleural derecho de características nodulares, que se confirma en la TC de tórax, sin adenopatías mediastínicas, nódulos, ni masas pulmonares o mediastínicas. Con respecto a la actitud a seguir con este paciente, señale la afirmación correcta:

1. La tomografía por emisión de positrones

permite llegar al diagnóstico específico si se observa un gran hipermetabolismo a nivel pleural.

2. El diagnóstico más probable es el de carcinoma broncogénico, por lo que deberá realizarse, en primer lugar, una fibrobroncoscopia diagnóstica.
3. La primera maniobra diagnóstica debe ser una toracocentesis. En caso de que no se consiga un diagnóstico etiológico, debe plantearse una toracoscopia diagnóstica para toma de una biopsia pleural.
4. Al tratarse de un derrame pleural atípico, debe descartarse una causa infecciosa, por lo que deberá realizarse una toracocentesis con análisis bioquímico y cultivo para indicar un posible drenaje pleural.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta impugnable por no ser ninguna de las opciones totalmente correcta. Nos hablan sobre el manejo diagnóstico de una lesión pleural, descrita como engrosamiento pleural derecho de características nodulares. El ministerio da como correcta la 3, ya que si en el enunciado nombrasen la presencia de derrame pleural sería la correcta. Suponemos que el enunciado nos esta hablando de un posible mesotelioma (paciente con antecedentes de exposición a uralita y lesión a nivel pleural), por lo que la actitud a seguir sería la realización de toracoscopia/pleuroscopia para realizar biopsia pleural. En ningún momento describen presencia de derrame pleural, por lo que la 3 y la 4 serían incorrectas. Si no existe líquido pleural no tendría sentido hacer toracocentesis. Respecto a la 2, también incorrecta, ya que nos dicen en el enunciado que NO tenemos lesiones a otros niveles, por lo que la fibrobroncoscopia no sería útil para diagnóstico de una lesión periférica. Por último, la 1: una tomografía por emisión de positrones no proporciona diagnóstico específico, ya que la captación de la lesión no implica malignidad, podría tratarse de otras enfermedades con hipermetabolismo como, por ejemplo, causas infecciosas.

137. Paciente de 55 años con cirrosis hepática alcohólica, abstinentes, sin datos de hipertensión portal. Análisis: AST 34 U/L (normal < 37 U/L); ALT 19 U/L (normal < 41 U/L); bilirrubina total 0,78 mg/dl (normal < 1 mg/dl); alfafetoproteína 7 ng/ml (normal < 10 ng/ml). Se realiza una ecografía hepática que detecta una lesión ocupante de espacio hipoecogénica de 1,5 cm de diámetro. La resonancia magnética muestra una lesión con captación en fase arterial y lavado en fase venosa. ¿Qué actitud de las siguientes es más correcta?:

1. Realizar biopsia del nódulo, ya que el tamaño es inferior a 2 cm.
2. Repetir la ecografía a los 3 meses.
3. Indicar un trasplante hepático.
4. Solicitar estudio de extensión.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Ante una lesión con comportamiento típico de hepatocarcinoma (hipervascular en fase arterial con lavado precoz en fase venosa) que asienta sobre un hígado cirrótico, no es preciso confirmar el diagnóstico mediante biopsia. Lo que sí necesitamos para poder plantear tratamiento es un estudio de extensión, incluyendo una TC toracoabdominopélvica. Recuerda que la RMN es excelente para estadificación local, pero no descarta la presencia de metástasis a distancia.

138. Mujer de 27 años que consulta por disfagia y odinofagia. En los últimos meses nota sensación de dificultad al tragar, más con líquidos que con sólidos, dolor centrotorácico, algún vómito aislado, sin esfuerzo y más parecido a una regurgitación. No refiere pérdida de peso ni de apetito. Exploración física normal. Analítica completa dentro de la normalidad. Endoscopia oral sin alteraciones estructurales ni lesiones mucosas. Manometría esofágica de alta resolución: actividad vigorosa y ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico con relajación normal del esfínter esofágico inferior. El diagnóstico más probable es:

1. Espasmo esofágico distal.
2. Esófago hipercontráctil.
3. Acalasia tipo I.
4. Peristalsis fragmentada.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta difícil y mal redactada acerca de los trastornos motores esofágicos. Podemos descartar fácilmente la peristalsis fragmentada (opción de relleno) y la acalasia, ya que nos dicen que el EEI relaja adecuadamente. La duda está entre la opción 1 y 2, ya que ambas pueden producir disfagia y típicamente dolor torácico. El hallazgo manométrico típico de un espasmo esofágico difuso es la presencia de contracciones simultáneas, no peristálticas, repetitivas y de gran amplitud en >20% de las degluciones. En el esófago hipercontráctil el hallazgo típico es una adecuada relajación del EEI junto con contracciones "hipercontráctiles" (muy intensas) en más del 20% de las degluciones. La pregunta no es clara y la palabra "vigorosa" no nos permite diferenciar con certeza entre ambas opciones. Es una pregunta muy polémica y mal redactada, aunque finalmente el Ministerio dio por correcta la 1.

139. Mujer de 69 años que acude a urgencias por un cuadro de vómitos, estreñimiento, retortijones y distensión abdominal. En la exploración se observa abdomen distendido, sin dolor a la palpación, con ruidos intestinales metálicos. En la radiografía simple de abdomen en bipedestación se observan múltiples niveles hidroaéreos y aerobilia. De los siguientes, el diagnóstico más probable es:

1. Colecistitis enfisematosa.
2. Fitobezoar.
3. Íleo biliar.
4. Colitis isquémica.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Caso clínico fácil que debemos conocer por su recurrencia en el MIR. Nos presentan una paciente con síntomas de obstrucción intestinal (vómitos, RHA metálicos, abdomen distendido) y nos hablan de la vía biliar (aerobilia). Este cuadro es muy típico de un paciente que ha presentado una fistula bilio-enterica (por eso entra aire en la vía biliar), ha soltado una piedra al intestino y se ha producido una obstrucción por la piedra en la válvula íleo-cecal. Este cuadro es compatible con íleo biliar y su tratamiento es quirúrgico.

140. Con relación a la clasificación de las heridas quirúrgicas en función de la magnitud de la carga bacteriana estimada, una enterotomía durante una obstrucción intestinal se clasifica como:

1. Herida sucia (clase IV).
2. Herida contaminada (clase III).
3. Herida limpia/contaminada (clase II).
4. Herida limpia (clase I).

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Se trata de una pregunta sencilla sobre la clasificación de las cirugías en función del grado de contaminación del lecho quirúrgico. En esta pregunta, la clave es identificar que una enterotomía en el contexto de una obstrucción no tiene por qué implicar una infección ya establecida, por lo que no sería una cirugía sucia. Al referirse a "enterotomía" en el contexto de una obstrucción, nos describen la apertura de víscera con carga bacteriana en el lecho quirúrgico, se trataría pues de una cirugía contaminada.

141. Varón de 18 años que fue intervenido hace 10 días de una apendicitis gangrenosa por laparoscopia con peritonitis localizada pélvica. Acude a urgencias por un síndrome febril en agujas, distensión abdominal y deposiciones diarreicas de 48 h de evolución. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Absceso en fondo de saco de Douglas.
2. Infección de la herida quirúrgica.
3. Infección urinaria complicada.
4. Absceso hepático.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta compleja sobre una complicación de la apendicitis con peritonitis pélvica. En este caso se trata de un absceso en el saco de Douglas. Recordad que típicamente la apendicitis pélvica manifiesta dolor en el saco de Douglas durante el tacto rectal. La apendicitis pélvica como compli-

cación postquirúrgica puede presentar un absceso en el saco de Douglas, que en este caso se manifiesta clínicamente por la fiebre y la diarrea.

142. Un paciente con bocio tóxico difuso (enfermedad de Graves) que rechaza tratamiento con yodo radioactivo y que presente oftalmopatía grave debe someterse a:

1. Lobectomía tiroidea.
2. Tiroidectomía total.
3. Tiroidectomía subtotal.
4. Enucleación del nódulo principal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta discutible e incluso impugnable. El tratamiento de la enfermedad de Graves se basa en tratamiento con antitiroideos, el tratamiento con yodo radiactivo y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento con yodo radiactivo está indicado en pacientes sin oftalmopatía tiroidea grave y que estén de acuerdo con el procedimiento. En cuanto al abordaje quirúrgico, no es habitual realizar cirugías parciales ante una enfermedad tiroidea difusa (respuesta 1 y 4 falsa). Clásicamente (y así aparece en el Harrison's) se ha recomendado la tiroidectomía subtotal, que pretende preservar la función tiroidea pero tiene más riesgo de recidiva que la tiroidectomía total. Esta última se emplea más en la actualidad y es la recomendada por las guías americanas de Tiroides. Aunque ambas opciones son razonablemente correctas y defendibles el Ministerio dio finalmente como correcta la tiroidectomía total (opción 2).

143. Mujer de 51 años que consulta, tras varios episodios de diverticulitis sigmoidea leve tratados de forma conservadora, por presentar ahora estreñimiento pertinaz que mejora con el uso de laxantes. En ocasiones presenta dolor abdominal tipo retortijón que mejora con la expulsión de heces y gases. Se practica colonoscopia encontrándose una estenosis sigmoidea que impide el paso del colonoscopio. Se toma muestra para estudio anatomopatológico que no es concluyente. En el enema opaco se encuentra una estenosis sigmoidea de unos 5 cm de longitud. La actitud terapéutica más adecuada sería:

1. Sigmoidectomía laparoscópica.
2. Tratamiento conservador con fibra dietética y rifaximina.
3. Dilatación endoscópica.
4. Stent en zona de estenosis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre el manejo de la diverticulitis aguda leve recurrente, que siempre es quirúrgico (respuesta correcta 1). La respuesta 2 es falsa ya que la mujer presenta una estenosis postinflamatoria no franqueable endoscópicamente y hay que hacer algo (no sirve de nada el tratamiento sintomático).

La respuesta 3 y 4 podían suscitar a dudas, pero actualmente no existe indicación de colocación de prótesis de colon ni de dilatación con esta indicación.

144. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento adyuvante del cáncer de mama?:

1. Incremento de la supervivencia global.
2. Transformar tumores no resecables en resecables para la cirugía.
3. Aumentar la supervivencia libre de progresión.
4. Mejorar el control de síntomas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil sobre un tema que debéis dominar por completo: el cáncer de mama. La adyuvancia constituye el tratamiento oncológico que se administra tras la cirugía y su objetivo principal es el aumento de la supervivencia global (respuesta 1 correcta), si bien es cierto que secundariamente también aumenta la supervivencia libre de enfermedad (disminuye el riesgo de recaída, no de progresión: respuesta 3 falsa).

145. ¿Cuál de las siguientes vacunas NO está recomendada previamente a una esplenectomía electiva en un adulto?:

1. Vacuna antineumococo PPV 23.
2. Vacuna antihaemophilus influenza B.
3. Vacuna antimeningocócica C.
4. Vacuna antitetánica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla que invita a reconocer qué gérmenes necesitamos cubrir antes de extirpar el bazo a un paciente (tanto adulto como en este supuesto o pediátrico). Recordad que precisamos dar cobertura frente a gérmenes encapsulados, por tanto incluiríamos todas las vacunas salvo la opción 4, antitetánica, que en este supuesto no añadiría ventaja importante al paciente.

146. Mujer de 40 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que presenta diarrea de varios días de evolución de carácter acuoso, muy abundante, acompañada de pérdida de 10 kg de peso, rubor y enrojecimiento facial, junto a lipotimias y dolor abdominal cólico y que en los datos de laboratorio presenta hipopotasemia. En ecografía abdominal se encuentra masa de 1,5 cm de diámetro en cola pancreática. De entre las siguientes, su sospecha diagnóstica primaria es:

1. Insulinoma.
2. PPoma.
3. VIPoma.
4. Glucagonoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La dificultad de esta pregunta radica en que los tumores neuroendocrinos son uno de los temas menos preguntados en Endocrinología. Sin embargo nos describen un caso típico de vipoma, también conocido como “cólera pancreático”, síndrome de Werner-Morrison, o síndrome WDHA (watery diarrhea, hypokalemia, and achlorhydria). El cuadro clínico nos plantea el diagnóstico diferencial de un tumor pancreático con clínica endocrinológica. La presencia de diarrea acuosa e hipopotasemia nos tiene que hacer pensar en el vipoma, que adicionalmente puede acompañarse de flushing facial.

147. En relación con la calprotectina, indique la respuesta correcta:

1. Es una proteína secretada por los neutrófilos que se determina en sangre para valorar la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal.
2. Sus niveles tienen muy buena correlación con la actividad objetivada por endoscopia, sobre todo en la colitis ulcerosa.
3. En los pacientes con síndrome de intestino irritable se detecta en niveles anormalmente elevados.
4. No es de utilidad en el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja-moderada. La calprotectina es una proteína de los granulocitos neutrófilos que se determina en heces (respuesta 1 falsa). Al ser una proteína neutrofílica sus niveles se correlacionan muy bien con el grado de inflamación de la mucosa intestinal (opción 2 correcta y opción 4 falsa); debiendo de ser completamente normal, por tanto, en los trastornos funcionales digestivos como el SII (opción 3 falsa). Si nos fijamos detenidamente en las opciones de esta pregunta y de cara a repasar técnica de examen, vemos que las opciones 2 y 4 se contradicen, y por lo tanto o bien no son ambas ciertas o bien no son ambas falsas a la vez. Lo correcto por tanto es que la 2 es la cierta y la 4 es la falsa.

148. Paciente de 48 años remitido a consulta de nefrología por un filtrado glomerular estimado (FGe) de 32 ml/min/1,72 m². ¿Cuál de los siguientes datos NO orientaría a pensar en una enfermedad renal crónica?:

1. Riñones de pequeño tamaño.
2. Antecedentes familiares de nefropatía.
3. Niveles elevados de fósforo en sangre.
4. Buena diferenciación ecográfica de corteza y médula renales.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La ecografía renal es útil a la hora de valorar datos de cronicidad ante un fracaso renal: mientras que en FRA la ecografía renal será normal, en la IRC nos encontraremos con

riñones habitualmente de tamaño disminuido (respuesta 1 verdadera), con adelgazamiento cortical y pérdida de la diferenciación cortico-medular (respuesta 4 falsa, por tanto correcta). Recuerda además que existen enfermedades renales hereditarias (como p.ej. la enfermedad de Alport) y que la elevación de fósforo sérico es típico de la IRC, apareciendo cuando el FG <30-45 ml/min (es decir, cuando queda el 25% o menos del FG).

149. Mujer de 67 años con enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética. En la actualidad presenta una creatinina de 3,2 mg/dl con filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 14 ml/min. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Presenta una enfermedad renal crónica estadio 3 y debe iniciar quelantes del fósforo.
2. Presenta una enfermedad renal crónica estadio 5 y debe considerarse el tratamiento renal sustitutivo.
3. Un buen control glucémico puede revertir la insuficiencia renal.
4. Es poco probable que presente una proteinuria superior a 500 mg/24h

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta en la que debes conocer los estadios de FG. Un FG <15 ml/min corresponde al estadio V (IRC terminal) de la enfermedad renal, y debe plantearse el inicio de terapia renal sustitutiva de manera individualizada (respuesta 2 correcta, respuesta 1 falsa). Respecto al resto de opciones, recuerda que en la nefropatía diabética, cuando hay daño renal establecido, no es suficiente con el control glucémico apropiado, sino que se deben emplear fármacos bloqueadores del SRAA como IECAs/ARA-II para ralentizar la progresión de la nefropatía (respuesta 3 falsa); además, recuerda que la elevación de creatinina sérica suele cursar con albuminuria de alto grado (>300 mg/día), que suele aumentar según empeora la nefropatía, pudiendo llegar a rango nefrótico (respuesta 4 falsa).

150. Mujer de 47 años que consulta por síndrome miccional. Se le diagnostica de infección urinaria no complicada y se le trata con ciprofloxacino durante 5 días. A la semana vuelve a consultar por mal estado general, artralgias y aparición de un rash cutáneo. En la analítica destaca un filtrado glomerular de 45 ml/min (CKDEPI), siendo el de hace 6 meses de 100 ml/min. En el sedimento se identifican leucocitos, siendo negativo para nitritos. ¿De las siguientes, cuál es la causa más probable de su insuficiencia renal?:

1. Glomerulonefritis postinfecciosa.
2. Nefrotoxicidad por ciprofloxacino.
3. Pielonefritis aguda.
4. Nefritis intersticial aguda.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta típica de nefritis tubulointersticial aguda (respuesta 4 correcta) de origen inmunoalérgico: FRA de origen tubulointersticial (leucocituria sin datos sugerentes de infección urinaria), precedido de cuadro sugerente de sintomatología alérgica (malestar general, artralgias y rash cutáneo), desencadenado tras la toma de un fármaco (en este caso, ciprofloxacino). Recuerda que otros datos típicos son la eosinofilia, la eosinofilia y la proteinuria tubular.

151. Varón de 22 años que acude a urgencias por presentar orina “casi negra” desde hace 12 horas. No tiene antecedentes de interés ni toma medicamentos. Refiere un cuadro catarral de vías altas desde hace 4-5 días para el que ha tomado paracetamol. Exploración: temperatura 37,3 °C, PA 150/95, FC 85 lpm, ligero eritema faríngeo, resto normal. En analítica destaca: Hb 12,8 g/dl, Hcto 39 %, leucocitos 10.500 /mm³ con fórmula normal, plaquetas 250.000 /mm³, coagulación normal, urea 25 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, iones, perfil hepático, lipídico, albúmina y proteínas totales normales. Estudio de autoinmunidad normal y serología vírica negativa. Orina de 24 h con proteinuria de 0,75 g/24h, sedimento con 10 eritrocitos por campo (90 % dismórficos), no leucocituria. Ecografía renal normal. ¿Qué diagnóstico le parece más probable?:

1. Nefropatía por cambios mínimos.
2. Glomerulonefritis post-infecciosa.
3. Nefropatía IgA.
4. Nefritis intersticial aguda.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos presentan un síndrome NEFRÍTICO (proteinuria no nefrótica, hematuria con 90% de hematíes dismórficos e HTA), por lo que podemos descartar la nefropatía de cambios mínimos (al ser causa de nefrótico, respuesta 1 falsa) y la nefritis intersticial aguda (al ser causa de síndrome tubular, respuesta 4 falsa). Dado que el cuadro se desencadena a los 4-5 días de una infección respiratoria, podemos descartar la GN postinfecciosa (precisa un periodo de latencia de 1-2 semanas, respuesta 2 falsa) y quedarnos con la nefropatía IgA como opción más probable (respuesta 3 correcta).

152. Varón de 24 años que presenta microhematuria dismórfica, proteinuria de 3g/24h, FGe(CKDEPI) 85 ml/min e hipoacusia neurosensorial. Refiere que su abuela materna precisó diálisis a los 70 años y tanto su madre como su hermana pequeña presentan microhematuria aislada. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable?:

1. Síndrome de Alport.
2. Nefropatía IgA.

3. Enfermedad de Fabry.
4. Poliquistosis renal autosómica dominante.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Caso sugerente de síndrome de Alport (respuesta 1 correcta). Recuerda que el síndrome o enfermedad de Alport es una enfermedad hereditaria con herencia autosómica dominante o ligada al X (por lo que suele haber antecedentes familiares de nefropatía), que produce un defecto de colágeno tipo IV. Su presentación característica es en forma de triada de nefropatía (hematuria con proteinuria progresiva que aboca en IRC terminal en la 2-3ª década de la vida), sordera neurosensorial y trastornos oculares (por esferofaquia o lenticono).

153. Varón de 19 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias porque después de una infección respiratoria presenta astenia, malestar general, oliguria y cefalea. Exploración física: TA 210/120 mmHg, fondo de ojo con retinopatía hipertensiva grado III. Analítica: Hb 7,4 g/dl, plaquetas 85.000/mm³, 2-3 esquistocitos en la extensión de sangre periférica, LDH 950 UI/ml, creatinina sérica 8,75 mg/dl. Sistemático de orina: proteinuria 300 mg/dl, sedimento 15 hematíes por campo. Niveles de ADAMTS-13 normales. Ante estos hallazgos ¿cuál sería su principal sospecha diagnóstica?:

1. Púrpura trombótica trombocitopénica.
2. Síndrome hemolítico urémico atípico.
3. Coagulación intravascular diseminada.
4. Síndrome hemolítico urémico típico.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Paciente con cuadro típico de microangiopatía trombótica: fracaso renal agudo grave, anemia hemolítica microangiopática (elevación de LDH y esquistocitos en el frotis), trombopenia y emergencia HTA (HTA grave con retinopatía grado III). Los niveles de ADAMTS13 normales (>10%) descartan en este caso una PTT (respuesta 1 falsa), y no nos presentan datos sugerentes de CID (coagulopatía, elevación de D-dímeros ni patología predisponente como infecciones/neoplasias) (respuesta 3 falsa). Estamos por tanto ante un síndrome hemolítico urémico (SHU). Dado que el cuadro no se ha desencadenado por una infección por E. coli enterohemorragico, nos tendríamos que decantar por un SHU atípico (respuesta 2 correcta, respuesta 4 falsa).

154. En cuanto a la obstrucción del flujo urinario, señale la respuesta FALSA:

1. La intensidad del dolor es independiente de la velocidad con la que ocurre la distensión.
2. Son sitios frecuentes de obstrucción las uniones pieloureteral y ureterovesical, el cuello vesical y el meato uretral.

3. Los recursos diagnósticos para identificar la obstrucción anatómica incluyen la flujometría.
4. La obstrucción del flujo urinario aumenta la presión hidrostática proximal al sitio de oclusión, causando dolor, distensión del sistema colector renal y aumento de la presión intratubular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil, aunque deducible, de la fisiopatología de la obstrucción urinaria. La opción correcta es la 1, dado que una obstrucción de la vía urinaria de instauración aguda es la que produce distensión de la cápsula renal y por tanto el cuadro típico de dolor cólico, mientras que una dilatación lenta, por un proceso tumoral (como una masa pélvica que atrapa uréter) se asocia a una dilatación asintomática. La flujometría nos sirve para diagnosticar una obstrucción infravesical. Los puntos de obstrucción más frecuentes son, efectivamente, la unión pieloureteral, uréter en el cruce con los vasos ilíacos, ureterovesical, e infravesicales, el meato uretral y el cuello vesical. Por último, la fisiopatología de la obstrucción sería exactamente como describe la opción 4.

155. ¿Cuál de las siguientes es la complicación metabólica más frecuente en el cáncer?:

1. Hiponatremia.
2. Hiperuricemia.
3. Hiperfosfatemia.
4. Hipercalcemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil, aunque con posibilidad de resolver mediante razonamiento. Aunque la respuesta sea la hipercalcemia, se trata más de una pregunta sobre Oncología que sobre Endocrinología. Los tumores son una causa muy frecuente de hipercalcemia por distintos mecanismos, aunque fundamentalmente por liberación de calcio en metástasis osteolíticas. También por hiperactivación de la vitamina D (linfomas) o por síntesis de PTHrp. Los pacientes oncológicos pueden también presentar hiponatremia, generalmente por mecanismos mediados por SIADH en contexto de neoplasias pulmonares o cerebrales. Menos frecuente es la hiperuricemia, que puede darse en contexto del síndrome de lisis tumoral (poco frecuente salvo en algunas neoplasias hematológicas). La hiperfosfatemia es mucho menos importante, pero puede aparecer en contexto de insuficiencia renal o acompañando a la hipercalcemia. Por tanto, son muchos más los tumores que dan hipercalcemia (prácticamente cualquier tumor puede hacerlo) que los que dan hiponatremia, hiperuricemia o hiperfosfatemia.

156. En relación con la compresión medular secundaria a infiltración neoplásica de la médula espinal en pacientes con cáncer, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La laminectomía quirúrgica y la radioterapia, sola o complementaria a la cirugía, consiguen una recuperación neurológica inferior al 20%.
2. El tratamiento precoz con corticoides reduce el edema vasogénico y limita la progresión de la lesión medular.
3. Los síntomas más frecuentes son la paraparesia y la reducción de la sensibilidad distal al segmento medular comprimido.
4. La resonancia magnética es la prueba diagnóstica de elección para la confirmación diagnóstica y la identificación del nivel de compresión.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las respuestas 2, 3 y 4 son ciertas. Ante una sospecha de compresión medular, el tratamiento con corticoides debe iniciarse inmediatamente para disminuir el edema vasogénico y, con ello, disminuir el dolor y prevenir un daño adicional. La paraparesia y la reducción de la sensibilidad son dos síntomas que aparecen de forma precoz. La compresión medular es una de las pocas indicaciones de realización de resonancia magnética urgente por ser la técnica diagnóstica de elección y poder abarcar toda la longitud de la columna. Por tanto, la respuesta falsa es la 1, ya que la radioterapia sola consigue una recuperación funcional en el 80% de los pacientes ambulatorios y hasta un 50% de hospitalizados si la instauración de los síntomas es progresiva y se interviene de manera precoz. Asimismo, la radioterapia acompañada de cirugía mejora los resultados de supervivencia y de recuperación funcional frente a radioterapia sola.

157. ¿Cuál es la mejor combinación de tratamientos oncológicos en un paciente con el diagnóstico de carcinoma adenoide quístico de paladar duro T4N0M0?:

1. Radioquimioterapia concomitante como primera opción terapéutica.
2. Cirugía de la lesión seguida de radioterapia adyuvante sobre el lecho quirúrgico.
3. Radioterapia y posterior cirugía en ausencia de respuesta completa.
4. Es un tumor benigno y por tanto no precisa de tratamientos oncológicos complementarios.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso sobre el tratamiento de un carcinoma adenoide quístico de paladar duro catalogado como T4N0M0. En estos casos la opción con mayor rentabilidad terapéutica es la cirugía con radioterapia adyuvante (opción 2 correcta)

158. Señale el tumor en el que la braquiterapia NO es una alternativa efectiva de tratamiento:

1. Adenocarcinoma de endometrio estadio I-B grado 2.
2. Carcinoma ductal infiltrante de mama tras intervención quirúrgica del lecho tumoral con margen cercano.
3. Glioblastoma multiforme resecado parcialmente.
4. Adenocarcinoma de próstata T1N0M0 Gleason 6.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta general sobre el tratamiento de los tumores que requiere conocer el tratamiento del glioblastoma multiforme, que consiste en la cirugía radical más tratamiento con temozolamida y radioterapia.

159. Además de las posibles complicaciones hemorrágicas ¿qué otro efecto adverso del tratamiento parenteral con heparina puede ser grave y comprometer la vida del paciente?:

1. Hipopotasemia extrema.
2. Trastornos gastrointestinales con diarrea abundante y deshidratación.
3. Alcalosis metabólica por toxicidad tubular renal.
4. Trombopenia grave acompañada de fenómenos trombóticos venosos o arteriales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La trombopenia inducida por heparina es un concepto ampliamente repetido en el MIR y que debes conocer. Recuerda que es un efecto adverso raro, más frecuente con las heparinas no fraccionadas que con la HBPM. La trombopenia inducida por heparina (TIH) se produce como consecuencia de la formación de anticuerpos antiFP4 en determinados pacientes cuando su organismo entra en contacto con la heparina. Como consecuencia de ello, se produce una destrucción plaquetaria (y por tanto una trombopenia grave) que a su vez genera liberación de factores procoagulantes que activan la cascada de la coagulación y que pueden dar lugar a fenómenos trombóticos graves (respuesta 4 correcta).

160. Mujer de 35 años, que toma anticonceptivos, acude a urgencias con síndrome febril y parestesias en hemicuerpo izquierdo. En la analítica de sangre se observa Hb 7,5 g/dl, plaquetas 7.000/microl, leucocitos normales con recuento diferencial normal, LDH 1.200 UI/l, reticulocitos 10 % (normal 0,5-2 %), haptoglobina en suero indetectable, test de Coombs directo negativo y frotis de sangre periférica con esquistocitos. Coagulación (tiempo de protrombina y APTT) normal. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Anemia hemolítica autoinmune.
2. Púrpura trombótica trombocitopénica.
3. Síndrome de Evans (anemia hemolítica y trombopenia inmunes).
4. Trombocitopenia inmune idiopática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con cuadro típico de microangiopatía trombótica: anemia hemolítica microangiopática (elevación de LDH, haptoglobina indetectable, Coombs directo negativo y esquistocitos en el frotis) y trombopenia grave, por lo que podemos descartar la anemia hemolítica autoinmune (Coombs negativo, respuesta 1 falsa), el síndrome de Evans (respuesta 3 falsa) y la trombocitopenia inmune idiopática (respuesta 4 falsa). Por tanto, lo más probable es una PTT (respuesta 2 correcta), máxime cuando se trata de una mujer de edad media y la concurrencia de fiebre y alteraciones neurológicas (que junto con la triada de microangiopatía trombótica, conforman la pentada sintomática clásica descrita por Moschcowitz). La determinación de niveles bajos de ADAMTS 13 (<10%) nos daría el diagnóstico definitivo.

161. En el diagnóstico de un proceso linfoproliferativo es fundamental el estudio molecular y del inmunofenotipo. La detección de la translocación 11:14 con afectación de la ciclina D1 es característica de un:

1. Linfoma folicular.
2. Linfoma de la zona marginal.
3. Linfoma linfoblástico.
4. Linfoma del manto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto muy repetido en el MIR. La translocación t(11;14) que da lugar a la expresión de la proteína ciclina D1 es típica del linfoma del manto (respuesta 4 correcta).

162. ¿Cuál de las siguientes escalas o instrumentos utilizados para valorar la condición de fragilidad en un paciente mayor se basa en el juicio clínico del observador y es, por tanto, la más subjetiva?:

1. El fenotipo de Fried.
2. La escala clínica de fragilidad (Clinical Frailty Scale).
3. SPPB (Short Physical Performance Battery).
4. Timed Up & Go.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Mientras que la escala de Fried valora la fragilidad de una forma objetiva con elementos medibles, la escala clínica de fragilidad (Clinical Frailty Scale) valora la fragilidad del paciente de forma subjetiva de acuerdo a la impresión del observador, en 9 estadios, desde el grado 1 (muy activo: paciente robusto, activo, enérgico y motivado) hasta el grado 9 (paciente terminal).

163. Referente a la sarcopenia, es cierto que:

1. Es un síndrome geriátrico que aparece exclusivamente en pacientes de edad avanzada.
2. Se caracteriza por pérdida de la masa y la fuerza de la musculatura esquelética.

3. Es sinónimo de fragilidad.
4. Se trata con medicamentos que aumentan la masa muscular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La sarcopenia es la pérdida de masa y fuerza muscular esquelética (respuesta 2 correcta). Puede aparecer tanto en ancianos como en personas jóvenes tras inmovilizaciones prolongadas, padecimiento de enfermedades neuromusculares, uso de ciertos fármacos... (respuesta 1 falsa). La fragilidad es un estado en el que hay un aumento del riesgo de incapacidad y vulnerabilidad a causa de diferentes factores, no solo médicos. Si bien es cierto que la sarcopenia supone un factor de riesgo de fragilidad en el anciano, la sarcopenia no es sinónima de fragilidad (respuesta 3 falsa). Hoy por hoy, no existen medicamentos que aumenten la masa muscular más allá del ejercicio físico y la nutrición adecuada rica en proteínas (respuesta 4 falsa).

164. Varón de 78 años con hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con finasterida y tamsulosina, independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Presenta un creciente número de episodios de escapes de orina involuntarios con sensación de urgencia miccional (actualmente presenta 4-5 escapes durante el día). El sedimento de orina es normal. Tiene un residuo de orina post-miccional de 60 cc. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada?:

1. Iniciar tratamiento con oxibutinina.
2. Colocar una sonda urinaria.
3. Retirar el tratamiento con finasterida.
4. Iniciar medidas higiénicas miccionales con terapia conductual vesical.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. Debemos recordar que las medidas higiénico-dietéticas y modificaciones en estilo de vida del paciente son la primera opción de tratamiento. El paciente que nos presentan, a pesar de tener ya tratamiento para la sintomatología obstructiva, comienza ahora con síntomas irritativos de novo. Antes de añadir nuevas terapias farmacológicas, hay que comenzar con medidas higiénico-dietéticas.

165. Mujer de 88 años que presenta episodio de desorientación en espacio y tiempo, inquietud y alteración del nivel de conciencia fluctuante al regresar a casa tras ser dada alta del hospital, tras un ingreso por fractura de cadera. Entre sus antecedentes destacan HTA, hipoacusia leve, deterioro cognitivo leve y osteoporosis. Antes de la fractura era independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, y tras la cirugía ha iniciado la deambulación

con andador y las transferencias las realiza con ayuda de una persona. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado del cuadro que presenta?:

1. Valoración del dolor y descartar una impactación fecal.
2. Iniciar haloperidol.
3. Iniciar diazepam.
4. Recomendar reposo en cama y sujeción mecánica para que no se autolesione.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La paciente presentada muestra un síndrome confusional agudo o delirium. Previo a iniciar tratamiento farmacológico, es preciso siempre corregir la causa subyacente al delirium. Para ello realizaremos anamnesis, exploración física y otras pruebas complementarias cuando sea necesario (respuesta 1 correcta). Además, es imprescindible tratar el dolor, las náuseas y otros síntomas que puedan contribuir a su desarrollo. Se debe garantizar la seguridad del paciente mediante la contención farmacológica con neurolepticos como el haloperidol tras tratar la causa subyacente. No se deben utilizar benzodiacepinas y, como norma general, deben evitarse las restricciones físicas (respuesta 3 y 4 falsas).

166. Mujer de 88 años de edad que consulta por caídas frecuentes, deterioro del estado general, hiporexia e insomnio. Como antecedentes presenta deterioro cognitivo moderado, diabetes mellitus tipo 2 con última hemoglobina glicosilada de 8 %, hipertensión arterial, hipercolesterolemia con LDL de 121 mg/dl y enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular de 42 mL/m. En tratamiento con sulfonilureas, simvastatina, benzodiacepinas y valsartan/amlodipino. Indique la actuación más correcta:

1. Habría que intensificar el tratamiento de la diabetes para reducir la hemoglobina glicada.
2. La hipercolesterolemia está mal controlada, por lo que añadiría ezetimiba.
3. Revisaría el tratamiento farmacológico para realizar una desprescripción priorizando fármacos imprescindibles.
4. Aumentaría la dosis de benzodiacepinas para control del insomnio.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Con el fin de detectar la prescripción inadecuada en ancianos existen los criterios llamados STOPP/START en los que se sugieren fármacos a retirar/iniciar en función de las patologías del paciente. Los criterios STOPP (Screening Tool of Older Person's potentially inappropriate prescriptions) hacen referencia a fármacos que deberían ser revisados y retirados tales como las benzodiacepinas (respuesta 3 correcta), los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, los anticolinérgicos o los AINEs.

167. Uno de los siguientes componentes NO se considera clave para conseguir la eficacia de los programas de valoración geriátrica integral:

1. Liderazgo clínico.
2. Uso de escalas e instrumentos estandarizados.
3. Plan por objetivos con trabajo en equipo interdisciplinar.
4. Intervención intensa de forma temporal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La valoración geriátrica integral del anciano (funcional, mental, social y biomédica) requiere del uso de escalas e instrumentos estandarizados, así como de un plan por objetivos para seguir por parte de un equipo multidisciplinar y con liderazgo clínico. Sin embargo, la intervención que se realice debe ser permanente y continua, no temporal y transitoria (respuesta 4 correcta).

168. Varón de 58 años, obeso, asintomático, bebedor moderado, que presenta una primera glucemia basal de 153 mg/d con glucosuria negativa. En las semanas siguientes ha tenido otras dos cifras de glucemias basales de 118 y 136 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más apropiada para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus?:

1. Practicar una curva de glucemia con 75 g de glucosa.
2. Reúne ya criterios diagnósticos de diabetes mellitus.
3. Solicitar una determinación de insulinemia basal o péptido C.
4. Solicitar una determinación de hemoglobina glicosilada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy fácil sobre el diagnóstico de diabetes en el paciente asintomático. Como sabéis, para diagnosticarla en una persona asintomática, se necesitan dos resultados de pruebas de screening que cumplan criterios de diabetes (glucemia basal, test de sobrecarga oral de glucosa o HbA1c), las pruebas pueden ser las mismas. En este caso nos dicen que a este paciente se la han hecho tres glucemias basales: 153 mg/dl (cumple criterios de DM), 118 mg/dl (situación de pre-DM) y 136 mg/dl (cumple criterios de DM). Por lo tanto, tenemos dos pruebas de screening positivas, luego ya tenemos el diagnóstico de DM (respuesta 2 verdadera, resto falsas).

169. ¿Cuál de las siguientes neoplasias NO suele asociarse con un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo MEN-1?:

1. Adenoma de hipófisis.
2. Feocromocitoma.
3. Insulinoma.
4. Glucagonoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica sencilla sobre neoplasias endocrinas múltiples. Se responde con la regla mnemotécnica “Uno Para PaPi”. En el MEN-1 se encuentran: hiperplasia paratiroidea, tumores pancreáticos neuroendocrinos (como el insulinoma o glucagonoma), tumores hipofisarios (como la acromegalia). El feocromocitoma no es característico del MEN-1, si no del MEN-2 (respuesta 2 correcta).

170. Mujer de 75 años en tratamiento con sertralina que acude a urgencias por un cuadro confusional. No se evidencian edemas y la tensión arterial es de 130/70 mmHg. En la analítica destaca Na 126 mEq/l y K 4 mEq/l, la natriuria es de 45 mEq/l y se ha descartado la ingesta de diuréticos. ¿De las siguientes cuál es la actitud más correcta?:

1. Se trata de una enfermedad de Addison y deben administrarse corticoides de inmediato.
2. Administrar suero salino hipertónico a fin de restablecer cuanto antes la natremia.
3. Indicar restricción hídrica y si no se eleva la natremia pasar a infusión lenta de suero salino.
4. Solicitar resonancia magnética cerebral, ya que seguramente se trata de una diabetes insípida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que genera dudas, dada la redacción de las opciones. Nos presentan un caso de hiponatremia hiposmolar (no nos dan datos de osmolaridad aumentada o normal), normovolémica (edemas y TA normales), con sodio urinario elevado (45 mEq/L) sin datos sugerentes de etiología alternativa (potomanía, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal). Estamos por tanto ante un SIADH probablemente farmacológico, desencadenado por sertralina (respuestas 1 y 4 falsas). Si bien ante hiponatremia moderada-grave está indicada la administración de bolos puntuales de suero salino hipertónico al 3%, debe vigilarse con cuidado que no se produzca una corrección excesiva de la natremia (6-8 mEq/día, nunca >10 mEq/día), motivo por el cual la respuesta 2 es falsa. Es por ello que, aunque la administración de suero salino puede empeorar algunos casos de SIADH, la respuesta más correcta en este caso sea la 3.

171. Mujer de 38 años que consulta por astenia e hipotensión de seis meses de evolución. Después de una evaluación extensa, en la analítica únicamente destaca cortisol 8 microg/dl (5-25 microg/dl) y ACTH de 240 pg/ml (10-60 pg/ml). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Debe solicitarse test de estimulación con ACTH con la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria.
2. Se trata de un síndrome de resistencia a la ACTH y debe solicitarse consejo genético.
3. Debe descartarse tumor hipofisario secretor de ACTH.

4. Se trata de una secreción ectópica de ACTH y debe buscarse una neoplasia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta relativamente fácil si reconoces el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y conoces su diagnóstico. El cuadro clínico es inespecífico (astenia e hipotensión) pero el enfoque te lleva directamente a una ISR, ya que en el estudio bioquímico sólo te hablan de cortisol y ACTH. Cuando el cortisol basal es <3 mcg/dL, el diagnóstico está confirmado. Un cortisol >18 mcg/dL descarta el diagnóstico. Los valores basales entre 3-18 deben estudiarse con el cortisol estimulado (1h después de estimular con ACTH), confirmándose el diagnóstico de ISR si éste es <18 mcg/dL. En cuanto a la causa de la ISR, los niveles basales elevados de ACTH orientan a un origen 1° (suprarrenal), y por tanto la opción 1 es la correcta.

- 172. En el síndrome de Klinefelter, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:**

1. El tratamiento con testosterona potencia la fertilidad.
2. Los niveles de gonadotrofinas están disminuidos en la mayoría de los pacientes.
3. El cariotipo XO subyace en la mayoría de los casos.
4. La incidencia de lupus eritematoso es mayor que en los varones de la población general.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil que se contesta por descarte. El síndrome de Klinefelter es la anomalía del desarrollo sexual más frecuente y se caracteriza por un cariotipo 47XXY o mosaicismos (respuesta 3 falsa), con lo que el fenotipo más frecuente es el del varón feminizado. Analíticamente cursa con un hipogonadismo hipergonadotropo (respuesta 2 falsa) y el tratamiento es sintomático con testosterona, por lo que la fertilidad no mejora (respuesta 1 falsa). Estos pacientes, además, tienen mayor incidencia de enfermedades autoinmunes que la población general, como alteraciones tiroideas, diabetes o lupus (respuesta 4 correcta).

- 173. Mujer de 37 años, diagnosticada hace tres meses de enfermedad de Graves, en tratamiento con metimazol y propranolol, que consulta por fiebre y deglución dolorosa. En la exploración física tiene temperatura 38,7°C y la orofaringe está eritematosa, sin exudados. ¿Cuál de los siguientes es el manejo más adecuado?:**

1. Iniciar un tratamiento empírico con penicilina V oral.
2. Obtener una prueba rápida de detección de antígenos para el estreptococo del grupo A.
3. Interrumpir el propranolol y obtener un cultivo de orofaringe.
4. Interrumpir el metimazol y obtener un hemograma con recuento diferencial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil por ser un concepto muy concreto sobre el tratamiento de la enfermedad de Graves, pero al mismo tiempo muy típico. El tratamiento con tionamidas tiene un riesgo muy bajo, aunque conocido, de agranulocitosis. Ocurre de forma impredecible, por lo que no es rentable el seguimiento con hemogramas periódicos. Lo indicado es explicar al paciente que si presenta un cuadro pseudogripal (fiebre, artromialgias, odinofagia...) debe acudir inmediatamente a hacerse un hemograma para descartar una agranulocitosis.

- 174. ¿Cuál de los siguientes hallazgos semiológicos en un paciente con herpes zóster NO indica una especial gravedad?:**

1. Presencia de vesículas en el conducto auditivo externo.
2. Afectación multimetamérica.
3. Afectación del ala nasal.
4. Lesiones cutáneas en distintas fases evolutivas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La presencia de lesiones cutáneas en distintas fases evolutivas es característica de las lesiones de herpes zóster y no constituye un criterio de gravedad. En cambio la presencia de lesiones en el conducto auditivo externo, la afectación metamérica y la afectación de la primera rama del trigémino (afectación del ala nasal) sí que son criterios de gravedad, al igual que el zóster en pacientes inmunodeprimidos.

- 175. Paciente de 62 años que consulta por haber estado en contacto cercano en las últimas semanas con una persona con una tuberculosis activa. El Mantoux es positivo (12 mm). Entre sus antecedentes destaca estar en tratamiento con anticoagulantes orales (acenocumarol) por una trombosis venosa profunda hace unos meses. No refiere fiebre ni tos y se encuentra asintomático. La Rx de tórax es normal. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más recomendable?:**

1. Isoniacida, durante nueve meses.
2. Rifampicina, durante cuatro meses.
3. Isoniacida y rifampicina, durante tres meses.
4. Isoniacida y rifapentina, durante tres meses.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta sobre tratamiento de infección tuberculosa latente todas las pautas enumeradas son válidas. Sin embargo, este paciente en concreto está tomando acenocumarol y tanto la rifampicina como la rifapentina presentan una interacción importante con los antivitaminas K, por lo que es preferible usar una pauta que no contenga rifamicinas, de forma que la opción 1 sería la más recomendable para evitar interacciones farmacológicas.

176. Paciente de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes que sufre una neumonía bilateral por SARS-CoV2. Tras recibir oxígeno en gafas nasales, enoxaparina a dosis profilácticas (60 mg/d SC), remdesivir y dexametasona (6 mg/d IV), la evolución clínica no está siendo favorable y en el cuarto día de hospitalización se encuentra taquipneico a 30 rpm, temperatura 38°C y saturación 92 %; comenzando a recibir oxígeno con gafas nasales de alto flujo. Análisis: 12000 leucocitos (75 % neutrófilos), PCR 80 (N<3 mg/L), ferritina 823 (N<350 ng/mL), dímero D 1800 (N<500 ng/mL), procalcitonina 0,45 (N< 0,3 ng/mL). La Rx de tórax muestra una progresión de la neumonía bilateral. ¿Cuál es la actitud terapéutica más recomendable de las siguientes?:

1. Aumentar la dosis de enoxaparina a dosis anticoagulantes (60 mg/12 h SC).
2. Aumentar la dosis de esteroides (metilprednisolona, 80 mg/8 h IV).
3. Añadir tocilizumab.
4. Añadir meropenem.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En este caso clínico nos presentan un paciente con COVID-19 grave que a pesar de haber recibido dexametasona presenta una mala evolución. Esta mala evolución no parece responder a una sobreinfección bacteriana ya que la procalcitonina es inferior a 2 ng/mL y en cambio la PCR y la ferritina están elevadas, lo que sugiere una hiperrespuesta inflamatoria. En esta situación la práctica clínica en este momento es intensificar el tratamiento inmunomodulador, por lo que la respuesta más correcta es añadir tocilizumab, que ha demostrado disminuir la mortalidad en algunos estudios.

177. Paciente de 33 años, residente en Valencia, que consulta por presentar en la mejilla derecha una placa eritemato-anaranjada tras picadura de insecto que ha ido creciendo lentamente hasta alcanzar 1,5 cm y que en las últimas semanas se ha ulcerado y cubierto de una escamocrosta. La lesión solo le origina discretas molestias si se rasca. Entre sus antecedentes destaca psoriasis en placas en tratamiento con adalimumab subcutáneo. Tiene buen estado general y no toma otros fármacos ni refiere alergias a medicamentos. Indique el tratamiento que emplearía:

1. Isotretinoína oral.
2. Antimoniato de meglumina intralesional.
3. Corticosteroides sistémicos.
4. Amoxicilina oral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es esta pregunta nos presentan un paciente inmunodeprimido (recibe anti-TNFalfa por una psoriasis cutánea) que presenta una lesión cutánea ulcerada crónica que aparece tras la picadura de un mosquito. Además el paciente vive en el levante español. Con estos datos tenemos que plantearnos una leishmaniasis cutánea, cuyo tratamiento de elección son los antimoniales intralesionales, por tanto la opción 2.

178. Varón de 48 años que acude a su consulta por estreñimiento crónico resistente a medidas habituales. Además, refiere palpitaciones y en las últimas semanas disnea de medianos esfuerzos. Señale, de las posibilidades que se ofrecen, cual le orientaría más para sospechar un diagnóstico etiológico específico:

1. Realizar un ECG.
2. Realizar un enema opaco.
3. Realizar un ecocardiograma.
4. Preguntar por el país de procedencia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico de un paciente joven que presenta un estreñimiento pertinaz y una clínica de insuficiencia cardíaca. Con esta combinación hay que plantearse una enfermedad de Chagas y por tanto nos va orientar mucho saber el país de procedencia del paciente. Aunque un ecocardiograma sería útil para constatar la causa de la insuficiencia cardíaca, el hallazgo de una cardiopatía dilatada no nos diría nada acerca de la causa de la misma, mientras que saber que el paciente es de Bolivia por ejemplo nos proporcionaría una alta sospecha etiológica.

179. Paciente de 54 años con antecedentes de alcoholismo crónico y deficientes condiciones de vivienda e higiene. Refiere un cuadro clínico de dos semanas de duración de astenia, febrícula y sudoración nocturna. En la Rx y la TC de tórax se observa una lesión única, cavitada, en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, de 4 cm de diámetro, con un nivel hidroaéreo. El estudio microbiológico del esputo es negativo. Decide comenzar con un tratamiento antibiótico empírico. Indique cuál de los siguientes sería el tratamiento MENOS eficaz:

1. Metronidazol IV.
2. Clindamicina IV.
3. La asociación de un betalactámico y betalactamasa IV.
4. Moxifloxacino oral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla en la que la única dificultad puede ser identificar que el paciente presenta un absceso pulmonar, aunque con el dato radiológico de una lesión cavitada con nivel

hidroaéreo no debería haber ninguna duda. El tratamiento empírico del absceso pulmonar debe incluir anaerobios y estreptococos, por lo que metronidazol en monoterapia no sería una buena opción, mientras que tanto clindamicina, como moxifloxacino como amoxicilina-clavulánico podrían ser muy buenas opciones.

180. Mujer de 26 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento con hidroxiquina, que consulta por sensación de debilidad generalizada que se ha instaurado progresivamente en los últimos 15 días. En la exploración física se aprecia palidez cutánea y en la analítica destaca Hb 7,4 gr/dL, Hcto 31 %, VCM 108. ¿Cuál de las siguientes determinaciones será más útil para decidir la actuación?:

1. Haptoglobina.
2. Test de Coombs.
3. Vitamina B12.
4. Anticuerpos antinucleares.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta ampliamente repetida en el MIR. Se trata de una mujer con anemia aguda grave en el contexto de LES. En dicho contexto, y dado el alto riesgo de anemia hemolítica autoinmune asociada al LES, lo más útil para decidir la actitud a corto plazo e instaurar tratamiento cuanto antes es solicitar un test de Coombs (respuesta 2 correcta), y, si es positivo, iniciar tratamiento cuanto antes con corticoides a dosis altas.

181. Varón de 67 años que presenta un cuadro de 3 meses de duración de astenia y febrícula, a la que se añade en el último mes obstrucción nasal con emisión de moco con algunos coágulos. En los últimos días nota dolor en el ojo derecho y asimetría respecto al contralateral. En la exploración física se objetiva proptosis del globo ocular derecho y la inspección de las fosas nasales constata una mucosa eritematosa con costras serohemáticas. El resto de la exploración es normal. Los análisis de sangre (hemograma, función renal y hepática) son normales, a excepción de una VSG de 65 mm/h; en el análisis de orina se detecta microhematuria y proteinuria de 520 mg/24h. ¿Cuál es el diagnóstico inicial más probable?:

1. Granulomatosis eosinofílica con poliangitis.
2. Poliangitis microscópica.
3. Granulomatosis con poliangitis.
4. Poliarteritis nudosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un varón de 67 años con febrícula y reactantes de fase aguda, con afectación de vía respiratoria superior

destruccion (moco con coágulos, costras hemáticas en fosas nasales), microhematuria y proteinuria con proptosis del globo ocular. Todo ello muy sugestivo de granulomatosis con poliangitis (antiguo Wegener).

182. En el síndrome de Sjögren, uno de los factores pronósticos asociados a una peor evolución es:

1. Poliartrosis de grandes y pequeñas articulaciones.
2. Fenómeno de Raynaud.
3. Hepatoesplenomegalia.
4. Crioglobulinemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La complicación más temible del síndrome de Sjögren es la aparición de Linfoma B, fundamentalmente en parótidas, que se debe sospechar ante la aparición de tumefacción parotídea mantenida, hipocomplementemia, crioglobulinemia y aumento beta-2 microglobulinemia o proteínas monoclonales. No se consideran factores de mal pronóstico la poliartrosis, el Raynaud ni la hepatoesplenomegalia.

183. Mujer de 45 años sin antecedentes de interés que consulta por presentar sensación disneica de unos 4 días de evolución. La exploración muestra taquicardia rítmica, sin soplos y la auscultación pulmonar es normal. La gasometría arterial muestra una pO₂ de 70 mmHg y una pCO₂ 32 mmHg. El hemograma, la función renal y hepática son normales. Tiempo de protrombina 90 %, tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) con ratio de 2 respecto al control (N <1,2). ¿De los siguientes diagnósticos cuál es el más probable?:

1. Síndrome antifosfolípido.
2. Factor V de Leiden.
3. Hemofilia.
4. Pericarditis aguda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El síndrome antifosfolípido es una afectación autoinmune que se caracteriza por el desarrollo de trombosis de repetición, complicaciones obstétricas y en ocasiones alteraciones hematológicas. Entre otras alteraciones, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos puede generar una interacción in vitro con los sistemas de determinación de TTPA en el laboratorio (anticoagulante lúpico). La presencia de anticoagulante lúpico supone una prolongación del TTPA in vitro, que no se corrige al añadir plasma normal. A pesar de prolongar el TTPA, la presencia de un anticoagulante lúpico no se asocia a fenómenos hemorrágicos (pues solo prolonga el TTPA in vitro) sino a fenómenos trombóticos. En el caso clínico, al tratarse de una paciente con un tromboembolismo pulmonar y un TTPA alargado, la asociación de TROMBO + PROLONGACIÓN DEL TTPA en el laboratorio nos debe hacer sospechar un síndrome antifosfolípido (respuesta 1 correcta).

184. Mujer de 70 años que refiere desde hace 1 mes dolor y rigidez en cinturas escapular y pelviana, que predomina al levantarse y mejora con la movilización, sin fiebre, cefalea ni afectación del estado general. En la exploración física se observa rigidez y dolor a la movilización de hombros y caderas. La analítica muestra una elevación de la VSG y la proteína C reactiva. ¿Qué diagnóstico es más probable y qué tratamiento prescribiría?:

1. Artritis reumatoide, iniciaría tratamiento con metotrexato.
2. Fibromialgia, iniciaría tratamiento con duloxetina.
3. Polimialgia reumática, iniciaría tratamiento con corticoides.
4. Espondilitis anquilosante, iniciaría tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan una mujer de 70 años con VSG elevada e impotencia de cintura escapular y pelviana, sugestivo de polimialgia reumática. No presenta datos de arteritis de células gigantes (no cefalea, no fiebre, no afectación ocular ni datos de alarma). De las demás respuestas, la artritis reumatoide tendría asociada poliartritis crónica, la fibromialgia dolores musculares sin reactantes de fase aguda, y la espondilitis afectación de entesis o uveítis, que no es el caso.

185. La interconsulta médica en pacientes hospitalizados constituye una actividad habitual entre los especialistas de medicina interna/geriatria, en especial en los servicios quirúrgicos. Indique cuál de las siguientes características NO corresponde al modelo asistencial de interconsulta denominado asistencia compartida:

1. Responsabilidad compartida.
2. Atención a demanda.
3. Atención integral y global.
4. Comunicación fluida entre médicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la medicina hospitalaria se está produciendo un cambio que alcanza su mayor expresión en área quirúrgica, debida a la superespecialización de los diversos especialistas y a la organización de muchos servicios, impidiendo el seguimiento diario de los pacientes por un mismo facultativo. En el modelo de asistencia compartida, se seleccionan pacientes hospitalizados de mayor edad, comorbilidad y complejidad para que sean seguidos de forma conjunta no solo por los facultativos del servicio donde el paciente esté ingresado, sino también por los facultativos del servicio de Medicina Interna o Geriatria, fundamentalmente, con el fin de realizar una atención integral y global y facilitar la comunicación entre los médicos.

186. La obligación moral de actuar en beneficio de los demás es un principio básico de la bioética que se denomina:

1. Autonomía.
2. Beneficencia.
3. No maleficencia.
4. Justicia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Concepto muy preguntado en el MIR. Los principios básicos de la bioética incluyen la autonomía, que establece que los pacientes tienen derecho a decidir lo que ellos entienden por sus intereses y a participar en las decisiones que les atañen; la beneficencia, según el cual el médico debe velar por el mayor interés del paciente; la no maleficencia, que exige que las determinaciones diagnóstico-terapéuticas respeten escrupulosamente el balance riesgo-beneficio y estén avaladas por la evidencia científica; y la justicia, donde se establece la gestión de los recursos en función de la eficiencia y equidad.

187. En relación con el uso de gabapentina como analgésico complementario a los opioides en pacientes con dolor neuropático en cuidados paliativos, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Se inicia con dosis de 100 a 300 mg dos o tres veces al día.
2. La combinación de gabapentina y nortriptilina no es más eficaz que la gabapentina sola.
3. La confusión y la somnolencia son efectos secundarios, en particular en pacientes mayores.
4. Por lo común es eficaz una dosis de 900 a 3.600 mg/día.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los ensayos clínicos realizados demuestran que la asociación de gabapentina y nortriptilina es más eficaz que cualquiera de las dos por separado, por lo que se recomienda su uso en pacientes que presenten una respuesta parcial a gabapentina o a nortriptilina cuando se administran de forma única. La gabapentina se inicia a una dosis de 300 mg cada 24h el primer día, para continuar con 300 mg cada 12h el segundo día y 300 mg cada 8h el tercer día (respuesta 1 verdadera), por lo que la dosis eficaz es de más de 900 mg al día (respuesta 4 verdadera). La confusión y somnolencia aparecen frecuentemente, sobre todo en personas mayores con alteración cognitiva (respuesta 3 verdadera).

188. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de los síntomas que presentan los pacientes con enfermedad crónica avanzada con pronóstico de vida limitada?:

1. Múltiples.
2. Intensos.

3. Estables.
4. Multifactoriales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La enfermedad terminal se caracteriza por presentar numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, por lo que respuesta 3 es falsa, y por tanto, la respuesta correcta.

189. Al cumplimentar el certificado médico de defunción de una persona que ha fallecido como consecuencia de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico tras caída casual en el domicilio, en el apartado I-d (causa inicial o fundamental), deberemos hacer constar que se ha producido por:

1. Parada cardiorrespiratoria por lesión de centros encefálicos.
2. Hemorragia intracraneal por traumatismo craneoencefálico.
3. Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié (Código W01 de CIE-10).
4. No se debe cumplimentar el certificado por tratarse de muerte violenta.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada que introduce el concepto de certificado médico de defunción, documento médico-legal al que prácticamente todo médico se enfrentará a su realización. Es un error común certificar como causa inmediata y también fundamental de muerte la “parada cardiorrespiratoria”, siendo este escenario un desenlace común a varios casos de fracaso multiorgánico. La pregunta hace hincapié en que es importante incidir acerca de un correcto diagnóstico de causa básica de defunción, incluso en sospecha de muerte violenta. En cualquier muerte, incluyendo causa violenta de la defunción, se ha de cumplimentar, siendo mas descriptivos en cuanto a las circunstancias. La opción número 4 fue la que se había dado por correcta por el Ministerio inicialmente, motivo de anulación de la pregunta.

190. Las heridas de disposición paralela y de diferente profundidad, que aparecen en ocasiones en la muñeca del miembro no dominante de una persona como consecuencia de la acción de un arma blanca, son sugestivas de una de las siguientes opciones:

1. Heridas de lucha, producidas por el manejo de arma.
2. Heridas de defensa.
3. Heridas de tanteo (intención autolítica).
4. Heridas autoproducidas con finalidad de simulación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Concepto novedoso de Medicina Legal. Las heridas de tanteo o de vacilación son heridas autoinflingidas, superficiales y paralelas entre sí, que no suponen un riesgo vital en sí mismas. Sin embargo, suelen encontrarse en un alto porcentaje de suicidios consumados con arma blanca, próximas a la herida más profunda y mortal. Esta pregunta se puede sacar por razonamiento, ya que la disposición paralela y que solo aparezcan en el miembro no dominante, nos debe hacer pensar en que han sido autoinflingidas.

191. Varón de 54 años de edad que acude a su centro de salud tras el alta hospitalaria por un infarto agudo de miocardio. Destacan como antecedentes ser fumador de 25 cigarrillos/día desde los 20 años, bebedor habitual de 6 UBE/día y en varios análisis de años anteriores cifras de colesterol total de 247-298 mg/dl, triglicéridos de 150-216 mg/dl, colesterol-HDL de entre 45-52 mg/dl. En sus antecedentes familiares tiene recogidos que sus padres (86 y 83 años) son diabéticos e hipertensos y que sus dos hermanos (58 y 60 años) están sanos, todos sin enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tipo de dislipemia es más probable?:

1. Disbetalipoproteinemia.
2. Hipercolesterolemia familiar heterocigota.
3. Hiperlipemia familiar combinada.
4. Hipercolesterolemia poligénica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Bonita pregunta sobre el diagnóstico diferencial de las dislipemias primarias. Tenemos un paciente con hipercolesterolemia moderada, niveles de triglicéridos normales o mínimamente elevados, ausencia de xantomas, y un patrón de herencia familiar poco evidente, sin familiares de 1º grado claramente afectados entre sus padres y hermanos. Todo ello orienta a una hipercolesterolemia poligénica, que es además la dislipemia 1ª más frecuente. Las cifras límites de triglicéridos pueden hacerte dudar con una hiperlipemia familiar combinada, pero la ausencia de familiares de 1º grado afectados nos la descarta razonablemente.

192. Una vez establecido el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y logrado un control bueno o aceptable, dentro de las actividades periódicas de seguimiento, ¿cuándo hay que solicitar una hemoglobina A1c?:

1. Cada 3 meses.
2. Cada 6 meses.
3. Cada 9 meses.
4. Cada 12 meses.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil, nunca preguntada anteriormente en el MIR, sobre el seguimiento del paciente con diabetes con buen control según las guías. Como explicamos en clase,

en el paciente de reciente diagnóstico o con mal control o en pacientes cuyo tratamiento haya cambiado o requiera ajuste, se recomienda medición de HbA1c trimestralmente. Sin embargo, en pacientes que cumplan con los objetivos de tratamiento y que tengan un control glucémico estable se recomienda medición de HbA1c al menos dos veces al año, es decir, cada 6 meses (respuesta 2 correcta, resto falsas).

193. Según las recomendaciones preventivas cardiovasculares del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS), indique la opción correcta sobre la periodicidad del cribado de hipertensión arterial en personas mayores de 40 años:

1. Se recomienda tomar la presión arterial anualmente.
2. Se recomienda tomar la presión arterial cada dos años.
3. Se recomienda tomar la presión arterial cada tres años.
4. Se recomienda tomar la presión arterial cada cuatro años.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta novedosa por hacer referencia directa a un documento científico de Sociedad española de medicina de familia y comunitaria. En dicho documento se recomienda un cribado de HTA cada 3-5 años, para comenzar a realizarse anualmente en sujetos mayores de 40 años o con algún factor de riesgo para el desarrollo de HTA (sobrepeso-obesidad, TA normal-alta o personas negras).

194. Respecto del síndrome cardiorrenal, señale la afirmación FALSA:

1. Es de causa multifactorial.
2. Se observa galope S1S2 y edemas periférico y pulmonar.
3. Su presencia empeora notablemente el pronóstico y los síntomas de la insuficiencia cardíaca y dificulta su tratamiento.
4. La anemia asociada a la insuficiencia renal puede agravar los síntomas de la insuficiencia cardíaca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta incómoda y atípica sobre el síndrome cardiorrenal. Este síndrome hace referencia a la alteración de la función renal de un individuo por causa cardiogénica (tipos 1 y 2), al desarrollo de insuficiencia cardíaca debido a enfermedad renal (tipos 3 y 4) o a la coexistencia de insuficiencia renal y cardíaca que se explican por una tercera causa (tipo 5). Es opción falsa la 2, porque el galope no es S1 ni S2 (ruidos normales), sino un tercer tono debido a llenado ventricular rápido e insuficiente que en ocasiones se acompañan de cuarto tono (por contracción auricular vigorosa para llenar

un ventrículo disfuncionante desde el punto de vista diastólico). Es igualmente falsa porque el síndrome cardiorrenal no es obligado que presente edemas periféricos ni pulmonar.

195. Mujer de 66 años con diabetes mellitus tipo 2. Valorando su función renal presenta un estadio G3a/A1. ¿A qué valores corresponde este estadio, el más frecuente en pacientes con nefropatía diabética?:

1. Filtrado glomerular 45-59 ml/min/1,73 m² y albuminuria < 30 mg/ml.
2. Filtrado glomerular 30-44 ml/min/1,73 m² y albuminuria < 30 mg/ml.
3. Filtrado glomerular 45-59 ml/min/1,73 m² y albuminuria 30-300 mg/ml.
4. Filtrado glomerular 15-29 ml/min/1,73 m² y albuminuria < 30 mg/ml.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa acerca de los estadios de la insuficiencia renal crónica. El estadio G3a corresponde a un FG 45-59 ml/min, mientras que la albuminuria A1 correspondería a albuminuria <30 mg/día, por lo que la opción correcta es la 1 (respuesta 1 CORRECTA).

196. Mujer de 25 años en estudio por una hepatopatía de origen autoinmune, con importante colestasis. Refiere prurito intenso y aparición de lesiones cutáneas sugestivas de xantomas. Niveles de colesterol total 800 mg/dL con colesterol LDL 395 mg/dL. Indique la respuesta correcta respecto a su enfermedad:

1. Se trata de una hipercolesterolemia secundaria a colestasis.
2. Es imprescindible realizar un test genético para descartar una hipercolesterolemia familiar.
3. Dados los niveles de colesterol total y de colesterol LDL se trata de una hipercolesterolemia familiar homocigota.
4. La eliminación del colesterol es fundamentalmente renal, por lo que hay que excluir una causa primaria de hipercolesterolemia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la colangitis biliar primaria, ya que nos dan todos los datos clave para sospecharla: sexo femenino, joven, hepatopatía "autoinmune", colestasis, xantomas... Recordad que en esta patología se produce típicamente aumento de colesterol, que generalmente no requiere tratamiento, ya que no se ha demostrado un aumento del riesgo cardiovascular en estos pacientes.

197. Varón de 30 años que presenta una insuficiencia respiratoria aguda grave que precisa de

intubación orotraqueal a su llegada a urgencia y traslado a UCI para ventilación mecánica invasiva. Se realiza una radiografía de tórax compatible con un distrés respiratorio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor al caso clínico?:

1. La causa más frecuente es infecciosa.
2. Durante los primeros siete días de evolución se produce normalmente la fase proliferativa.
3. Se caracteriza por un aumento de la distensibilidad del pulmón.
4. La relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno es superior a 300.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pseudo- caso clínico en el que en el propio enunciado nos ofrecen el diagnóstico de presunción: un distrés respiratorio del adulto; solicitándonos la respuesta correcta. De éstas, la opción 1 (la causa más frecuente de distrés es infecciosa) es verdadera. Ya era correcta en la era pre- pandémica, en la que se consideraba que la principal causa de distrés era la sepsis; y posteriormente con mayor motivo aún, pues tras la emergencia de la pandemia SARS-CoV-2, la primera causa de SDRA ha pasado a ser, con mucha diferencia, la neumonía vírica. El resto de las opciones son falsas: durante los primeros siete días ocurre la fase exudativa, posteriormente empieza la proliferativa (opción 2 falsa), el SDRA se caracteriza por una pérdida de distensibilidad pulmonar (opción 3 falsa) y la ratio PaO_2/FiO_2 debe ser < 300 como requisito diagnóstico sine qua non para poder definir un SDRA (opción 4 falsa).

198. Mujer de 35 años, remitida a urgencias por traumatismo craneoencefálico por caída en patinete, sin pérdida de conciencia ni amnesia. En la exploración se trata de un traumatismo craneoencefálico cerrado con conmoción y cefalea leve sin presencia de náuseas y vómitos. La exploración neurológica es normal y presenta un índice de Glasgow de 15. Ante esta situación ¿qué prueba de imagen está indicada en primer lugar?:

1. TC craneal sin contraste.
2. TC craneal con contraste.
3. Ninguna prueba de imagen.
4. Radiografía simple de cráneo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre el manejo del TCE. En pacientes con TCE leve que no tienen criterios de alto riesgo basta con realizar observación sin necesidad de hacer TC.

199. En relación con el soporte hemodinámico en pacientes con shock séptico, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El control hemodinámico inmediato es fundamental para el pronóstico.
2. Deben administrarse fluidos (cristaloides) a razón de 30 ml/kg en la primera hora de atención.
3. Debe administrarse hidrocortisona si tras el primer litro de cristaloides no se ha logrado el control hemodinámico.
4. Debe iniciarse una perfusión con noradrenalina si tras la administración de fluidos no se logra control hemodinámico (tensión arterial media superior a 65 mmHg).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los corticoides en el shock séptico solo se recomiendan en pacientes que a pesar de recibir soporte vasoactivo intensivo siguen presentando una TA media inferior a 65 mmHg, pero nunca antes de un aporte de volumen suficiente y de soporte vasoactivo correcto.

200. Varón de 83 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca que acude a urgencias del centro de salud por un cuadro de disnea de reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas maleolares de 24 horas de evolución. A su llegada el ECG muestra una fibrilación auricular a 126 lpm y se objetiva TA 79/47 mmHg, SatO₂ 89 %, temperatura 36,7°C y frecuencia respiratoria 26 rpm. En la auscultación se aprecian crepitantes bibasales bilaterales. Se administra oxígeno con mascarilla Venturi al 50 %, furosemida 20 mg IV y morfina 2 mg IV. Se le va a trasladar al hospital en un soporte vital avanzado donde se administrará ventilación no invasiva con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP). ¿Cuál es la razón por la que aplicaría la CPAP en este caso?:

1. Incrementa la capacidad residual funcional de sistema respiratorio.
2. Es especialmente eficaz en el paciente con hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco.
3. Produce un aumento de la presión intratorácica que aumenta la precarga cardíaca.
4. Ocasiona un aumento de la presión transmural del ventrículo izquierdo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Bonita pregunta en la que lo primero es constatar que nos encontramos ante una insuficiencia cardíaca descompensada “fría y húmeda” (es decir, con datos de congestión pulmonar junto con hipoperfusión periférica, el estadio IV de la clásica clasificación de Forrester, que define un shock cardiogénico con edema pulmonar). En esta circunstancia, nos preguntan cuál es la razón por la cual aplicaríamos una CPAP a este paciente; en otras palabras, qué beneficio esperaríamos aportar

al paciente con dicha técnica. Seguidamente nos ofrecen un posible beneficio respiratorio (que es correcto: la CPAP mejora la CRF, pues se trata de una maniobra reclutadora, es decir, que logra mantener llenos de aire más alvéolos al final de una espiración normal –que es justo el volumen que define la CRF–, logrando así mejorar la oxigenación sanguínea); y luego tres teóricos beneficios hemodinámicos que son falsos, puesto que la CPAP provoca exactamente lo contrario de lo que expone el enunciado: la CPAP aumenta la presión intratorácica, lo que dificulta el adecuado retorno venoso, reduciendo por tanto la precarga (opción 3 falsa) lo cual a su vez, por la ley de Frank-Starling, disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo (opción 4 falsa), la contractilidad, el gasto cardíaco y la tensión arterial. Por todo ello, es una terapia que debe vigilarse muy estrechamente en el paciente hipotenso y con arritmias, por su potencial deletéreo hemodinámico (opción 2 falsa).

201. Señale de entre los siguientes aquel factor etiológico NO relacionado o implicado en la etiopatogenia de la miocardiopatía por estrés o síndrome de tako-tsubo:

1. Disfunción microvascular.
2. Mayor susceptibilidad de los receptores catecolaminérgicos en el miocardio.
3. Espasmo coronario.
4. Enfermedad coronaria obstructiva significativa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil en el que hay que saber que el diagnóstico de Tako Tsubo pasa por encontrar unas coronarias sin lesiones obstructivas (opción 4).

202. ¿Cuál de estos síntomas NO va a favor de un vértigo de origen central por lesión en el tronco cerebral?:

1. La presencia de hipoacusia y acúfenos acompañando al vértigo.
2. La aparición de diplopia acompañando al vértigo
3. La descripción del vértigo como una sensación de inestabilidad, siendo menos frecuente que sea un vértigo rotatorio
4. Que en la exploración se objetive un nistagmo vertical.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica sobre las diferencias entre un vértigo central y un vértigo periférico. La aparición de un nistagmo vertical o cambiante sugiere centralidad, asimismo la presencia de diplopía o focalidad neurológica. Un vértigo periférico es rotatorio y frecuentemente acompañado de otros síntomas otológicos (acúfenos e hipoacusia), la respuesta correcta es la 1.

203. La distrofia fascioescapulohumeral:

1. Se transmite con carácter autosómico recesivo.
2. Afecta más frecuentemente a mujeres.
3. Afecta al músculo pectoral mayor en estadios precoces.
4. Acorta significativamente la esperanza de vida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que exige conocer el curso clínico de la distrofia facioescapulohumeral; primero se afecta la musculatura facial, posteriormente el deltoides y el pectoral mayor, y en estadios avanzados se puede afectar otra musculatura (miembros inferiores, cadera y cuádriceps, pero suele ser leve y nunca es lo predominante). No se afecta la esperanza de vida.

204. En relación con los aneurismas de aorta abdominal, señale la respuesta FALSA:

1. Está indicada su reparación quirúrgica cuando el diámetro aneurismático supera los 5-5,5 cm de diámetro.
2. Suelen ser asintomáticos y de diagnóstico casual en el transcurso de pruebas de imagen hechas por otros motivos.
3. La complicación más frecuente es la trombosis aneurismática.
4. En caso de rotura está indicado el tratamiento quirúrgico urgente mediante cirugía abierta o endovascular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada en un tema de moda en el MIR. La opción 3 es falsa, pues la trombosis a este nivel es rara y la complicación más frecuente es la ruptura aneurismática (recuerda que es el riesgo de ruptura estimado por el diámetro el que marca la indicación intervencionista).

205. Varón de 61 años, fumador e hipertenso, que acude a urgencias por pérdida súbita de fuerza y sensación de hormigueo en la mano derecha de unos 15 minutos de duración, con recuperación posterior casi completa. ECG: ritmo sinusal a 93 lpm. En relación con el diagnóstico más probable, señale la respuesta FALSA:

1. Una causa probable es una embolia arterioarterial por desprendimiento de una placa carotídea.
2. El ecografía-doppler de troncos supraaórticos es poco útil para el diagnóstico.
3. Es necesario realizar una TC craneal para evaluar la repercusión sobre el parénquima cerebral.
4. El tratamiento quirúrgico está indicado si las pruebas de imagen revelan una estenosis carotídea >70%.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El paciente ha sufrido un AIT o un ictus (clínica deficitaria focal de instauración brusca y resolución CASI completa; si los síntomas duran más de >24h y/o deja alteración en neuroimagen lo catalogamos de ictus, como vemos es una definición algo arbitraria). Tiene un fenotipo “ateromatoso” (varón fumador e hipertenso), por lo que la opción 1 es correcta (además en el ECG está en ritmo sinusal). Por supuesto que hay que realizar un TC craneal (opción 3 correcta). El doppler es una técnica muy útil en el estudio del ictus, permitiendo definir un origen aterotrombótico si se halla una estenosis de >50% de una arteria que lleve sangre al territorio afectado (opción 2 falsa y por tanto la que hay que marcar). En el caso de ser la carótida, si la estenosis es >70% (en las guías de práctica clínica de Cardiología este porcentaje es el 60%), dado que es sintomática en este caso, hay que abrir la arteria (opción 4 correcta).

206. Ante un derrame pleural derecho con los siguientes parámetros: pH 7,49; proteínas en líquido pleural 3,8 g/dl; LDH en líquido pleural 360 UI/L; proteínas en suero 5,9 g/dl; LDH en suero 210 UI/L. Podemos afirmar que nos encontramos ante un:

1. Derrame pleural tipo trasudado, por tanto es necesario tratar la causa subyacente.
2. Derrame pleural tipo exudado, probablemente secundario a insuficiencia cardíaca.
3. Derrame pleural tipo exudado del que se debe investigar la causa.
4. Los valores medidos no son creíbles y se requiere la toma de una nueva muestra.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre los criterios de Light en el estudio diagnóstico de un derrame pleural: se cumple que el cociente LDH líquido pleural/ LDH sérica > 0.66 y que el cociente Proteínas en líquido pleural/ Proteínas séricas > 0.5; por lo que cumple al menos dos criterios de Light, luego no hay duda de que se trata de un exudado pleural (opción 1 falsa). Los exudados suponen la expresión clínica de un proceso inflamatorio pleural (sea de naturaleza infecciosa, tumoral o inmuno-mediado) caracterizado por el aumento de permeabilidad capilar, con fuga de líquido rico en células inflamatorias y proteínas (pudiendo presentar LDH más elevada en líquido pleural que en suero –opción 3 4 falsa), y cuya etiología debe investigarse siempre correlacionando la historia clínica, los hallazgos físicos, la radiología y los estudios bioquímicos y anatomopatológicos (opción 3 correcta). Por el contrario, el derrame pleural de la insuficiencia cardíaca ocurre por aumento de la presión hidrostática, típicamente sin inflamación pleural, por lo que el líquido es de carácter trasudativo (opción 2 falsa).

207. En una crisis de asma bronquial, en la fase inicial la gasometría arterial suele mostrar:

1. pH y PaCO₂ normales con descenso de la PaO₂.
2. PaO₂ normal con descenso de la PaCO₂ y aumento del pH.
3. Disminución de la PaCO₂ y la PaO₂ con aumento del pH.
4. Aumento de la PaCO₂ con descenso de la PaO₂ y del pH.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

En una crisis asmática en la fase inicial esperaríamos encontrar los efectos de la taquipnea, pero con un intercambio gaseoso bien preservado, es decir, hipocapnia y normoxemia (opción 2 verdadera, opciones 1 y 4 falsas). Considerando que en general la función alveolar en los asmáticos está correctamente preservada, la aparición de trastornos del intercambio gaseoso (es decir, hipoxemia +/- hipercapnia) se debe atribuir a hipoventilación alveolar; lo cual acaba ocurriendo en una fase tardía (opción 3 falsa) y de mucha mayor gravedad, cuando la capacidad vital forzada del paciente disminuye de forma relevante (lo cual a su vez se debe al aumento del volumen residual secundario al atrapamiento aéreo, fenómeno típicamente obstructivo).

208. Varón de 53 años sin antecedentes de interés que tras un mal movimiento en el gimnasio nota un dolor lumbar que al pasar las horas se irradia hacia la pierna derecha por la parte posterior y llega al borde lateral del pie. Presenta en la exploración maniobra de Lasègue positiva a 40°, reflejo aquileo abolido y no se puede poner de puntillas. El diagnóstico etiológico más probable es:

1. Hernia discal L2-L3 derecha.
2. Hernia discal L3-L4 derecha.
3. Hernia discal L4-L5 derecha.
4. Hernia discal L5-S1 derecha.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta fácil y muy repetida en el MIR. Nos describen una radiculopatía S1: dolor irradiado por muslo posterior, pantorrilla, planta y 5º dedo del pie, asociado a debilidad de gemelos y reflejo aquileo abolido. Recordad que, a nivel lumbar, las hernias discales suelen provocar la radiculopatía de la vértebra de abajo, es decir, una hernia discal L5-S1 provocará una radiculopatía S1.

209. En la endoscopia oral de un paciente con pirosis de larga evolución se aprecia una mucosa rosada ascendente en llamas, sin erosiones ni úlceras. Se toman biopsias esofágicas que demuestran la presencia de epitelio metaplásico, con 34 eosinófilos por campo y sin displasia. El diagnóstico más probable es:

1. Esófago de Barrett.
2. Esofagitis eosinofílica.

3. Enfermedad por reflujo gastro-esofágico no erosiva.
4. Esofagitis grado B de Los Ángeles.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto muy preguntado en el MIR: el esófago de Barrett. Nos presentan un paciente con pirosis de larga evolución (principal factor de riesgo). Siempre se describe igual: una mucosa asalmonada/rosada que asciende por el esófago con longitud variable. Recordad que el diagnóstico requiere de biopsias para confirmar la metaplasia intestinal. El resto de opciones se descartan fácilmente: en la esofagitis eosinofílica debe haber más de 15 eosinófilos y los hallazgos son completamente distintos, en la esofagitis grado B debería haber erosiones y en la ERGE no erosiva la endoscopia debería ser normal.

210. Señale cuál de las siguientes NO es una manifestación usual de las metástasis leptomeníneas de los carcinomas:

1. Radiculopatía cervical.
2. Hemiparesia.
3. Neuropatía de pares craneales.
4. Encefalopatía por hidrocefalia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que exige razonamiento para responderla. Dado que se trata de una afectación meníngea, no suele haber síntomas secundarios a una lesión parenquimatosa: hemiparesia, hemihipoestesia, heminegligencia, afasia, etc.

